

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Sistema de Información para la Gestión de Garantías en Salud **SIGGES**

4ª Versión

MARZO 2009



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Redes Asistenciales
División de Integración de Redes

DIVISIÓN DE INTEGRACION DE REDES - DIREC
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINSAL

Elaborado por:
Beatriz Heyermann Gajardo
Eliaana Barraza Courtois

PARTICIPARON EN LA REVISIÓN 2008:

Consuelo Navarro - Unidad de Coordinación de Servicios de Salud y Puesta en Marcha
Fernanda Gonzalez – Unidad de Coordinación de Servicios de Salud y Puesta en Marcha
Hsiao-Lan Sung – División de Gestión de la Red Asistencial
Sonia Torrealba – División de Gestión de la Red Asistencial
Marcela Lobos - División de Gestión de la Red Asistencial
Karen Muñoz - División de Gestión de la Red Asistencial
Nancy Dawson - División de Gestión de la Red Asistencial
Sidia Matus DIREC
Ana María Merello - División de Gestión de la Red Asistencial
Nelly Contreras - División de Gestión de la Red Asistencial
Danuta Rajs - Departamento de Estadísticas e Información de Salud
Claudio Acuña - Departamento de Estadísticas e Información de Salud
Ania Rojas - Servicio de Salud Coquimbo
Alexandra Torres - Servicio de Salud Concepción
Kareen Schiappacasse - Servicio de Salud Valparaíso San Antonio

PRESENTACION

La implantación del GES en las redes de atención del sector público ha significado un cambio en el actuar en cada uno de los puntos de atención de nuestros establecimientos, ubicando al usuario como el centro de nuestro quehacer diario. Para ello los establecimientos debieron reformular sus procesos de atención de las personas de modo de darles a los usuarios todas las garantías tanto de acceso como de oportunidad en las atenciones que ellos requerían.

Para facilitar el seguimiento del GES en los establecimientos del sector público, el año 2005 se formuló una herramienta tecnológica EL SIGGES*, Sistema de Información de apoyo a la Gestión de las Garantías Explícitas de Salud con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las garantías de oportunidad establecidas por los Decretos GES, que sirviera de apoyo a la gestión local de los procesos del ciclo de la atención curativa de las personas y de generación secundaria de información, para la gestión sanitaria en los ámbitos subregional, regional y central, tanto de prestadores como el seguro público (FONASA).

Este manual de procedimientos contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de las unidades de gestión de los usuarios en cada uno de los niveles de atención de las redes públicas, destacando en especial los cuidados en el manejo de la información y el registro de éstas en los sistemas de información locales y su posterior transcripción al SIGGES de modo de apoyar y mejorar la atención de las personas afectas a un problema de salud GES:

Esperamos que esta nueva versión, que contiene los aprendizajes de estos cuatro años de trabajo, sea una herramienta práctica que facilite las acciones en los establecimientos de nuestro sector.



Dr. Julio Montt Vidal
Subsecretario de Redes Asistenciales

* Sistema de Información para Gestión de Garantías Explícitas en Salud

Índice

INTRODUCCIÓN	9
Siglas y Abreviaturas	11
CAPITULO I	13
GESTACIÓN DEL SIGGES	13
I. El Régimen de Garantías Explícitas en Salud GES	13
II. Proceso de Atención	16
III. El Sistema de Información de Apoyo al GES-SIGGES	18
IV. Responsabilidad de los Funcionarios que Participan en el Sistema	18
V. Funcionarios que Intervienen en el Proceso de Atención	22
VI. Responsabilidades de los centros en la derivación	22
VII. Material de Documentación Necesario para la Atención de los Pacientes	23
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO	25
I. Definición Caso AUGÉ	25
II. Creación de casos AUGÉ	25
III. Cierre de Caso	26
IV. Excepciones de Garantías	28
V. Regla de asignación del Caso a un establecimiento en el SIGGES	30
ESTADOS DEL PACIENTE EN EL CICLO DE ATENCIÓN	31
SITUACIONES DE EXCEPCIÓN	33
I. Casos que no presentan los estados de sospecha ni de proceso diagnóstico:	33
II. Casos que no tienen seguimiento, sino que continúan en estado de tratamiento hasta el cierre:	34
III. Casos que presentan otros estados además de los mencionados:	35
IV. Casos con etapas pre-natales:	35
V. Problema de salud que no crea casos	35
Garantías de oportunidad para los pacientes auge en el sigges	36
I. Datos del Paciente en el SIGGES	37
Descripción sumaria del proceso de atención del paciente	39

CAPITULO II	41
Trámite administrativo – some	41
I. Inscripción de un Paciente Nuevo	41
II. Concurrencia a la citación	43
III. Paso por Recaudación (Sistema Actual)	44
IV. Traslado a otro Consultorio	45
ATENCIONES DE SALUD – UNIDAD CLÍNICA	45
I. Unidades de atención de salud	45
II. Atención de Auxiliar Clínico	46
III. Consulta Profesional por un Problema de Salud Determinado	46
IV. Solicitud de Interconsulta o Derivación	52
V. Orden de Atención	55
VI. Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento	57
Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el sigges	59
Excepción de prestaciones y garantías.	60
 CAPITULO III	 63
Trámite administrativo habitual	63
I. Atención del Paciente Derivado	63
Atenciones de salud	66
I. Unidades de atención de salud	66
II. Atención de pacientes por la especialidad	66
III. Consultas siguientes por el mismo problema de salud	68
IV. ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AUGE	69
V. Seguimiento	71
VI. Reingresos	72
VII. Solicitud de Interconsulta o Derivación	72
VIII. Orden de Atención	75
IX. Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento	77
Excepción de prestaciones y garantías	77
Ingreso de los datos al sigges	78
I. Será obligación del SOME de especialidad:	78
II. Será obligación del SOME del establecimiento que efectuó las prestaciones:	79
Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el sigges	79
 CAPITULO IV	 81
Unidades de atención de salud	81
Atención profesional de pacientes hospitalizados	81
I. Detección de Caso nuevo AUGE	81

II.	Paciente con un problema de salud AUGÉ que es hospitalizado:	82
III.	Solicitud de Interconsulta o Derivación	85
IV.	Orden de Atención	86
V.	Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento	88
	Excepción de prestaciones y garantías	88
	Ingreso de los datos de pacientes hospitalizados	89
	Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el sigges	90
	 CAPITULO V	 93
	 Los servicios de urgencia	 93
I.	Ingreso de Pacientes a Servicios de Urgencia	93
II.	Paso por Recaudación	95
III.	Atención por Auxiliar Clínico	95
IV.	Atención Profesional Servicio de Urgencia	95
V.	Archivo e Ingreso de Datos	97
VI.	Formulario de Registro de la atención de Urgencia (DAU)	97
VII.	Formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación	108
VIII.	Orden de Atención	109
IX.	Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento	111
	Excepción de prestaciones y garantías	111
	Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el sigges	112
	 CAPITULO VI	 115
	 Salidas del sigges y su aplicación	 115
	Salidas del sigges relacionadas a la verificación del registro.	116
	Salidas del sigges para el monitoreo de casos y garantías ges	117
	Salidas relacionadas a prestaciones y al proceso de facturación.	118
	 CAPITULO VII	 119
	ANEXO 1	121
	ANEXO 2	138
	ANEXO 3	141
	ANEXO 4	147
	ANEXO 5	151
	 BIBLIOGRAFÍA	 159

Introducción

El presente manual tiene por objeto apoyar al personal de los distintos establecimientos de salud del país para el uso y aplicación adecuados del Sistema de Información para la Gestión de Garantías en Salud (SIGGES).

Con el objeto de facilitar la consulta por cada nivel de atención, el manual contempla en primer lugar generalidades (CAPITULO I) todos los niveles de atención, y en seguida los procedimientos, separados en Atención Primaria (CAPITULO II) , Atención de Especialidades (CAPITULO III) , Atención Cerrada (CAPITULO IV) y Servicios de Urgencia (CAPITULO V). De este modo un establecimiento de Atención primaria puede revisar solo el capítulo correspondiente a ese nivel sin necesidad de revisar a profundidad lo concerniente a los servicios de urgencia o Atención cerrada. El CAPITULO VI incluye una descripción general de las salidas del SIGGES y sus usos

Se incluye en Anexos (CAPITULO VII) diversa información que puede apoyar el trabajo.

Esta cuarta versión recoge las observaciones e instrucciones emanadas durante estos cuatro años de implementación.

Siglas y abreviaturas

APS	Atención Primaria de Salud
CONASIDA	Comisión Nacional del SIDA
DAU	Datos de Atención de Urgencia
DEIS	Departamento de Estadísticas e Información de Salud (MINSAL)
FONASA	Fondo Nacional de Salud
GES	Garantías Explícitas en Salud
HTA	Hipertensión Arterial
IAM	Infarto Agudo al Miocardio
IPD	Informe Proceso Diagnóstico
IRA	Infección Respiratoria Aguda
ISAPRE	Institución de Salud Previsional
MINSAL	Ministerio de Salud de Chile
OA	Orden de Atención
RUN	Rol Único Nacional
SAPU	Servicio de Atención Primaria de Urgencia
SIC	Solicitud de Interconsulta o Derivación
SIGGES	Sistema de Información para la Gestión de Garantías en Salud
SOME	Sección de Orientación Médica y Estadística

CAPITULO I

Generalidades

- *Gestión del SIGGES.*
- *Normas Generales para la organización y funcionamiento del Sistema.*
- *Descripción General del Sistema.*
- *Estados del Paciente en el Ciclo de la Atención.*
- *Casos de Excepción.*
- *Garantías de Oportunidad para los Pacientes AUGE.*
- *Datos del Paciente en el SIGGES.*
- *Descripción Sumaria del Proceso de Atención del Paciente.*

Gestión del SIGGES

13

I. El Régimen de Garantías Explícitas en Salud GES

Considerando que nuestro país vive un proceso de transformación del perfil de enfermedades que afectan a la población, como consecuencia de su progresivo envejecimiento, del cambio de hábitos de vida y de las condiciones de trabajo, el Gobierno de Chile ha reorientado las políticas públicas en salud.

Con este objeto, la Ley 19.966 del 3 de septiembre de 2004 estableció el Régimen General de Garantías en Salud y determinó que ese régimen contendría, además, Garantías Explícitas en Salud relativas al acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud.

Hasta la fecha se han establecido tres decretos llegando a cubrir la totalidad de 56 problemas de salud. El primer decreto correspondió al Decreto Supremo N° 170 del 28/01/2005, y comprendió las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios del Sector Salud, respecto a 25 problemas de salud específicos. El segundo Decreto Supremo n° 228 publicado el 30 de Enero del 2006 entró en vigencia el 1° de Julio del 2006 y estableció las garantías de los cuarenta problemas de salud Ges para el periodo 2006 -2007. Finalmente el tercer Decreto Supremo n° 44, publicado el 09 de Enero del 2007 y que entró en vigencia el 1 de Julio del 2007, establece las garantías y prestaciones correspondientes a los 56 problemas de salud vigentes hasta hoy. Este fue modificado a través del Decreto Supremo n° 69, publicado 28 de Febrero del 2007, el cual se encuentra vigente hasta hoy.

Los 56 problemas de salud son los siguientes

1. Insuficiencia Renal Crónica Terminal
2. Cardiopatías congénitas operables en menores de 15 años
3. Cáncer Cervicouterino
4. Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos
5. Infarto Agudo del Miocardio
6. Diabetes Mellitus Tipo 1
7. Diabetes Mellitus Tipo 2
8. Cáncer de mama en personas de 15 años y más
9. Disrafias Espinales
10. . Tratamiento Quirúrgico de Escoliosis en menores de 25 años
11. Tratamiento Quirúrgico de cataratas
12. Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años o más con artrosis de cadera con limitación funcional severa
13. Fisura Labiopalatina
14. Cáncer en menores de 15 años: leucemia, linfoma y tumores sólidos.
15. Esquizofrenia.
16. Cáncer de Testículo en personas de 15 años y más
17. Linfomas en personas de 15 años y más
18. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
19. IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años
20. Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más
21. Hipertensión Arterial Esencial en personas de 15 años o más
22. Epilepsia No Refractaria
23. Salud Oral Integral para niños de 6 años
24. Prematurez
25. Trastornos de Generación de Impulso y Conducción en personas de 15 años y más que Requieren Marcapaso
26. Colectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en Personas de 35 a 49 años, sintomáticos.
27. Cáncer Gástrico.
28. Cáncer de Próstata en Personas de 15 años y más.
29. Vicios de Refracción de Personas de 65 años y más.
30. Estrabismo en Menores de 9 años.
31. Retinopatía Diabética.
32. Desprendimiento de Retina Regmatógeno no Traumático.
33. Hemofilia.
34. Depresión en Personas de 15 Años y más.
35. Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en Personas Sintomáticos.
36. Órtesis (o Ayudas Técnicas) para Personas de 65 Años y más.
37. Accidente Cerebrovascular Isquémico en Personas de 15 años y más.
38. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de Tratamiento Ambulatorio.

39. Asma Bronquial Moderada y Severa en Menores de 15 años.
40. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido
41. Tratamiento Médico en personas de 55 años y más con Artrosis de Cadera y/o rodilla, Leve o Moderada
42. Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de Aneurismas Cerebrales
43. Tratamiento quirúrgico de Tumores Primarios del Sistema Nervioso Central en personas de 15 años o más.
44. Tratamiento quirúrgico de Hernia Núcleo Pulposo Lumbar
45. Leucemia en personas de 15 años y más.
46. Urgencia Odontológica ambulatoria
47. Salud Oral integral del adulto de 60 años
48. Politraumatizado Grave
49. Atención de urgencia del Traumatismo Craneoencefálico Moderado o Grave
50. Trauma Ocular Grave
51. Fibrosis Quística
52. Artritis Reumatoide
53. Consumo Perjudicial o Dependencia De Riesgo Bajo a Moderado de Alcohol y Drogas en Personas Menores de 20 Años
54. Analgesia del Parto
55. Gran Quemado
56. Hipoacusia Bilateral en personas de 65 años y más que requieren Uso de Audífono

Cabe destacar que a partir del 1 de enero del año 2008, en el sistema público y para los beneficiarios del FONASA se inicia el piloto que incorpora siete patologías más a las 56 ya existentes. Estas últimas no tienen obligación legal mientras no se modifique la actual ley del AUGE. Durante el año 2009 y a partir del año 2010 se incorporarán 5 más.

Las doce patologías son:

- ☐ Enfermedad de Gaucher
- ☐ Tratamiento quirúrgico de Hernias abdominales en personas de 15 años y más
- ☐ Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más
- ☐ Asma bronquial en personas de 15 años y más
- ☐ Enfermedad de Parkinson
- ☐ Artritis Idiopática Juvenil
- ☐ Prevención secundaria de insuficiencia renal terminal
- ☐ Displasia Luxante de Caderas
- ☐ Atención odontológica integral de la embarazada
- ☐ Esclerosis múltiple remitente recurrente
- ☐ Hepatitis B
- ☐ Hepatitis C

II. Proceso de Atención

A. Ingreso por establecimiento de la red pública de salud:

En el caso de los pacientes que son atendidos en el sistema Público, en el momento en que el profesional tratante del establecimiento de Atención correspondiente detecta que la persona tiene un problema de salud GES, debe verificar si este cumple con los criterios de inclusión definidos para cada problema de salud en el decreto vigente y tomando en cuenta los criterios clínicos establecidos en las guías clínicas.

El Decreto N° 44, establece en el artículo 5 lo siguiente:

Artículo 5°. Para que los beneficiarios tengan derecho a las Garantías establecidas en este decreto, será necesario que cumplan los siguientes requisitos o condiciones:

1. Que se trate de un problema de salud incluido en el artículo 1° de este decreto
2. Que el beneficiario sea de aquellos a quienes dicho artículo 1° haya considerado para el acceso a las prestaciones de la patología que se trate
3. Que se sospeche o confirme el diagnóstico de uno o más de los problemas de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, por el profesional que corresponda en la Red de Prestadores.
"...."
4. Que las prestaciones se otorguen en la Red de Prestadores, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11, y
5. Que se trate de las prestaciones incluidas el mencionado artículo 1°, y que hayan sido debidamente prescritas por el profesional que corresponda. Tratándose de la sospecha de un problema de salud que incluya una prestación asociada a esa etapa, el beneficiario tendrá derecho a la(s) garantía(s) de la sospecha y siempre que el problema de salud incluya una prestación asociada a esta etapa, el beneficiario tendrá derecho a las garantías correspondientes tanto si se confirma la sospecha como si se descarta

Si el paciente cumple con los requisitos el profesional le notifica que se trata de un problema GES y le informa sus derechos¹. Dependiendo del problema de salud y de la capacidad resolutive del centro donde se hizo la pesquisa el paciente puede ser atendido en el mismo establecimiento o derivado al centro que cuente con la capacidad resolutive adecuada según las definiciones. Si el paciente es beneficiario de ISAPRE en ese momento se le debe entregar la constancia firmada para que gestione ante su ISAPRE el reconocimiento del problema de salud en su red.

1 Dependiendo del problema de salud y las definiciones de la red, es en ese momento o en una consulta posterior en que se le entrega al paciente la constancia de que se trata de un problema de salud GES. La ley 19.966 establece en el artículo 24 que es deber del prestador informar al paciente. La superintendencia de salud estableció que esta notificación debe hacerse al momento de la confirmación del problema de salud, debiendo entregarle al paciente una copia del formulario firmado por el representante del prestador y por el usuario o su representante. La copia de este formulario debe archivar en la ficha clínica. Ordinario MINSAL C26 N° 1980 del 12 de Junio del 2008

Dependiendo del problema de salud y de la etapa del proceso de atención en que se encuentre el paciente, el profesional de salud además de documentar el hecho en la Historia Clínica, completa el formulario o documento en el cual se explicita la sospecha (Solicitud de Interconsulta, Hoja Diaria de Atención en el caso de la APS, DAU (Dato de Atención de Urgencia) en el caso de la atención de Urgencia), o la confirmación (informe de Proceso Diagnóstico, Hoja Diaria de Atención para la APS o DAU en la Urgencia) del problema de salud que corresponde.

Según el problema de salud del paciente y la etapa del proceso, el profesional indica los procedimientos diagnósticos o terapéuticos necesarios, para lo cual completa las Órdenes de Atención (órdenes de exámenes, recetas, órdenes de tratamiento) necesarias. En aquellos casos en que el profesional determine que el paciente presenta contraindicación para la realización de un examen o tratamiento que está garantizado, se deberá explicitar este hecho como una Excepción de la Garantía correspondiente. Esto podrá documentarse en la Historia Clínica o en un Formulario que el establecimiento haya determinado para este fin.

Una vez que se haya terminado el proceso de atención completo, el profesional debe informar al paciente sobre el cierre de su caso GES. Ese momento se documenta en un formulario ad - hoc llamado "Formulario de Cierre de Caso". Este no debe ser utilizado en las etapas intermedias en que el paciente es derivado desde un establecimiento a otro para ser atendido por diferentes equipos profesionales.

B. Ingreso desde un prestador privado

En aquellos casos en que un Beneficiario de FONASA es evaluado por un profesional de un prestador privado, este debe generar el informe de constancia de la existencia de un problema de salud GES, para que la persona asista a un establecimiento de la red pública desde donde se iniciará el proceso de atención del problema de salud GES correspondiente.

La puerta de entrada a la red pública es la Atención Primaria, (o los servicios de urgencia en aquellos problemas de salud que lo requieren) por lo que la persona deberá acudir al establecimiento de Atención Primaria que le corresponde con el formulario de constancia y es el profesional de ese centro el que determina finalmente si la persona cumple con los criterios de inclusión clínicos y administrativos definidos para el problema de salud correspondiente.

En caso de tratarse de una persona que sea atendida en un servicio de urgencia privada o bien, que estando hospitalizada en un prestador privado, se determina que presenta un problema de salud GES, el profesional tratante debe completar el formulario de constancia para este sea presentado ante el FONASA, para que se reconozca la condición GES y que se implementen los mecanismos necesarios para trasladar al paciente a un establecimiento de la red pública.

III. El Sistema de Información de Apoyo al GES-SIGGES

El “SIGGES”, sistema de información del FONASA, surgió como una herramienta que, a la vez que permita monitorear el cumplimiento de las garantías de oportunidad establecidas por el Decreto GES vigente, sirva de apoyo a la gestión local de los procesos del ciclo de la atención curativa de las personas y entregue generación secundaria de información para la gestión sanitaria en los ámbitos subregional, regional y central.

Este sistema permite el seguimiento de cada una de las personas, que solicitan atención y cumplen con los criterios de inclusión del GES, a lo largo de todo el ciclo de atención curativa, disponiendo por lo tanto de información individualizada que permitirá mejorar la atención de cada individuo en particular sin dejar de vista la mirada sanitaria integral.

Con este objeto, se desarrolló un sistema computacional que funciona en red, donde se capturan los datos de los pacientes y sus atenciones², y que permite monitorear el cumplimiento de garantías, a través de consultas e informes.

El SIGGES se alimenta de datos que provienen fundamentalmente de formularios diseñados para este objeto, aunque en algunos casos se ha considerado más eficiente el uso de los formularios locales por parte de cada establecimiento.

Se han establecido procedimientos uniformes para la captura, registro e ingreso de datos, materia que se aborda en este manual.

Normas Generales para la Organización y Funcionamiento del Sistema

IV. Responsabilidad de los Funcionarios que Participan en el Sistema

A. Responsabilidades del SOME – Admisión - Estadísticas del establecimiento:

- ☐ Velar por el cumplimiento de los procedimientos internos, para lograr el adecuado funcionamiento del Sistema de Información de Salud.
- ☐ Administrar los registros para la dación de horas, las citaciones a procedimientos, exámenes y demás atenciones, la referencia y la contrarreferencia de pacientes, coordinándose permanentemente con las áreas funcionales del establecimiento, para la gestión de la disponibilidad de horas, camas o

2 Esto se puede producir ya sea a través de registro directo en el sistema SIGGES, o bien a través de la captura por parte del SIGGES a través de una interfaz, de la información registrada en los sistemas informáticos locales.

cupos para la atención, con sus contrapartes de la red asistencial el territorio y comunicándose con la población a cargo.

- ❑ Admitir a los pacientes para atención abierta o cerrada, generando todos los registros y las verificaciones relacionados con este proceso y realizar la apertura de la historia clínica cuando corresponda
- ❑ Realizar el registro de las prestaciones otorgadas a las personas atendidas (o los resúmenes semanales y mensuales de atenciones, en caso de no disponer de sistema de información automatizado)
- ❑ Registrar diariamente las prestaciones trazadoras realizadas a los pacientes AUGE.
- ❑ Ingresar, al sistema SIGGES o a los sistemas locales en el caso de realizarse transferencia a través de interfaz, los formularios de Solicitud Interconsulta o Derivación, Informe Proceso Diagnóstico, Cierre de Caso y Creación de caso, que se hayan recibido en el día, en la medida de lo posible, evitando la acumulación de información.
- ❑ Emitir documentos relacionados con, o resultantes de, la atención individual de pacientes (comprobantes, órdenes de atención, certificados, licencias médicas, etc.) a través del Sistema de Información del establecimiento.
- ❑ Establecer y mantener un procedimiento para verificar las causales de inasistencia de los usuarios a las atenciones citadas que sean de su ámbito de responsabilidad, y actualizar esta información en los sistemas de información correspondientes (SIGGES o Sistema Local)
- ❑ Custodiar y conservar las historias clínicas mediante métodos apropiados de archivo y distribuirlas para su uso en la atención de pacientes;
- ❑ Mantener actualizado el Índice Alfabético Centralizado de Pacientes o la base de datos que cumpla esta función.
- ❑ Colaborar con el Encargado de Procesos, Encargado GES y Los jefes de Servicios Clínicos para el cumplimiento de las garantías de oportunidad.
- ❑ Revisar en conjunto con el Encargado de Procesos del Establecimiento los casos AUGE ingresados, con y sin citación, verificando el cumplimiento con las garantías de oportunidad.
- ❑ Difundir y distribuir a las distintas áreas funcionales del establecimiento la información generada por el Sistema Nacional de Estadísticas e Información de Salud;
- ❑ Coordinarse permanentemente con el Departamento de Administración de la Información de Salud (o de Estadísticas e Información de Salud) del Servicio de Salud para la mantención de los registros y de la calidad de la información y someterse a supervisión por parte del mismo;
- ❑ Establecer la coordinación necesaria y permanente con la Unidad encargada de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (o de Informática), para la óptima mantención de los Sistemas de Información, en cuanto a su integridad, seguridad y funcionamiento.
- ❑ Evaluar permanentemente la calidad de los registros, según las normativas nacionales y locales vigentes al respecto, en especial, en relación con la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud y otras nomenclaturas y clasificaciones que rijan en el Sistema de Información;
- ❑ Apoyar a las áreas funcionales clínicas y directivas en métodos y técnicas de investigación clínica y epidemiológica local y en el acceso a la información necesaria para estos fines.

B. Responsabilidades del profesional que brinda la atención de salud:

- ❑ Registrar los datos de la atención en la Historia Clínica e Informe Diario de Actividades. Esto incluye el registro de las inasistencias a las atenciones citadas.
- ❑ Llenar la Solicitud de Interconsulta o Derivación, en los casos que proceda, en particular los Datos Clínicos.
- ❑ Reconocer cuando se trata de un problema de salud AUGÉ y, en ese caso y si se trata de un beneficiario de FONASA, efectuar los registros correspondientes, anotando la hipótesis diagnóstica y el problema de salud AUGÉ de que se trata.
- ❑ En el caso de un problema de salud AUGÉ, el profesional debe informar al usuario, entregándole copia de la constancia correspondiente, previamente firmada por él³. La copia correspondiente al establecimiento debe ser archivada en la ficha o en el registro establecido en el establecimiento para este propósito. El profesional responsable de informar esta condición al usuario será definido según el tipo de problema de salud, correspondiendo los problemas que deben resolverse principalmente en APS al profesional de este nivel, y al profesional del nivel secundario o terciario los problemas que deben resolverse en estos niveles.
- ❑ Los pacientes ISAPRE a los cuales se les haya detectado un problema de salud AUGÉ deberán acudir a su seguro correspondiente para que se hagan efectivas las garantías a las cuales tienen derecho
- ❑ Llenar el Informe Proceso Diagnóstico en el plazo establecido para cada problema de salud, según corresponda, confirmando o descartando el diagnóstico original.
- ❑ Llenar el Formulario de Cierre de Caso, cuando se trate de un término de tratamiento, exclusión por protocolo o rechazo de tratamiento.

C. Responsabilidades de las Unidades de Estadística en los Servicios de Salud:

- ❑ Administrar la información necesaria para la formulación, el control y la evaluación de los programas de salud, de desarrollo de infraestructura, de gestión de recursos humanos y financieros, de producción, de impacto directo sobre el estado de salud de la población y otros, garantizando la calidad de las mismas.
- ❑ Utilizar las salidas del SIGGES, para elaborar los indicadores de gestión y de monitoreo de garantías que se requieren para la gestión sanitaria local.
- ❑ Mantener actualizada la información relativa al GES, a la producción y a las coberturas de atención, construyendo los indicadores necesarios
- ❑ Recopilar y revisar la información emanada de los establecimientos de la red asistencial y de los prestadores privados ubicados en el área de gestión de la red o en convenio, y velar por su consistencia, integridad, exactitud, oportunidad y comparabilidad.

3 La superintendencia estableció que esta notificación debe ser realizada por el prestador al momento de la confirmación. De este modo el establecimiento (que corresponde al prestador) es el responsable de la información al paciente la que puede ser realizada íntegramente por el profesional médico o odontólogo, o bien una vez establecido el diagnóstico la información de derechos y deberes puede ser realizado por otro funcionario del establecimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos a nivel local.

- ☐ Establecer y mantener mecanismos de coordinación con las unidades de estadísticas y encargados del SIGGES en los establecimientos de la red
- ☐ Mantener mecanismos de coordinación con las unidades funcionales del Servicio de salud y de los establecimientos
- ☐ Enviar información procesada al DEIS del Minsal.
- ☐ Velar por la confidencialidad de la información de los pacientes.

D. Responsabilidades del Encargado de Procesos del Establecimiento:

- ☐ Revisar diariamente, en conjunto con el Jefe de SOME, los casos AUGE ingresados, con y sin citación, verificando los plazos de cumplimiento de las garantías.
- ☐ Gestionar en conjunto con el SOME el cumplimiento de las garantías según problema de salud, mediante la citación, ya sea en el establecimiento, o por la vía de compra de servicios.
- ☐ Verificar y velar porque los profesionales responsables de la atención registren, en los documentos definidos para ello y en la Historia Clínica correspondiente, las causas de incumplimiento de las garantías, en los casos en que haya justificación.
- ☐ Coordinar con los Jefes de Servicios Clínicos los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las garantías.
- ☐ Comunicar al Encargado de Procesos del Servicio de Salud los casos en riesgo de incumplimiento de Garantías.
- ☐ Revisar los procedimientos de alertas de monitoreo de Casos de acuerdo a cada problema de salud para garantizar su oportunidad.

E. Responsabilidades del Encargado de Procesos del Servicio de Salud:

- ☐ Verificar las prestaciones otorgadas a los casos utilizando la información existente en el SIGGES o los sistemas locales.
- ☐ Respecto a los casos en riesgo de incumplimiento de garantías:
- ☐ Revisar diariamente las alertas enviadas por los establecimientos
- ☐ Informar a la Dirección Regional de FONASA
- ☐ Gestionar la resolución de dichos casos en la Red de Salud pública o privada en convenio.
- ☐ Si no es posible gestionar la citación en la Red o mediante la compra, se debe coordinar con FONASA para la resolución de casos, a través de nuevos prestadores.

La meta de cumplimiento de las garantías de oportunidad es 100%. En caso de producirse retrasos en el cumplimiento de la, el Encargado de Procesos del Servicio de Salud debe mantener información actualizada sobre las causas que generaron estos retrasos en cada caso.

V. Funcionarios que Intervienen en el Proceso de Atención

En el procedimiento de atención de un paciente pueden intervenir a lo menos, las siguientes personas:

- ☐ Funcionario de Admisión del SOME
- ☐ Funcionario de Recaudación del SOME
- ☐ Profesional médico, otro profesional, o paramédico que le proporciona la prestación consulta
- ☐ Funcionario encargado de llamar a los pacientes al box de consulta del profesional de la Unidad donde se le va a prestar la atención.
- ☐ Funcionario que atiende las solicitudes de exámenes de apoyo diagnóstico.
- ☐ Funcionario que efectúa los exámenes de apoyo diagnóstico.
- ☐ Funcionario administrativo o paramédico de la unidad de Apoyo Diagnóstico o terapéutico que lleva el registro de las prestaciones realizadas.
- ☐ Funcionario que atiende las solicitudes de tratamiento.
- ☐ Profesional médico, otro profesional, o paramédico que efectúa el tratamiento.
- ☐ Funcionario administrativo o paramédico de pabellón, que lleva el registro de intervenciones quirúrgicas.
- ☐ Equipo Profesional que efectúa las intervenciones quirúrgicas.
- ☐ Funcionario de Estadística, encargado de recopilar y procesar los datos de las distintas prestaciones otorgadas, que le son informadas por los formularios en uso.
- ☐ Funcionario a cargo de la orientación e información a los usuarios

VI. Responsabilidades de los centros en la derivación

En las derivaciones entre establecimientos, cada uno de ellos se hace responsable de parte del proceso de derivación, con el objeto de mantener la continuidad de la atención.

A. Responsabilidad de Centro de Referencia

- ☐ Mantener los siguientes mecanismos de coordinación con los centros derivadores:
 - Un cabal conocimiento de la red asistencial
 - Contar con Normas, Manuales, instrucciones de derivaciones, *que formalicen los procedimientos de relación y derivación.*
 - Identificación, formalización y difusión de los procesos involucrados en la referencia y de las personas encargadas (Referentes)
 - *Protocolos de atención, de derivación y de contraderivación* consensuados con los centros derivadores
- ☐ Contar con un Plan de Contingencia (mantener oferta a todo evento). Este debe incluir los procedimientos de derivación a otra red, compra de servicio u otros que se hayan establecido.
- ☐ Asignar cupos respetando los criterios de equidad
- ☐ Cumplir con rol definido por nivel central
- ☐ Recibir los pacientes derivados y a sus acompañantes

- ☐ Mantener el recurso humano capacitado para la adecuada atención de los pacientes así como informados en los procedimientos, normas y leyes vigentes
- ☐ Colaboración en capacitación de centros derivadores
- ☐ Desarrollar y ejecutar políticas y planes para la formación y el desarrollo de especialistas

B. Responsabilidad de Centro de Derivador

- ☐ Cumplir con los protocolos de derivación establecidos.
- ☐ Coordinar las agendas y los traslados con los establecimientos receptores.
- ☐ Mantener una adecuada pertinencia y oportunidad en la derivación
- ☐ Identificar, formalizar y difundir de los procesos involucrados en la referencia y de las personas encargadas (Referentes)
- ☐ Realizar los traslados de pacientes, y sus acompañantes cuando corresponda, con calidad y oportunidad
- ☐ Entregar la información necesaria sobre el proceso de atención y derivación que se está realizando, en forma oportuna y adecuada al paciente y su familia
- ☐ Recibir al pacientes una vez que es dado de alta en el centro de referencia
- ☐ Coordinar la agenda de controles y traslados
- ☐ Mantener el recurso humano capacitado para la adecuada atención de los pacientes así como informados en los procedimientos, normas y leyes vigentes
- ☐ Planificar actividades que permitan evaluar y mejorar el proceso de derivación
- ☐ Seguimiento del paciente en la macrored

VII. Material de Documentación Necesario para la Atención de los Pacientes

A. Material que debe existir en cada box de atención profesional:

- ☐ Lista de Problemas AUGÉ y Sub problemas (ver anexo)
- ☐ Guías Clínicas. Si no es posible contar con una por Box, las Guías Clínicas deben estar en un lugar accesible y conocido por los profesionales.
- ☐ Hoja Diaria de Registro de Prestaciones Realizadas.
- ☐ Formularios Solicitud de Interconsulta o Derivación
- ☐ Formularios Informe Proceso Diagnóstico (en consulta de especialidades)
- ☐ Formularios de Orden de Atención del establecimiento
- ☐ Formularios de Cierre de Caso
- ☐ Formularios de constancia de un problema de salud AUGÉ para información al paciente
- ☐ Block de prescripciones
- ☐ Lista de centros de derivación de acuerdo con la red de atención
- ☐ Folletos informativos sobre los problemas de Salud AUGÉ para entregar a los usuarios. Estos pueden estar disponibles en otras ubicaciones tal como las OIRS, u oficinas de Admisión

B. Material que debe existir en la Oficina de Admisión del SOME:

1. Registros manuales o computacionales:

- Base de datos computacional de beneficiarios de todo el país (sistema certificador del FONASA)
- Agenda de profesionales
- Registro de Inscritos en el establecimiento
- Citaciones

2. Folletos:

Estos pueden estar ubicados en otra dependencia cercana al flujo del paciente si las condiciones físicas del establecimiento no permiten disponer de esta información en Admisión.

- Derechos del paciente
- Ley de Garantías Explícitas de Salud
- Folletos informativos sobre los problemas de Salud AUGE y otros para entregar a los usuarios ("Así funciona el AUGE", "Todo lo que debes saber sobre el AUGE", cartillas programas, u otros disponibles)

3. Expuesto a la vista del funcionario:

- Lista de problemas AUGE y Sub problemas (ver anexo)
- Centros de derivación de acuerdo con la red de atención

4. Documentación de apoyo:

- Lista de todas las patologías que se incluyen en los distintos problemas AUGE y Sub problemas (ver Anexo)
- Decreto que establece las garantías explícitas N° 44 del 09/01/2007. Decreto n° 69 del 28 de febrero del 2007
- Reglamentos correspondientes
- Lista de prestaciones que se incluyen en las garantías de cada problema AUGE y Prestaciones de Programas Especiales de FONASA
- Manual de procedimientos
- Procedimientos de derivación de las redes y macroredes; listas de establecimientos de las redes con datos importantes (dirección, teléfonos, encargados)

Descripción General del Proceso

A partir del proceso de atención descrito anteriormente y con las definiciones especificadas en el decreto del GES, se desarrollan las definiciones específicas que operan en el Sistema de Información SIGGES y que permiten hacer el seguimiento de los casos GES a lo largo de su proceso de atención completo, el monitoreo de los tiempos relacionados a las garantías de oportunidad, y el cálculo de los parámetros relacionados a la garantía de protección Financiera.

I. Definición Caso AUGE

Se define un Caso AUGE como el conjunto de los siguientes datos:

- Paciente identificado como Beneficiario⁴ Fonasa.⁵
- Problema de Salud: uno de los problemas comprendidos en el Decreto GES vigente.
- Subproblema de Problema de Salud: se han definido subproblemas para algunos problemas de salud que, según la legislación, tienen distintas garantías, según algunas características específicas de cada patología.

En el SIGGES, pueden crearse casos sin conocer el subproblema definitivo a que corresponde; esto porque algunos problemas de salud como “Cataratas” definen el subproblema durante el proceso de diagnóstico del paciente y no se cuenta con la información suficiente como para discriminar entre subproblemas en etapas tempranas como la “Sospecha”. Para estos casos se asignará el subproblema correspondiente al paciente al recibir la confirmación diagnóstica, indicando esta situación.

La creación del caso en el sistema informático SIGGES está determinada por el ingreso de los datos señalados anteriormente, cuando aparece alguno de los eventos identificados y tipificados para este estos efectos.

II. Creación de casos AUGE

Un caso AUGE puede originarse a través de la información existente en los diferentes formularios propios del proceso de atención. El registro de estos formularios en el SIGGES determina la creación del caso en el sistema informático:

4 Beneficiarios: Personas que sean beneficiarios según el Libro II o que sean afiliados o beneficiarios según el Libro III, ambos del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

5 En el caso de los pacientes beneficiarios de ISAPRE que tengan la condición de PRAIS, estos deberán ser considerados como beneficiarios de FONASA si así lo solicitan. Se le debe informar al paciente que puede optar al GES en ambos seguros, pero que al momento de escoger la opción de cambio va a estar limitada.

- Ingreso de una Solicitud de Interconsulta o Derivación en la cual se ha marcado un problema AUGE en etapa de sospecha.
- Ingreso de un Informe Proceso Diagnóstico con marca en la casilla "Confirmado".
- Ingreso de Planillas APS: en estas planillas utilizadas para los establecimientos de ese nivel, los casos se pueden crear si se cumplen las determinadas validaciones definidas por el sistema.

En todas estas circunstancias, el sistema de información SIGGES graba el documento ingresado y además verifica que los pacientes cumplan con las Condiciones de Acceso definidas para cada problema de salud AUGE en el decreto del régimen de salud, para crear un caso AUGE.

Estas condiciones son revisadas cada vez que para un paciente se ingresa un evento que puede crear casos. Estas condiciones son diferentes para cada Problema de Salud y en algunos casos para cada uno de sus subproblemas; dichas condiciones pueden ser simples o compuestas.

El sistema SIGGES evalúa al menos las siguientes condiciones para la creación de un caso AUGE:

- ☐ Si el paciente tiene "casos abiertos" para el mismo problema de salud.
- ☐ El estatus de "Beneficiario" del paciente dentro de la Aseguradora de Salud
- ☐ Fecha de Nacimiento del Paciente
- ☐ Edad del paciente
- ☐ Sexo del Paciente (Femenino, Masculino)
- ☐ Tipo de Paciente (No-Nato, Recién Nacido sin RUN, Paciente con RUN, Paciente sin RUN)
- ☐ Para Recién Nacidos:
 - Gramos de peso al nacer
 - Semanas de gestación al nacer

El sistema no permite crear un caso con fecha posterior al fallecimiento de un paciente.
El sistema no evalúa los criterios clínicos definidos en el decreto.

III. Cierre de Caso

Un Caso está Cerrado cuando el Paciente alcanza uno de los estados terminales. Un Caso cerrado no puede ser abierto nuevamente y no puede registrar nuevos eventos ocurridos con posterioridad a la fecha indicada de cierre.⁶

⁶ Nota: Un cierre de caso no exime del cumplimiento de las garantías del caso.

Las posibles causales de cierre están enumeradas a continuación:

- ❑ **Fallecimiento:** Por lo general esta causa podrá ser determinada por el SOME, que llenará el *formulario de Cierre del Caso* y lo registrará en el SIGGES.
La información sobre pacientes AUGÉ fallecidos se podrá obtener, ya sea del formulario de Egreso de Hospitalización, si han fallecido en el establecimiento, o de la detección de las causas de inasistencia de los pacientes. Otra fuente de información posible es el resultado del Monitoreo, por parte de los Encargados AUGÉ de los establecimientos.
El SIGGES contará además con la retroalimentación de las bases de datos de Registro Civil, que periódicamente transmitirán los datos de las defunciones ocurridas en todo el país, para que sean cotejadas con los registros del sistema.
El Sistema entregará un listado de los Cierres de casos producidos en este proceso.
- ❑ **Término de Tratamiento:** consiste en la definición, por parte del profesional del área clínica que está tratando el caso, que éste no continuará recibiendo prestaciones, ya sea porque el paciente ha mejorado, porque ya no lo requiere o porque el tratamiento correspondiente al problema de salud ya se ha proporcionado en su totalidad. También puede darse esta causa en el estado de seguimiento.
- ❑ **No cumple criterios de Inclusión:** en aquellos casos en que la pertinencia de la sospecha ingresada por otro establecimiento no corresponda o sea inadecuada, corresponderá cerrar el caso por la causal “no cumple criterios de Inclusión”, de modo de diferenciar de aquellos casos en que la sospecha fue adecuada pero fue descartada por el especialista.
- ❑ **Exclusión por protocolo:** en cada problema de salud pueden estar definidos ciertos criterios que impiden o no hacen aconsejable el tratamiento de un paciente. Estos criterios, definidos en las Guías Clínicas, deberán ser declarados para cada caso particular, por el profesional tratante, en el *formulario de Cierre de Caso*.
- ❑ **Término de tratamiento garantizado:** para cada problema de salud están definidas las prestaciones garantizadas por el AUGÉ; cuando ya se han completado dichas prestaciones, procede el cierre del caso en el sistema aunque el paciente siga en tratamiento en el establecimiento.
- ❑ **Descarte:** definido por el profesional del área clínica, a través de formulario **Informe Proceso Diagnóstico, o en la Hoja APS**, para los problemas que se resuelven en este nivel.
- ❑ **Cambio de previsión:** corresponde cerrar el caso cuando el paciente declara que se seguirá tratando en el área privada, o cuando cambia su condición previsional en la Base de Beneficiarios. El sistema podrá realizar cierres de los casos al comprobar el cambio de previsión en el proceso de actualización de la base de datos. Este entregará un reporte de los casos cerrados por esta causal para que el establecimiento realice los procedimientos administrativos correspondientes y actualice sus registros.
- ❑ **Causas atribuibles al paciente:** se consideran como abandono las siguientes circunstancias:

Por rechazo al prestador: si el paciente no acepta al prestador o la red de prestadores que se ha indicado para su tratamiento, el profesional o el SOME podrá hacerle firmar una declaración que así lo establezca y llenará el formulario de Cierre respectivo cuando corresponda. En algunos casos el rechazo de una prestación o de un prestador no es causal del cierre del caso, sino que sólo implica una excepción de una garantía.

Por rechazo del tratamiento: cuando el paciente expresamente declara que no desea continuar el tratamiento, el profesional deberá cerrar el caso, consignando esta circunstancia en la historia clínica, con la firma del paciente. Si se rechaza solamente una prestación en específico, pero el paciente sigue con el resto de las prestaciones, no corresponde cerrar el caso.

Otra causa expresada por el paciente: cuando el paciente, por cualquiera otra causa, manifiesta que no seguirá haciendo uso de su tratamiento garantizado por el AUGE, el profesional, o en su defecto el SOME, deberá cerrar el caso, consignando esta circunstancia en la historia clínica, con la firma del paciente.

Inasistencia: se podrá cerrar el caso por inasistencia si el paciente deja de concurrir a las citaciones durante un periodo que será establecido para cada tratamiento en el protocolo respectivo.

Estos eventos que originan el cierre de un caso, se documentan en el **formulario de Cierre de Caso**, o bien mediante el registro correspondiente al descarte en el **Informe Proceso Diagnóstico o en la Hoja APS**.

No todas esas causales son válidas para todos los problemas de salud, sino que su pertinencia se establece de acuerdo con los criterios técnicos definidos para cada problema de salud, los que se traducen en el SIGGES en una programación (parametrización) específica para cada problema de salud.

No corresponde cerrar el caso cuando el paciente se traslada desde un establecimiento a otro o desde una red a otra y continúa su tratamiento.

IV. Excepciones de Garantías

Hay ocasiones en que a un determinado paciente no se le realiza un procedimiento o una atención que en el caso del GES tiene asociada una garantía de oportunidad, de calidad o financiera. En esos casos se debe justificar la no realización de ese procedimiento o atención.

Las causas para la no realización de esa prestación puede ser derivadas de una decisión del paciente o de su tutor responsable o bien derivadas de una decisión del profesional tratante, tomando en cuenta las condiciones y el estado de salud del paciente en cuestión.

Solo se consideran Excepciones de las Garantías situaciones derivadas de condiciones de los pacientes. No pueden ser consideradas excepciones situaciones derivadas de los prestadores.

Según el Proceso de Atención al paciente, se puede exceptuar una Garantía de Oportunidad⁷, cuando:

- ❑ **No se va a realizar el procedimiento o atención garantizada**, ya sea por motivos clínicos, debidamente fundamentados por el especialista, o por rechazo del paciente.
- ❑ **El procedimiento o atención se va a realizar** pero debido a las causas fundamentadas, el plazo legal se va a sobrepasar.
- ❑ **Inasistencia del paciente** a la atención según los parámetros definidos para cada situación. En aquellos casos en que la excepción se deba a una causa temporal que obligue a prorrogar la atención (condición médica del paciente; patología concomitante) se deberá implementar localmente un procedimiento para hacer seguimiento de estos nuevos plazos con posterioridad.

No podrán ser exceptuadas Garantías de Oportunidad en que la fecha máxima de ocurrencia del evento esperado ya ha ocurrido, a excepción de aquellas debidas a inasistencia del paciente.

Para cada paciente ante cada una de justificaciones de incumplimiento se debe completar un formulario similar al que se presenta en el anexo 1 (Formularios e Instrucciones). En su defecto podría consignarse en la Historia Clínica o en el Formulario de Atención de Urgencia, especificando claramente que se trata de una excepción de garantía. En este último caso debe existir un mecanismo establecido para que la información correspondiente sea ingresada al SIGGES.

El documento correspondiente debe contener al menos la información siguiente:

- ❑ Identificación del paciente (RUN, Nombres y Apellidos)
- ❑ Problema de salud al cual corresponde el procedimiento o atención garantizada (problema y subproblema cuando corresponda)
- ❑ Procedimiento o prestación que hay que justificar (garantía): de acuerdo al listado de prestaciones trazadoras.
- ❑ Causal de la excepción, según el detalle que se define más adelante
- ❑ Explicación más detallada de la causal marcada más arriba
- ❑ Identificación y firma de la persona que toma la decisión de la no realización o postergación del procedimiento o atención garantizada. Esta puede ser el profesional tratante, el paciente, su tutor o representante legal (en el caso de las excepciones de causas atribuibles al paciente o sus representantes, tales como el rechazo o la expresión de la voluntad del paciente), o el funcionario que determine la inasistencia del paciente de acuerdo a los criterios establecidos por el MINSAL⁸.

7 En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando "fuerza mayor"

8 Ordinario 1417 del MINSAL del 30 de Junio del 2006

En la propuesta de formulario **EXCEPCIONES DE GARANTÍAS DE OPORTUNIDAD** en **SIGGES** se incluyen las siguientes causales de excepción:

❑ **Decisión del Profesional Tratante**

- Criterios de exclusión (según protocolos): definidos en los protocolos o guías clínicas. Son las condiciones que excluyen al paciente del tratamiento o prestación garantizada.
- Indicación Médica: decisión justificada del profesional tratante ante condiciones específicas del paciente.

❑ **Causas Atribuibles al Paciente o sus Representantes**

- Por Inasistencia
- Por Expresión de la Voluntad del Paciente o sus Representantes
- Por Rechazo del Prestador Designado
- Por Rechazo del Tratamiento
- Por otra causa

❑ **Otra Causa: especificar**⁹

El SIGGES generará en forma automática excepciones a garantías, cuando se informe el fallecimiento del paciente, o se produzca el cambio de previsión a través del proceso de actualización de la Base de Beneficiarios del FONASA. Estos procesos automáticos serán informados en las salidas correspondientes del sistema.

Las causales que el SIGGES reconoce como válidas para cada una de las garantías de oportunidad están definidas en los protocolos de atención de cada problema de salud ¹⁰.

En el **SIGGES**, las garantías de oportunidad con excepciones no aparecen en los reportes de monitoreo como incumplidas, aunque cumplan con las condiciones para estarlo.

V. Regla de asignación del Caso a un establecimiento en el SIGGES

El SIGGES asigna el caso de un paciente a un solo establecimiento. Para ello se utiliza una **regla específica** que permite ir siguiendo el caso a lo largo de su proceso de atención, en cualquier establecimiento del sector.

1. Un Caso **pertenece a un solo establecimiento** definido en el SIGGES, en el cual se registran los eventos del paciente.

⁹ En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando "fuerza mayor"

¹⁰ Todas estas reglas se especifican en las Guías Rápidas elaboradas por el Departamento de Gestión de Procesos para cada uno de los problemas de salud y que se publican en www.salunet.cl

2. Para determinar ese establecimiento se buscará el último evento del paciente, y según el caso, se asignará el establecimiento de pertenencia, a saber:
 - 2.1. Si el evento es una Prestación Otorgada que ocurre posteriormente a una confirmación (Informe de Proceso de Diagnóstico que confirma el problema de salud del paciente) y además en que la realización de la prestación corresponde a un evento de transición al estado de tratamiento del problema de salud, entonces, el establecimiento al que pertenece el caso corresponde al que realizó dicha prestación.
 - 2.2. Si es una Solicitud de Interconsulta, entonces, el establecimiento al que pertenece el CASO, corresponde al establecimiento de destino identificado en dicha solicitud de interconsulta.
 - 2.3. Si el evento es un Informe de Proceso de Diagnóstico, el establecimiento al que pertenece el CASO, corresponde al establecimiento identificado en dicho informe.
 - 2.4. Si el paciente no posee solicitudes de interconsulta o informes de proceso de diagnóstico, entonces, se define que el establecimiento a que pertenece el CASO es que creó el CASO. Este evento está definido en el diagrama de estados de cada problema de salud/ subproblema.

Estados del Paciente en el Ciclo de Atención

El paciente pasa por diversas fases de evolución durante el ciclo de la atención, que transcurren en la **medida que se suceden eventos o hitos que a su vez, requieren que sean registrados. Estas fases se denominan Estados y están definidos para cada problema de salud.**

Un Caso en salud existe propiamente tal cuando el problema de salud ya ha sido confirmado, sin embargo, debido a que en el hay problemas de salud GES que tienen garantizadas intervenciones en la etapa de diagnóstico, muchas de las cuales tienen a su vez definidos tiempos máximos, en el SIGGES se crea un Caso GES cuando aparece el primer evento que debe ser registrado para un problema de salud de un paciente en particular. Por lo general el evento Ingreso **Solicitud de Interconsulta o Derivación** provoca la creación de un Caso, pero también puede crearse directamente con el ingreso del **Informe Proceso Diagnóstico**, cuando ya existe un caso confirmado, que se ingresa con este estado al sistema. A partir de la **Hoja APS** en la cual se registra la información generada desde las Hojas de registro Diario de Atenciones de los establecimientos APS, se puede crear un Caso desde la Sospecha o desde la Confirmación

Los cambios de estado pueden ser distintos para cada sub problema del Problema de Salud o similar para todos ellos. Los casos particulares están ilustrados en los diagramas de estado de cada problema de salud, los cuales están disponibles en la documentación que el Sistema proporciona en línea.

El Caso, una vez que fue creado, debe encontrarse en todo momento en uno de los estados definidos por el sistema.

Los estados posibles son, en la secuencia indicada:

- 1) **CASO EN SOSPECHA:** estado en que se ha extendido una "Solicitud de Interconsulta o Derivación" a una especialidad, por una hipótesis diagnóstica, y aún no se ha confirmado el diagnóstico.
- 2) **CASO EN PROCESO DE DIAGNÓSTICO:** estado en que el paciente ya ha sido atendido por el especialista, quien le ha solicitado exámenes y que se encuentra, por lo tanto, en espera de confirmación o descarte de la hipótesis diagnóstica.
- 3) **CASO CONFIRMADO:** estado en el que se ha registrado en el "Informe del Proceso de Diagnóstico" la confirmación del problema de salud AUGE registrado en la Solicitud de Interconsulta o Derivación
- 4) **CASO EN TRATAMIENTO:** estado en que el paciente portador de un diagnóstico confirmado de una enfermedad, está recibiendo aquellas atenciones de tratamiento de la misma que están definidas en el listado oficial que acompaña al Decreto.
- 5) **CASO EN SEGUIMIENTO:** estado en que el paciente terminó el tratamiento indicado originalmente en función de lo establecido por el protocolo clínico formulado para la enfermedad que lo afecta, y se mantiene en observación por indicación del especialista. La indicación de seguimiento implica emitir un "**Solicitud de Interconsulta o Derivación**" o una "**Orden de Atención**", donde se especifique la indicación "A seguimiento".
- 6) **CASO CERRADO:** estado en que el caso deja de estar activo por alguna de las siguientes causas, como se indica en el punto Cierre de Caso:
 - Fallecimiento
 - Término de Tratamiento
 - No cumple criterios de Inclusión
 - Criterios de exclusión (por protocolo)
 - Término de tratamiento garantizado
 - Descarte
 - Causas atribuibles al paciente
 - Por rechazo al prestador
 - Por rechazo del tratamiento
 - Otra causa expresada por el paciente
 - Inasistencia

En los casos AUGE que se resuelven en el nivel primario los estados se registran directamente en la Hoja Diaria APS, pudiendo darse los estados de Sospechoso, Confirmado, Descartado, En Tratamiento y Cerrado.

Importante

En la última versión del SIGGES, no se incorporaron los estados para los problemas de salud desde el 40 al 56, existiendo solo los estados de CASO ABIERTO y CASO CERRADO.

Situaciones de Excepción

Conforme a los estados descritos, el ciclo normal del proceso es: **Sospechoso-En proceso diagnóstico-Confirmado-En tratamiento-En seguimiento-Cerrado.**

En general los casos pueden entrar directamente al estado de Confirmado, porque ya ha sido atendido anteriormente por ese problema de salud en algún establecimiento público o privado, siempre que se cumplan las condiciones definidas en el reglamento para cada problema de salud.

Además, en algunos problemas de salud los casos no pasan por todos los estados de acuerdo a lo definido en los decretos n° 170, del 26 de Noviembre del año 2004 y el decreto 228 de Enero del 2006, y el n 44 del 09 de Enero del 2007 modificado el 28 de Febrero del 2008 por el decreto supremo n° 69, constituyendo excepciones al proceso normal:

I. Casos que no presentan los estados de sospecha ni de proceso diagnóstico:

- 1) **Alivio del dolor:** El caso se abre una vez que el equipo profesional tratante de su problema oncológico determina que su condición es terminal y requiere sólo terapia de apoyo.
- 2) **Tratamiento quirúrgico de escoliosis en menores de 25 años:** Los pacientes que ingresan a este problema de salud han sido previamente diagnosticados, e ingresa al sistema cuando se indica el tratamiento quirúrgico
- 3) **Infarto Agudo al Miocardio (IAM): Subproblema “Seguimiento by-pass y/o angioplastía percutánea, coronarias.:** Pacientes que no han sufrido un Infarto, pero que debido a que se les ha realizado un procedimiento de by-pass o angioplastía percutánea, coronario, son ingresados para el seguimiento y prevención de complicaciones.
- 4) **Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa.:** Es la misma situación que el de la escoliosis operable
- 5) **IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 15 años:** problema de confirmación inmediata.
- 6) **Epilepsia no refractaria en personas desde un año y menores de 15 años:** paciente ingresa una vez que se ha determinado que se trata de este diagnóstico
- 7) **Insuficiencia Renal Crónica Terminal:** Sólo una vez que el paciente se encuentra en una situación terminal de su insuficiencia renal crónica terminal, puede ser ingresado al SIGGES.
- 8) **Cáncer de Próstata:** Una vez que el paciente es confirmado se ingresa al Sistema.
- 9) **Depresión en personas de 15 años y más:** A partir de la confirmación del problema de salud.

- 10) Tratamiento quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en personas sintomáticas:**
Una vez que se determine que el paciente es portador de una Hiperplasia de Próstata y que cumple con los criterios de inclusión clínicos definidos en el decreto
- 11) Órtesis o Ayudas Técnicas:** A partir de la indicación profesional de entrega de la Ayuda Técnica.
- 12) Tratamiento médico en personas de 55 años y más con Artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada:** Una vez que se confirma la condición del paciente
- 13) Tratamiento Quirúrgico de Hernia al Núcleo Pulposo:** A partir que se determina que el paciente cumple con los criterios de inclusión para la realización de la cirugía.
- 14) Urgencia Odontológica:** a partir del diagnóstico del problema.
- 15) Politraumatizado Grave:** a partir de la confirmación de la condición de grave del paciente politraumatizado
- 16) Atención de urgencia del TEC Moderado o Grave:** Una vez que se determine que se trata de un TEC moderado o Grave.
- 17) Fibrosis Quística:** a partir de la confirmación del Problema
- 18) Artritis Reumatoidea:** a partir de la confirmación del problema por parte del especialista.
- 19) Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años:** A partir de la determinación de que el menor cumple con las condiciones definidas para el Plan Básico de Atención.
- 20) Analgesia del Parto:** a partir del momento en que el profesional indique la analgesia correspondiente
- 21) Gran Quemado:** A partir del momento en que se determine la condición de Gran Quemado
- 22) Hipoacusia Bilateral en personas mayores de 65 años que requieren de audífonos:** a partir de la confirmación por parte del especialista de la condición de Hipoacusia que requiere de audífono.

II. Casos que no tienen seguimiento, sino que continúan en estado de tratamiento hasta el cierre:

- 1) Alivio del Dolor
- 2) Diabetes Mellitus tipo 1
- 3) Diabetes Mellitus tipo 2
- 4) Cataratas
- 5) Esquizofrenia
- 6) IRA Baja
- 7) Neumonía
- 8) HTA Primaria
- 9) Epilepsia no refractaria
- 10) Prematurez: Subproblema prevención parto prematuro
- 11) EPOC
- 12) Asma Bronquial
- 13) Depresión
- 14) Hemofilia

- 15) Tratamiento Médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla leve o moderada
- 16) Fibrosis Quística
- 17) Artritis Reumatoidea
- 18) Hipoacusia Bilateral.
- 19) Displasia broncopulmonar

III. Casos que presentan otros estados además de los mencionados:

- 1) **Insuficiencia renal crónica Terminal:** Caso en tratamiento diálisis, Caso con estudio de pre - trasplante
- 2) **Cáncer Cérvicouterino:** Caso en etapificación posterior a la confirmación previa al tratamiento
- 3) **Salud oral integral:** El caso se inicia en una etapa de "En Espera de Atención". Pasa a tratamiento una vez que se le da la primera prestación de tratamiento.
- 4) **VIH – SIDA:** En este problema las etapas corresponden a la solicitud de cambio o inicio de triterapia; la confirmación de la triterapia por parte de la Subsecretaría de Salud Pública y el tratamiento (entrega de triterapia).
- 5) **Infarto Agudo al Miocardio (IAM) subproblema seguimiento bypass y/o angioplastia percutánea, coronarias:** El caso tiene solo 2 eventos: Caso Confirmado y Caso en Seguimiento.

IV. Casos con etapas pre-natales:

- 6) **Cardiopatía Congénita Operable:** Sospecha Prenatal / Proceso diagnóstico prenatal.
- 7) **Disrafia sospecha prenatal**

V. Problema de salud que no crea casos

- 8) **Urgencias Odontológicas:** En este caso y debido a que tanto la sospecha como la confirmación y el tratamiento ocurren en la misma consulta de urgencia y son resueltas por el mismo profesional, este problema de salud no genera caso en el SIGGES. Solo se debe informar las atenciones realizadas por este problema y sus diferentes diagnósticos, los que son registrados como prestaciones realizadas ¹¹.

11 Se registra en el ingreso de prestaciones Programas Especiales (valoradas) problema urgencia odontológica.

Garantías de Oportunidad para los Pacientes AUGE en el SIGGES

El Decreto GES vigente, define distintas garantías para los pacientes que presentan determinados problemas de salud.

Para los efectos del SIGGES, la garantía que es controlada y monitoreada por el sistema es la de **oportunidad**.

La garantía de oportunidad consiste en el plazo máximo definido para el otorgamiento de una prestación o grupo de prestaciones.

El sistema SIGGES **monitorea el plazo** definido para el primer prestador, pero no considera el plazo definido en la ley para la acción del seguro y de la superintendencia en el caso de no cumplirse ese primer plazo.

No indica por lo tanto el incumplimiento legal, pero permite monitorear y adelantarse a un posible incumplimiento.

Las garantías de oportunidad son tiempo...



Hay garantías en las diferentes etapas:

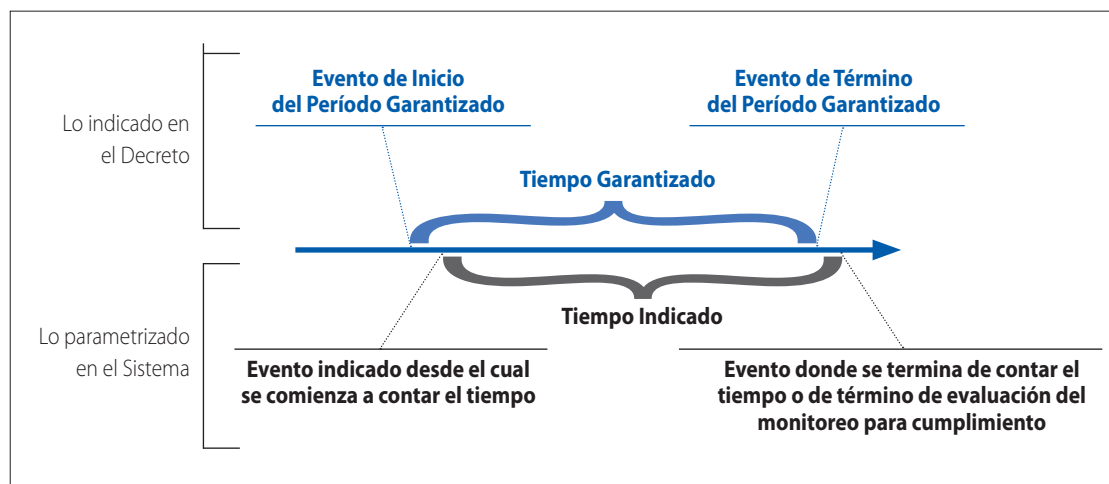
- ☐ Sospecha a Confirmación.
- ☐ Confirmación a Inicio de Tratamiento
- ☐ Tratamiento a Seguimiento.

Son aproximadamente 191 los tiempos que se monitorean en el sistema.

Cualquiera sea la parte del proceso en que se encuentren las prestaciones que tienen garantizada su oportunidad de ocurrencia, los elementos que las definen en el SIGGES son (ver Figura 1):

- 1) **Evento que activa la garantía.**
- 2) **Evento que cierra la garantía.**
- 3) **Evento desde el cual se comienza a contar el tiempo (evaluación de la garantía).**
- 4) **Evento donde se termina de contar el tiempo o de término de evaluación de garantía.**
- 5) **Tiempo máximo permitido entre la ocurrencia del evento de inicio y el evento final.**

Figura 1: Línea de tiempo



Las garantías están definidas en los Decretos del Régimen de Garantías.

I. Datos del Paciente en el SIGGES

El Sistema de Información, para poder controlar el cumplimiento de las garantías de los pacientes AUGE, requiere que se ingrese la identificación del paciente al **momento de iniciar el caso**. Se pueden dar varias situaciones:

- ❑ **Paciente que conozca y porte su RUN:** en ese caso se registrará el RUN en el SIGGES con lo que el sistema consultará en la base de datos de Beneficiarios trayendo la información sobre previsión y datos personales que existan allí
- ❑ **Paciente Recién Nacido sin RUN:** En los casos de los recién nacidos en que se desconozca el RUN, y en los prematuros, se ingresan al SIGGES con la opción de Recién Nacido sin RUN. En ese caso se le asigna temporalmente el RUN de la madre (o del padre si este es el beneficiario). Se deben ingresar además los datos de edad gestacional y peso al nacer.
- ❑ **En los casos de urgencia en los que no se conozca el RUN** del paciente se puede ingresar a través de la opción de Pacientes sin RUN. Una vez que se disponga de la información de RUN debe realizarse el Cambio utilizando la opción Cambiar RUN a Paciente. No debe utilizarse esta opción para ingresar pacientes que no son beneficiarios al SIGGES, ya que serán eliminados cuando se realicen las validaciones periódicas contra la base de beneficiarios.
- ❑ **En el caso de las sospecha de problemas de salud que se realicen en la etapa prenatal,** se agrega el Tipo de Paciente No-nato, que corresponde a Pacientes que todavía no nacen y que están afectos a eventos al igual que cualquier otro paciente conocido por el Sistema de Información. Este

tipo de paciente debe estar relacionado con otro paciente -que en este caso debe ser la madre-, tal como existe hoy en día la relación entre un paciente con RUN y un Paciente Recién nacido sin RUN. De la misma forma se deberá cambiar de Tipo de paciente No-nato a Recién nacido sin RUN y/ o a Paciente con RUN, una vez ocurrido el nacimiento.

Una vez que se digita el RUN, el sistema busca los datos de identificación en la base del SIGGES; si encuentra al paciente, los recupera y despliega; si el paciente no figura en el SIGGES, el sistema busca y recupera los datos de la Base de Beneficiarios del FONASA.

Aunque los datos de identificación por lo general no pueden ser modificados, el sistema permite completar alguna información, como la región y la comuna.

Si el paciente no figura como beneficiario en el SIGGES pero si aparece como beneficiario en la base de Beneficiarios del FONASA (certificador), el establecimiento debe solicitar a través de la mesa de ayuda¹² la corrección de los datos en el SIGGES.

Si el paciente no figura como beneficiario en el SIGGES y en la base de Beneficiario del FONASA (certificador) siéndolo, deberá solicitar su regularización en la oficina de FONASA correspondiente.

38

Los datos que deben figurar en el sistema son los siguientes:

- ☐ RUN y dígito verificador
- ☐ Tipo de Paciente (Condición de Acceso a Casos AUGE)
- ☐ Nombres (de base de Datos de FONASA)
- ☐ Apellidos (de base de Datos de FONASA)
- ☐ Fecha de Nacimiento (de base de Datos de FONASA)
- ☐ Edad (Condición de Acceso a Casos AUGE)
- ☐ Sexo (de base de Datos de FONASA. Condición de Acceso a Casos AUGE)
- ☐ Nacionalidad
- ☐ Etnia
- ☐ Región (de base de Datos de FONASA)
- ☐ Comuna (de base de Datos de FONASA)
- ☐ Dirección del paciente (de base de Datos de FONASA,)
- ☐ Correo Electrónico
- ☐ Aseguradora de Salud o Previsión (Condición de Acceso a Casos AUGE) (de base de Datos de FONASA)
- ☐ Teléfono

¹² El fono de la mesa de ayuda del SIGGES de FONASA es el 800470400.

- ❑ Datos Locales del paciente (Por cada Establecimiento que atiende al paciente)
 - Historia Clínica
 - Dirección
 - Región
 - Comuna
 - Teléfono
 - Fax
- ❑ **En el caso de un paciente prematuro (con o Sin RUN) se solicita marcar:**
 - Fecha de Nacimiento y Hora de nacimiento (si el paciente se crea como paciente sin RUN)
 - Condición de Prematurez (condición de acceso a casos AUGE)
 - Peso al nacer (condición de acceso a casos AUGE)
 - Semanas de Gestación al nacer (condición de acceso a casos AUGE)
- ❑ **En caso de paciente no –nato o Prevención del Parto Prematuro, deberá agregarse a los datos de la mujer embarazada:**
 - Fecha de Última Regla (Condición de Acceso a Casos AUGE)

Descripción Sumaria del Proceso de Atención del Paciente

- ❑ Todo paciente nuevo, es decir, el que por primera vez concurre a un establecimiento de un servicio público de salud, debe inscribirse en un **Consultorio**, generalmente que corresponda a su domicilio, para recibir todas las atenciones y prestaciones de salud que requiera y que ese nivel pueda proporcionarle. Una vez realizado este proceso y de acuerdo a la condición de salud y previsión el paciente podrá ser atendido por un profesional, que le otorgará una consulta. Cada vez que asista se verificarán en el SOME los datos de previsión y de contacto los que deberán ser actualizados en los sistemas de información.
- ❑ El profesional de salud completará los datos de la atención en la **Hoja Diaria de Atención** donde de tratarse de un problema de salud AUGE de resolución en la APS marcará esta condición además del problema de salud específico. En la atención en que se produzca la sospecha inicial deberá marcar “sospecha”. En la atención en que se confirme o descarte el problema de salud AUGE deberá marcar “Confirmación” o “Descarte”. Estas decisiones ocurren cada una sólo en una de todas las posibles atenciones que puedan dárseles a un paciente AUGE en el establecimiento.¹³
- ❑ Cuando se necesiten exámenes para apoyo al diagnóstico o procedimientos para el tratamiento del paciente, el profesional que otorgó la consulta extenderá una o más **Órdenes de Atención**¹⁴, especificando las prestaciones que el paciente requiere. Con ellas el paciente se dirigirá a la **Unidad de Apoyo Diagnóstico o de Tratamiento** para recibir las prestaciones respectivas, ya sea en el mismo establecimiento o en otro al que haya sido remitido, en el caso que en el establecimiento donde consultó no se otorguen dichas prestaciones.
- ❑ Si el profesional que lo atendió determina que el problema de salud no puede ser resuelto a ese

13 Ver indicaciones de Registro en las UAPO para aquellos casos GES que son atendidos en ellos, en anexo

14 En el caso de la indicación de medicamentos esto corresponde a una receta médica.

nivel y considera que el paciente necesita consultar a un especialista, le extenderá una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, para que sea atendido en la especialidad y establecimiento correspondientes, de acuerdo con las redes de atención establecidas para todo el país, y a las condiciones de beneficiario del paciente.

- ❑ El Consultorio donde el paciente esté inscrito lo remitirá, cuando sea necesario el examen de un especialista, con la **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, al establecimiento que corresponda, de acuerdo con la especialidad demandada y la red de atención. En los anexos se detallan las especialidades estandarizadas.
- ❑ Una vez que el paciente es atendido por el especialista, ya sea en el consultorio de origen o en el establecimiento donde se refirió y, cuando se necesiten exámenes para apoyo al diagnóstico o procedimientos para el tratamiento del paciente, el profesional que otorgó la consulta extenderá una o más **Órdenes de Atención**, especificando las prestaciones que el paciente requiere. Con ellas el paciente se dirigirá a la **Unidad de Apoyo Diagnóstico o de Tratamiento** para recibir las prestaciones respectivas, ya sea en el mismo establecimiento o en otro al que haya sido remitido, en el caso que en el establecimiento donde consultó no se otorguen dichas prestaciones.
- ❑ Los resultados de los exámenes y procedimientos, así como todas las atenciones que se prestan a los pacientes, serán informados al servicio clínico que los solicitó e incorporados a la historia clínica que el paciente tiene en el respectivo establecimiento.
- ❑ El especialista aplicará el tratamiento correspondiente a su especialidad, de acuerdo con el diagnóstico formulado y con los medios que estén disponibles en ese nivel. Si el tratamiento puede realizarse en el lugar de origen, en ese momento el especialista contestará la **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, con las indicaciones que sean necesarias.
- ❑ Si el paciente debe continuar tratamiento en la especialidad, una vez que éste haya terminado, el especialista deberá responder toda **Solicitud de Interconsulta o Derivación** al establecimiento o Unidad de atención que la solicitó, por escrito, en el **Informe Proceso Diagnóstico** o, en su defecto, en el formulario que se use para estos efectos, con la información sobre diagnóstico, exámenes y tratamientos efectuados, así como las indicaciones del tratamiento que deba continuar en la Unidad de Origen, cuando sea necesario.
- ❑ Independientemente, cualquier persona puede dirigirse a uno de los Servicios de Urgencia públicos de salud, SAPU o Servicio de Urgencia de un hospital, que funcionan en su mayoría en forma continua las 24 horas, para resolver los casos en que la naturaleza del problema de salud no le permite esperar para ser atendida en un Consultorio. En este servicio se le brindará una primera atención para resolver el problema inmediato, con los profesionales y equipos que amerite el caso, según las disponibilidades del establecimiento. En aquellos casos que se resuelvan en las Unidades de Emergencia se deberá consignar la información el **Formulario de Atención de Urgencia o DAU** respectivo. Cuando sea necesario, se le extenderá una Solicitud de Interconsulta o Derivación a otro establecimiento o se le dará una indicación para que concurra al Consultorio que le corresponda en días y horarios hábiles.

Los procedimientos aquí descritos se describen más en detalle en los capítulos siguientes.

CAPITULO II

Procedimientos Nivel Primario de Atención

- *Trámite Administrativo – SOME.*
 - *Inscripción Paciente nuevo.*
 - *Citación o Dación de hora en Consultorio.*
 - *Traslado a otro Consultorio.*
 - *Atenciones de Salud – Unidad Clínica*
 - *Unidades de Atención de Salud.*
- *Atención Auxiliar Clínico.*
 - *Consulta Profesional por un problema de Salud.*
 - *Solicitud de Interconsulta o Derivación.*
 - *Orden de Atención.*
 - *Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento.*

41

Trámite Administrativo – SOME

I. Inscripción de un Paciente Nuevo

A. Paciente se dirige a establecimiento de Atención Primaria

Todo paciente que por primera vez acude a un establecimiento público para solicitar una atención de salud, debe dirigirse en primer lugar a un **Consultorio** de un Servicio de Salud, para su inscripción.

Generalmente el Consultorio está ubicado en el mismo sector del domicilio del paciente.

B. Inscripción en el SOME

En primer lugar, el paciente deberá acudir a la Oficina de Admisión del **SOME** (Sección de Orientación Médica y Estadística).

Un funcionario de Admisión verificará si el paciente figura en la Base de Datos de Inscritos del Consultorio. Deberá además verificar la condición previsional en el Sistema de Titularidad de Derecho provisto por el FONASA para los establecimientos Públicos. Si se trata de un paciente ya inscrito, procederá a otorgarle la citación correspondiente.

Si se trata realmente de un paciente nuevo en el Consultorio, deberá abrirse la siguiente documentación:*

- ❑ **Historia Clínica**, donde se registrarán los datos de identificación del paciente.
- ❑ **Tarjeta para el Índice Alfabético de Pacientes**, que se archiva en un “kardex” y tiene por objeto ubicar el número de la Historia Clínica.
- ❑ **Carné** del paciente, con el número de Historia Clínica, donde por lo general se anotan las citaciones y hospitalizaciones que se produzcan.

Los datos de identificación y el número de Historia Clínica se ingresarán a la Base de Datos de Inscritos del Consultorio.

Cada vez que el paciente concurra para atenderse en dicho establecimiento, deberá dirigirse en primer lugar al SOME, a no ser que tenga una citación a una unidad determinada y se le haya indicado que concurra directamente a ella. Generalmente en estos casos hay un funcionario que ejerce la función de admisión en esa unidad en especial

C. Citación o Dación de Hora en Consultorio

Todo Consultorio deberá contar con una Agenda Profesional, ubicada en el SOME, donde estén registrados los horarios, cupos y citaciones otorgadas del establecimiento.
Si no existe una Agenda computacional, deberán establecerse transitoriamente los registros manuales que cumplan con estos fines, hasta que se disponga de la solución computacional respectiva.

D. Dación y registro de hora en el SOME

Cada vez que un paciente concurre al Consultorio a solicitar atención de consulta profesional:

El funcionario del **SOME** revisará si hay cupos disponibles para que la persona sea atendida en esa misma jornada (mañana o tarde).

En el caso que se solicite alguna atención para un niño de 6 años o a un adulto de 60 años, el SOME deberá registrarlo en una Hoja Diaria APS como Caso en Espera de Atención en el Problema de Salud “Salud Oral Integral”, e ingresarlo posteriormente al SIGGES, con lo que se creará el caso AUGÉ.

* En aquellos casos de pacientes “en tránsito” o en proceso de reformulación de su condición previsional se deberá, igualmente, tener un procedimiento que permita realizar la atención y mantener la documentación clínica de la atención realizada.

- ❑ En caso afirmativo anotará la hora asignada en la agenda manual o computacional que esté en uso, y, en los casos en que sea necesario, completará un formulario ad hoc que entregará al paciente, donde deberá incluir el lugar y profesional que lo atenderá.
- ❑ Si no hay cupo para que el paciente se atienda en esa jornada, el funcionario de Admisión revisará en la Agenda Profesional los cupos de los días siguientes y conforme con la disponibilidad otorgará una citación, la que deberá ser registrada en el sistema computacional o manual que esté en uso, y en el formulario y/o carné que se entregue al paciente.
- ❑ Si los horarios disponibles en los periodos consultados no permiten asignar una hora para la atención, la solicitud de hora será registrada en la Agenda computacional o manual, para que quede en espera de citación.

La citación deberá otorgarse en la primera oportunidad en que se disponga de los horarios correspondientes, y será comunicada a la brevedad al paciente, según el medio más expedito disponible.

E. Ingreso de datos al SIGGES

Las citaciones deberán ser registradas en el **SIGGES o en el sistema computacional local** de acuerdo a como se haya establecido¹⁵, en lo posible el mismo día o antes de 48 horas¹⁶.

En el caso de Salud Oral, es necesario que tanto la solicitud de hora como la citación sean ingresada al SIGGES, lo que permitirá monitorear las alertas en el sistema.

F. Notificación

El SOME informará personalmente al paciente la fecha, lugar, hora, y nombre del profesional que lo atenderá, verbalmente y por escrito, en un documento donde registrará la citación. En ausencia del paciente se le notifica vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc.

II. Concurrencia a la citación

- ❑ El día de la citación, el SOME solicitará al Archivo las Historias Clínicas de los pacientes que se atenderán en esa fecha.
- ❑ Cuando el paciente concurre a atenderse, en la fecha y hora indicada, deberá dirigirse en primer lugar al SOME, con el comprobante de citación.
- ❑ El SOME registrará su asistencia en:
 - La Agenda profesional
 - El Informe Diario de Actividades del Profesional que lo atenderá.

15 Esto va a depender de la factibilidad de la comunicación que exista entre el SIGGES y el sistema computacional local, no siendo necesario registrar en los dos sistemas si existe esta comunicación establecida

16 Esta indicación está sujeta a la conectividad que presente el sistema computacional existente en el establecimiento y/o el SIGGES y deberá considerarse excluidos los días no laborales.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Se recomienda establecer en todos los establecimientos un sistema de registro de los casos en los cuales no se realizó la atención en la fecha en que el paciente fue citado, donde se especifiquen las causas por las cuales no se prestó la atención, tanto las atribuibles al paciente como al establecimiento.

El funcionario de Admisión remitirá a los pacientes que se atenderán a la Unidad Clínica de Atención, enviando las Historias Clínicas e Informes Diarios de Actividades correspondientes.

III. Paso por Recaudación (Sistema Actual)

- ❑ Después que el paciente obtiene la citación o indicación del lugar donde se va a atender, ya sea para la consulta de un profesional o cuando se le extiende una **Orden de Atención** para un Examen o Procedimiento, o se le da una Orden de Hospitalización, debe presentar los formularios respectivos a la Oficina de Recaudación del **SOME**.
- ❑ Este paso es previo a su atención; en la ventanilla correspondiente el paciente debe presentar su identificación, para que sea verificada su calidad de beneficiario y se timbren los formularios correspondientes.
- ❑ En algunos establecimientos se omite este paso por Recaudación en el caso de beneficiarios, pero no es una práctica generalizada.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Los repetidos pasos por Recaudación significan un aumento en la demora de la atención, una molestia para los pacientes y un gasto innecesario de horas-funcionario.

Es preciso mejorar el proceso, mediante una identificación adecuada del paciente una sola vez, que quede registrada y, adicionalmente, podría extenderse al paciente un documento probatorio, o bien un timbre autorizado en su carné, que baste para justificar su calidad de beneficiario.

Importante

Si el profesional tratante considera que el problema de salud puede ser resuelto a nivel primario, el paciente seguirá siendo citado para atenderse en el mismo consultorio, a no ser que él expresamente manifieste que desea su traslado a otro consultorio.

Si el Consultorio dispone de los medios y equipos necesarios para efectuar todos los exámenes y tratamientos que requiere el paciente por ese problema de salud, se seguirá atendiendo exclusivamente en ese lugar.

IV. Traslado a otro Consultorio

Un paciente puede solicitar su traslado a otro consultorio del mismo o de otro servicio de salud, por cambio de domicilio u otra razón. Si así lo solicita, deberá expresamente y por escrito renunciar a su atención en el lugar actual, donde se eliminará de la Base de datos de Inscritos del Consultorio actual. El Consultorio Actual deberá remitir los antecedentes de la Historia Clínica al nuevo establecimiento

Dado que no hay una base de datos de inscripción de los beneficiarios que sea compartida con el SIGGES, cuando se trate de un traslado de un paciente que tenga un caso activo en el establecimiento APS (en tratamiento o en seguimiento) junto al procedimiento habitual de traslado del paciente deberá confeccionarse una **Solicitud de Interconsulta o Derivación (SIC)**, consignando el o los problemas de salud GES que el paciente tengan dirigido al nuevo establecimiento, Solicitud que será registrada en el SIGGES por el establecimiento de origen de modo que el paciente quede asignado de este modo al nuevo establecimiento en el sistema. Con el o los documentos **Solicitud de Interconsulta o Derivación (SIC)** ingresados al SIGGES, el sistema automáticamente asignará la responsabilidad del caso al nuevo establecimiento APS. Se deben ingresar al SIGGES una SIC por cada caso GES-APS que el paciente tenga de modo que todos los casos GES de ese paciente queden asignados al nuevo establecimiento. Este procedimiento no será necesario una vez que las bases tengan comunicación en línea. Tal como se realiza en el procedimiento habitual de derivación, el establecimiento de origen debe informar del procedimiento realizado al establecimiento de destino de modo que este pueda monitorear adecuadamente los casos trasladados.

En ningún caso se deben cerrar los casos abiertos de las personas para el traslado.

Atenciones de Salud – Unidad Clínica

I. Unidades de atención de salud

El paciente puede ser atendido o recibir una prestación en un establecimiento de atención primaria de salud en los siguientes lugares:

- ☐ Un box de profesional para una consulta o control de salud
- ☐ Un box para tratamiento de profesional médico o paramédico
- ☐ Una Unidad de Apoyo Diagnóstico, donde se le efectúen exámenes de diversa índole
- ☐ Sala IRA – Sala ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto)
- ☐ Unidad de procedimiento terapéutico
- ☐ Un Pabellón, donde se le practique una intervención quirúrgica
- ☐ La farmacia, donde se le entreguen medicamentos o suplementos alimenticios.

II. Atención de Auxiliar Clínico

El paciente, después de recibir la indicación y/o citación del **SOME**, se dirigirá a la unidad donde se le indicó, para recibir la atención de consulta profesional.

En la unidad respectiva *podrá* existir un auxiliar clínico (funcionario paramédico o administrativo) que estará encargado de:

- ☐ Recibir a los pacientes
- ☐ Prepararlos (toma de presión, pulso, temperatura, etc.)
- ☐ Hacerlos pasar, en su oportunidad, al box profesional respectivo.
- ☐ Si un paciente concurre con una hora otorgada por el **SOME** y la unidad no ha recibido su historia clínica, el auxiliar clínico deberá reclamarla de inmediato al **SOME**, para que éste la envíe con un funcionario.
- ☐ El auxiliar clínico distribuirá las historias clínicas recibidas a los profesionales, en el orden en que deben ser atendidos los pacientes.
- ☐ Cada profesional revisará las historias clínicas y llamará a cada paciente personalmente o a través del auxiliar clínico.
- ☐ Si el paciente no asiste a la citación, deberá registrarse como inasistente en la hoja diaria, o en el registro que el establecimiento maneje para esto fines.

III. Consulta Profesional por un Problema de Salud Determinado

A. Primera consulta

El profesional:

- ☐ Examinará al paciente
- ☐ Obtendrá la información para la Anamnesis.
- ☐ Formulará una Hipótesis Diagnóstica o un Diagnóstico.
- ☐ Definirá si el paciente tiene un problema de salud GES u otro.
- ☐ Decidirá camino a seguir.
- ☐ Registrará en la historia clínica del paciente:
 - el resultado del examen clínico
 - el correspondiente diagnóstico o la hipótesis diagnóstica
 - las indicaciones de tratamiento
 - los exámenes que se solicitan
 - indicaciones de otro control
- ☐ Registrará la atención en el **Informe Diario de Actividades**, también llamada "**Hoja Diaria**". Este informe debe contener al menos la siguiente información:
 - Fecha: dd/mm/aaaa, correspondiente al día en que se produjo la atención, que corresponde al mismo día de llenado el formulario
 - RUN del paciente.
 - Nombre: del paciente.

- Problema de Salud: Cuando se trate de alguno de los problemas de salud deberá especificarse según se detalla en las páginas siguientes.

El profesional, deberá registrar en el documento, el momento en que toma la decisión de ya sea sospechar o confirmar o descartar un caso. Estos hitos pueden ser¹⁷:

- **Sospecha:** Para efectos de monitorear garantías, esta columna sólo aplica para los problemas AUGE de Hipertensión Arterial Esencial, Diabetes Mellitus Tipo 2, vicios de refracción, colecistectomía preventiva, depresión, asma bronquial, EPOC.
 - **Confirmación Diagnóstica o Descarte:** En este caso el profesional debe marcar el momento en que se produce la confirmación o el descarte del problema de salud previamente sospechado.
- ❑ Extenderá las prescripciones de los medicamentos indicados en el formulario ad hoc, el cual será entregado al paciente, para que se dirija a solicitarlos a la Farmacia del establecimiento.
 - ❑ Extenderá las **Órdenes de Atención** que sean necesarias, para solicitar los exámenes, procedimientos y otros tratamientos que deban efectuarse al paciente, ya sea en el mismo o en otro establecimiento. Asimismo deberá extender una Orden de Atención en el caso que se indique una hospitalización. Estas órdenes se anotarán en los formularios que para estos efectos haya establecido el establecimiento.
 - ❑ Evaluará la necesidad del concurso de un especialista, cuando el caso no pueda resolverse a nivel primario. En ese caso emitirá una Solicitud de Interconsulta o Derivación (Figura 2 Anexos).
 - ❑ Informará al paciente o a sus acompañantes según corresponda de las conclusiones y el plan de acción a seguir.

Si, de acuerdo con la hipótesis diagnóstica, existe una sospecha de que la patología corresponde a un problema de salud AUGE, se deberá distinguir entre aquellos casos que se tratan en el nivel primario y los casos que deben ser derivados a una especialidad.

1. Caso Auge Nivel Primario

- ❑ Verificará si el problema de salud se encuentra entre los siguientes, que deben resolverse en el Nivel Primario:
 - IRA baja
 - Neumonía adquirida en la comunidad
 - Diabetes Mellitus tipo 2
 - Hipertensión Arterial Esencial
 - Salud Oral
 - Asma
 - EPOC
 - Vicios de refracción (Presbicie)

17 Ver indicaciones de Registro en las UAPO para aquellos casos GES que son atendidos en ellos, en anexo

- Depresión (leve y moderada)
 - Órtesis
 - Tratamiento médico en personas de 55 años y más con Artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada.
- ❑ Si se trata de uno de estos problemas, **el profesional** deberá informar al usuario entregándole copia del Formulario de Constancia correspondiente, previamente firmada por él ¹⁸. La copia correspondiente al establecimiento debe ser archivada en la ficha o en el registro establecido en el establecimiento para este propósito.
 - ❑ Si se tratara de un paciente de **ISAPRE** se le deberá indicar que debe acudir a su seguro correspondiente para que se hagan efectivas las garantías a las cuales tiene derecho.
 - ❑ En caso de pacientes inscritos en el establecimiento y beneficiarios de **FONASA** (incluye a PRAIS) se deben registrar los siguientes datos en el **Formulario Informe Diario de Actividades** del Establecimiento el que al menos deberá contener la información detallada en la Nómina de Casos AUGÉ APS (Ver Anexo 3). Esta última es una sugerencia a utilizar en los establecimientos APS y SAPU:
 - Servicio de Salud
 - Establecimiento
 - Fecha de la consulta dd/mm/aaaa, correspondiente al día en que se produjo la atención, que corresponde al mismo día de llenado del formulario
 - RUN del paciente
 - Nombre y apellidos del paciente
 - Problema de salud de que se trata, con letra clara y sin abreviaturas
 - Hito de decisión: Se refiere a la consignación de la atención en que se produce la sospecha, la confirmación o el descarte del problema de salud GES:
 - ❑ **Sospecha:** Se debe consignar en aquella consulta o control en que por primera vez se sospecha un problema de salud GES. Para efectos de monitorear garantías, este dato sólo aplica en la APS para los problemas AUGÉ de Hipertensión Arterial Esencial, Diabetes Mellitus Tipo 2, Neumonía Adquirida en la Comunidad, Asma, EPOC, vicios de refracción, Colectomía preventiva. Ver en anexo las acciones de registro para el caso de las UAPO.
 - ❑ **Confirmación Diagnóstica o Descarte** Consignar en aquella consulta o control en la cual el profesional confirma o descarta el problema de salud AUGÉ. En el caso del problema IRA, esto ocurre en la primera consulta ya que no hay etapa de sospecha en el GES. En el Problema de Salud Oral del niño de seis años y del adulto de 60 años se registra en esta etapa en el momento en que el paciente solicita la atención en el establecimiento (fecha de la solicitud de la atención). Ver en anexo las acciones de registro para los casos de las UAPO.
 - ❑ **Nombre** del profesional o técnico que presta la atención.

18 La superintendencia estableció que esta notificación debe ser realizada por el prestador al momento de la confirmación. De este modo el establecimiento (que corresponde al prestador) es el responsable de la información al paciente la que puede ser realizada íntegramente por el profesional médico o odontólogo, o bien una vez establecido el diagnóstico la información de derechos y deberes puede ser realizado por otro funcionario del establecimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos a nivel local.

En los casos de IRA de niños menores de 5 años y Neumonías Comunitarias en mayores de 65 años que consulten en los servicios de Urgencia de Hospitales, el registro de esta atención se realizará en los establecimientos de APS, cuando el paciente se presente a continuar su tratamiento.

Para ello los servicios de Urgencia deberán entregar al paciente un informe que indique además de los datos de identificación del paciente (en especial el RUN) la fecha y hora de atención, el problema de salud y el diagnóstico específico, el tratamiento realizado en el establecimiento y la indicación de derivación.

Ese documento deberá ser entregado en el SOME del establecimiento APS al solicitar la atención, para que se ingresen los datos en el SIGGES utilizando la planilla definida para este fin, y devuelto posteriormente al paciente y asignándole esta atención al establecimiento de urgencia correspondiente.

- ❑ La atención o tratamiento recibidos en la **APS** se entenderán **como la continuación de la etapa anterior debiendo registrar en el SIGGES las prestaciones de Tratamiento y/o Kinesioterapia cuando corresponda.**
- ❑ Igualmente si el paciente no ha acudido al establecimiento APS en el tiempo indicado (definido por la garantía y el tratamiento entregado) se podrá ingresar los datos para la excepción de la garantía por causal atribuible al paciente (inasistencia) lo que deberá ser respaldado en la ficha.
- ❑ Los SAPUs siguen el mismo procedimiento de los establecimientos APS

Para fines del AUGE, las atenciones brindadas por el profesional kinesiólogo y el profesional odontólogo deberán ser entendidas como prestaciones, por lo que no deberán ser registradas en el SIGGES en la Planilla APS, sino que en el ingreso de prestaciones. Para ese ingreso se deberán utilizar los códigos de prestaciones definidos en el anexo Prestaciones Trazadoras

Los pacientes ISAPRE a los cuales se les haya detectado un problema de salud AUGE deberán acudir con el Formulario de Constancia, a su seguro correspondiente para que se hagan efectivas las garantías a las cuales tiene derecho.

2. Caso AUGE nivel de especialidad

Si el problema de salud del paciente beneficiario no se resuelve a Nivel Primario, el profesional deberá efectuar la derivación del paciente al establecimiento y la especialidad que corresponda según se haya definido en la red de derivaciones del establecimiento y servicio de salud correspondiente, para lo cual deberá:

- 1) Extender un Formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación, donde registrará los datos del establecimiento y de la especialidad de destino.
- 2) En dicho formulario deberá registrar, además del problema de salud AUGE, el subproblema correspondiente, en los siguientes casos (Ver Anexos):
 - Diabetes Mellitus 1 ¹⁹
 - Cáncer de mama
 - Disrafia espinal
 - Artrosis de cadera
- 3) Dicho Formulario deberá ser remitido de inmediato al SOME, junto con el paciente, para los trámites siguientes.

B. Resultado de los Exámenes de Apoyo Diagnóstico solicitados por el Nivel Primario.

- ☐ Los exámenes de apoyo al diagnóstico que se hayan solicitado en el nivel primario, podrán realizarse en el mismo establecimiento o en otro, según los recursos disponibles.
- ☐ La realización de los exámenes deberá ser registrada en el Informe diario de Actividades, y posteriormente remitido al **SOME** para el ingreso de las prestaciones realizadas. Si se ha establecido el procedimiento, estas podrán ser ingresadas en la unidad de apoyo diagnóstico debiendo para este fin regirse a las indicaciones y normas emanadas desde el **SOME**.
- ☐ Una vez realizados estos exámenes, el servicio clínico o de apoyo diagnóstico que los llevó a cabo remitirá un informe del resultado de cada uno de ellos al **SOME** del establecimiento de atención primaria que los solicitó.
- ☐ El **SOME** incorporará los resultados a la Historia Clínica del paciente
- ☐ Una vez completos los resultados, el **SOME** otorgará una citación para el profesional que los solicitó, comunicándola personalmente o por otra vía al paciente.

19 Corresponde marcar el sub problema Diabetes Mellitus 1, cuando se sospeche la patología y el paciente no esté presentando un episodio de descompensación. El sub problema Descompensación de Diabetes Mellitus 1 permite hacer el seguimiento de los episodios de descompensación de una persona, tenga o no confirmado previamente el caso de Diabetes Mellitus sub problema DM1.

C. Nuevas Consultas por el mismo problema de salud

El profesional del Consultorio, en las siguientes consultas:

- ☐ Examinará los resultados de los exámenes solicitados y del tratamiento indicado.
- ☐ Una vez que cuente con los elementos de juicio necesarios, formulará un Diagnóstico. En el caso de los problemas de salud AUGE esto corresponde al momento de la confirmación o el descarte del problema de salud GES que generó el proceso de diagnóstico. En el momento de confirmar se debe llenar el formulario de Constancia para el paciente²⁰.
- ☐ Decidirá si el paciente continúa tratándose en el nivel primario o será necesario la intervención de un especialista
- ☐ Si es preciso la concurrencia de un especialista, emitirá la Solicitud de Interconsulta o Derivación correspondiente.

ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AUGE

Una vez incorporado un paciente por sospecha de problema de salud AUGE, en todos los establecimientos se le dará atención cuidando de que se cumplan a cabalidad las garantías establecidas por la legislación respectiva.

El profesional que lo atienda, tendrá las siguientes obligaciones:

Anotar la consulta en el formulario APS, en el Informe Diario o en el formulario que haya establecido el establecimiento para estos fines, estampando cada vez los siguientes datos:

- ☐ Servicio de Salud
- ☐ Establecimiento
- ☐ Fecha de la consulta
- ☐ RUN del paciente
- ☐ Nombre y apellidos del paciente
- ☐ Problema de salud de que se trata, con letra clara y sin siglas
- ☐ Nombre del profesional o técnico que presta la atención
- ☐ Hito de Decisión:
 - Sospecha, cuando se genera la primera sospecha del problema de salud AUGE.
 - Confirmación diagnóstica o Descarte del problema AUGE: Una vez que se tengan los antecedentes suficientes para definir tomando en consideración las normas y los plazos establecidos por la legislación vigente.

20 La superintendencia estableció que esta notificación debe ser realizada por el prestador al momento de la confirmación. De este modo el establecimiento (que corresponde al prestador) es el responsable de la información al paciente la que puede ser realizada íntegramente por el profesional médico o odontólogo, o bien una vez establecido el diagnóstico la información de derechos y deberes puede ser realizado por otro funcionario del establecimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos a nivel local

D. Ingreso de datos de la consulta en el SOME:

- ❑ Será responsabilidad del **SOME** del Consultorio que se efectúe el ingreso al **SIGGES** o al sistema local en el caso de existir interfaz:
- ❑ En el caso de pacientes **AUGE**:
 - Los casos de niños de seis años y de adultos de 60 años que soliciten atención dental, serán ingresado en la Hoja APS, directamente por el SOME.
 - Todas las consultas, prestaciones de tratamiento (entrega de medicamentos, kinesioterapia, entrega de órtesis, etc.) ingresada desde el formulario de registro diario que el establecimiento haya implantado para este objeto.
 - Las órdenes de Atención para la realización de procedimientos al interior del establecimiento (ej Orden de Kinesioterapia Respiratoria, orden de entrega de lentes, orden de entrega de medicamentos HTA y DM2)
 - Las citaciones a prestaciones relacionadas a las alertas del monitoreo de garantías (citación a consulta odontológica)
 - Excepciones a las garantías cuando corresponda
 - Los cierres de casos (Los problemas IRA y Neumonía se cerrarán automáticamente cada 15 días, o cuando se presente un episodio nuevo)

En este momento se puede producir un cambio de estado en los pacientes AUGE de nivel primario, según el estado registrado en el formulario de registro.

IV. Solicitud de Interconsulta o Derivación

A. Emisión del formulario

Si se requiere que el paciente sea evaluado por algún especialista, el profesional llenará una Solicitud de Interconsulta o Derivación, que remitirá al SOME, junto con el paciente, para que se solicite la hora respectiva.

En este momento comienza la etapa de referencia.

Este formulario cuenta con tres partes:

- ❑ Datos del paciente.
- ❑ Datos clínicos.
- ❑ Datos del Profesional.

El profesional deberá anotar en primer lugar, en dicho formulario, el RUN y nombre del paciente, para su debida identificación. A continuación deberá llenar los Datos Clínicos y los Datos del Profesional.

Se debe tener presente que en ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados o modificados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

B. Solicitud de hora de Interconsulta

Después que el profesional tratante haya emitido un formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación, el paciente deberá dirigirse al SOME, para que se solicite la hora respectiva.

C. Ingreso de los Datos de la Solicitud de Interconsulta o Derivación

El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una Solicitud de Interconsulta o Derivación, deberá:

- ☐ Revisar el formulario y completar los datos de tipo administrativo que falten. **En ningún caso deberá llenar o cambiar los datos clínicos; si estos faltaran, se preocupará de devolver el formulario al profesional respectivo, para que los complete.**
- ☐ Revisar que el establecimiento de destino corresponde a la definición de la red del establecimiento.
- ☐ Ingresar al sistema computacional, SIGGES o al que disponga el establecimiento y que realice interfaz con el SIGGES, donde deberá digitar el RUN del paciente. Con este dato, el sistema consulta si la persona figura en la Base de Beneficiarios:

- Si la persona figura en dicha base, el sistema recupera los datos de identificación y los despliega en pantalla.
- Si la persona no figura en la base, el funcionario del SOME deberá ingresar sus datos en forma provisoria, verificando previamente la condición previsional del paciente en el Sistema respectivo.
- Si el paciente no cuenta con RUN, se ingresarán los datos en forma provisoria, para que sean actualizados cuando se disponga de dicho dato. Esto se realiza en la opción de ingreso de paciente sin RUN en el sistema. Una vez que el paciente obtenga su RUN, el dato debe actualizarse en la opción Cambiar RUN. La actualización de estos datos no debiera tardar más de un mes.
- En el caso de un recién nacido sin RUN, se deberá ingresar el RUN de la madre o padre beneficiarios, de preferencia el de la madre. Una vez obtenido el RUN del niño se deberá cambiar el dato utilizando la opción cambio de RUN.
- En el caso de las pacientes embarazadas que son derivadas por sospecha de cardiopatía o disrrafia en el no-nato, el caso debe creársele al niño no nacido y no a la madre. Para ello deberá crearse un paciente No-nato, al cual se le asignará el RUN y Apellidos de la madre y en el nombre se consignará NN. Se deberá incluir entre los datos la Fecha de Última Regla de la Madre (FUR).
- En otros casos se ingresarán los nombres del paciente, tal como están registrados en el **Formulario Solicitud de Interconsulta o Derivación.**

- ☐ El funcionario del **SOME** completará los datos locales del paciente.
- ☐ Los datos de la Base de Beneficiarios no podrán ser modificados.
- ☐ A continuación el funcionario del **SOME** ingresará los demás datos del Formulario Solicitud de Interconsulta o Derivación:
 - Datos clínicos
 - Datos del profesional

En este momento si el paciente presenta un problema de salud AUGE, queda en el sistema con un caso nuevo, en estado de “Sospechoso”, en la mayoría de los casos, aunque para algunos problemas de salud no se crea el caso a través de la Solicitud de Interconsulta o Derivación. (Ver Casos de Excepción)

D. Obtención de Citación

A nivel primario, lo normal es que la Interconsulta se solicite a otro establecimiento. Pero excepcionalmente puede existir la especialidad en el Consultorio.

- ☐ En ese caso se sugiere ingresar la Solicitud de Interconsulta o Derivación (SIC) igualmente pero destinada al mismo establecimiento que la solicita, para el cálculo de los tiempos de espera involucrados. En el caso que se envíe el paciente a un establecimiento del Extrasistema (Compra de Servicios por ejemplo a través del Programa de resolución de Listas de Espera) se deberá ingresar una Orden de Atención por la prestación Consulta Médica, al Extrasistema.
- ☐ En esos casos los pacientes serán asignados al establecimiento de origen de la **Orden de Atención**.
- ☐ El funcionario de Admisión del SOME, si está habilitado para ello, consultará computacionalmente la agenda Profesional de la especialidad respectiva del establecimiento de destino.
- ☐ Si no existe una Agenda Profesional computarizada en red, solicitará por el medio más efectivo, la citación al establecimiento de destino.

E. Registro de hora para Interconsulta

Si la citación se obtiene de inmediato, el funcionario del SOME registrará la fecha y hora correspondientes, en:

- ☐ La Agenda del establecimiento y/o especialidad de destino, según los medios de que se disponga.
- ☐ El **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario.

Si la citación es informada posteriormente por el establecimiento o especialidad de destino, será responsabilidad del SOME del establecimiento de origen efectuar los registros señalados en el punto 1.

Si el SOME de origen no se encuentra habilitado, deberá solicitar en el mismo establecimiento o en otro, vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva. En este

caso, el ingreso de la citación al SIGGES será obligación del establecimiento que administra los cupos de la especialidad respectiva.

F. Notificación al paciente de hora para Interconsulta

La citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:

- ☐ Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario ad-hoc
- ☐ Telefónicamente
- ☐ Por fax
- ☐ Por aviso al domicilio.

G. Envío de Formulario Solicitud de Interconsulta o Derivación

El **SOME** enviará el original del **Formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación** al establecimiento que recibe la Referencia por estafeta. **El paciente no debe transitar con el formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación;** la gestión es responsabilidad del SOME. La copia del documento deberá archivar en la ficha del paciente, o en el archivo que el establecimiento haya destinado para este fin.

V. Orden de Atención

A. Emisión del formulario

En los casos en que el profesional tratante considere necesario que se practique algún examen de apoyo al diagnóstico o algún procedimiento o tratamiento al paciente, el profesional deberá:

- ☐ Emitir una **Orden de Atención**, donde registrará las prestaciones respectivas. También se debe utilizar este formulario cuando se envía un paciente a una consulta en el extra sistema a través de la compra de servicio.

No corresponde utilizar una SIC en esos casos.

- ☐ Los datos mínimos que debe contener la Orden de Atención si esta debe ser ingresada al **SIGGES** son los siguientes:
- ☐ **Datos de Origen**
 - Fecha y hora de emisión de la Orden
 - Servicio de salud y Establecimiento de origen de la orden
 - Especialidad de Origen de la orden
- ☐ **Datos del Paciente**
 - RUN
 - Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
 - N° de Ficha Clínica

❑ **Datos Clínicos**

- Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGE
- Diagnóstico (s) en texto libre
- Establecimiento destino (incluye establecimientos privados)
- Especialidad Destino
- Prestaciones solicitadas
- Otra Indicación: en caso de no indicar una prestación, o de indicar que es necesario que el paciente pase a la etapa de seguimiento, para los casos AUGE.
- Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación (se requiere en algunos problemas de salud)

❑ **Datos Profesional Solicitante**

- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno Profesional Solicitante
- RUN Profesional Solicitante

B. Solicitud de hora para exámenes o procedimientos

- ❑ El paciente deberá concurrir al **SOME con la Orden de Atención**, con el objeto de que se le indique el lugar, fecha y hora en que se le efectuarán las prestaciones.
- ❑ La prestación puede otorgarse en la misma jornada o, al igual que con la consulta profesional, se le puede dar una citación.

C. Ingreso de los Datos

El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Orden de Atención**, que contenga prestaciones trazadoras según la definición oficial²¹, deberá ingresar los datos del formulario al sistema computacional, **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario del SIGGES, consignando la fecha y hora de la orden.

D. Obtención de Citación

El **SOME** verifica si está habilitado para otorgar hora en la Unidad de Apoyo o Especialidad donde debe efectuarse cada una de las prestaciones que figuran en la orden de atención.

Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al **SIGGES**.

Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar en el mismo establecimiento o en otro, vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.

La citación será ingresada al **SIGGES** por el **SOME** del establecimiento que administra los cupos.

²¹ Todos los años se envía desde el FONASA el listado actualizado de las prestaciones trazadoras de los problemas GES y de los programas especiales. En anexo está la lista vigente al mes de Octubre del año 2008

E. Registro de hora para examen o procedimiento

La hora correspondiente deberá ser registrada, por el funcionario del SOME del establecimiento que administra los cupos, en:

- ☐ La Agenda de la Unidad de Apoyo y establecimiento de destino, según los medios de que se disponga.
- ☐ El SIGGES, de acuerdo con el Manual del Usuario.

F. Información al paciente de hora para examen o procedimiento

La hora de citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:

- ☐ Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario ad hoc
- ☐ Telefónicamente
- ☐ Por fax
- ☐ Por aviso al domicilio.

VI. Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento

El paciente recibirá, durante su proceso de atención, en el establecimiento de origen o en otro donde haya sido referido, distintas prestaciones, que podrán consistir en exámenes, tratamiento, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.

El servicio clínico o de apoyo diagnóstico del mismo u otro establecimiento otorgará las prestaciones prescritas, registrándolas en el establecimiento que otorgó la prestación.

Importante

En el caso de aquellas prestaciones que sean realizadas en el sector privado a través de la compra de servicios, le corresponde al establecimiento que genera la orden de atención el registrar la prestación realizada, registrándolas en el establecimiento privado que otorgó la prestación. Para ello deberá establecer los procedimientos para que la información necesaria para el proceso de atención del paciente le sea remitida desde el centro privado.

A. Prestaciones a Pacientes AUGE: aspectos importantes a considerar

- La Unidad de Apoyo o Clínica que otorgue prestaciones de apoyo diagnóstico o tratamiento en el Consultorio, informará diariamente al **SOME** las prestaciones trazadoras **AUGE** que se hayan otorgado en el Consultorio.
- El **SOME** de cada Consultorio tendrá la tarea de registrar en el **SIGGES** todas las prestaciones trazadoras que se hayan otorgado a pacientes AUGE, conforme a la Lista de Prestaciones Trazadoras (Ver Anexo).
- Se debe registrar cuando se realiza algún tratamiento garantizado según Guías Clínicas. Este puede ser Tratamiento medicamentoso, Tratamiento kinésico en el caso de IRA Baja, Curación de Pie Diabético: en el caso de Diabetes Mellitus tipo 2, Consulta dental y tratamiento dental en el caso del problema Salud Oral.
- En el caso específico de los pacientes con Diabetes Mellitus 2 y/o Hipertensión Arterial Esencial, que no requieran inicialmente tratamiento con medicamentos, se considerará el registro del tratamiento médico (Indicaciones de dieta, ejercicios, etc.) como tratamiento del caso, y se ingresará por lo tanto en el SIGGES la prestación de tratamiento correspondiente. La entrega de Órtesis o lentes también deberá ser registrada como prestación otorgada.
- Si se ha establecido un procedimiento de traspaso de datos por interfaz, será obligación del SOME preocuparse por que este traspaso se efectúe en lo posible en forma diaria, o de acuerdo al protocolo establecido, y chequear la calidad de los datos resultantes.
- Las prestaciones realizadas a través de compra de prestaciones en establecimientos del Sector Privado, deberán ser ingresadas al SIGGES por el establecimiento que solicitó la prestación, asignándola a través de la opción "**compra extra sistema**" al establecimiento privado que realizó la prestación.
- En los casos en que no se ha podido realizar la prestación debido ya sea a causales atribuibles al paciente (rechazo de la prestación o del prestador designado; inasistencia a la prestación) o atribuibles al tratante (criterios de exclusión o indicación del tratante) estas deben ser registradas en los formularios establecidos en el establecimiento para estos fines y posteriormente ingresadas al **SIGGES** utilizando la funcionalidad de ingreso de Excepción de garantías.

Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el SIGGES

El Encargado de **SOME** – Estadística deberá revisar diariamente una muestra de las nóminas de cotejo de modo de ir verificando la calidad y oportunidad del registro.

La eliminación de registros erróneos deberá ser realizada por el encargado del establecimiento a quién se haya delegado esta tarea o deberá ser solicitada al **Monitor de Registro** encargado del SIGGES del Servicio de Salud Respectivo. Cada solicitud de eliminación de registros en el sistema deberá ser realizada en un formulario respectivo.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- ❑ El formulario deberá ser confeccionado por el establecimiento que ingresó el documento al sistema y que solicita la eliminación del evento o caso **GES**, completando todos los datos que le son requeridos.
- ❑ El formulario deberá identificar el nombre y apellido del **Monitor de Registro** del establecimiento que solicita la eliminación, Este puede ser respaldado por el **Sub Director Médico** del Hospital o Director de Consultorio APS, según corresponda, quien deberá refrendarlo con su nombre y firma.
- ❑ El formulario llevará un folio correlativo anual. **Formato: 0000/2005; 0000/2006**
- ❑ La eliminación se solicitará en forma inmediata a la detección del error.
- ❑ El formulario será remitido al **Monitor de Registro** vía e-mail o FAX al Departamento de Estadística e Información en Salud de la Dirección de Servicio de Salud. Además se oficiará la solicitud respectiva.
- ❑ Los establecimientos en los cuales se haya delegado la función de Eliminación desde el Servicio de Salud hacia el **Monitor de Registro** local deberán mantener los formularios respectivos en el Departamento de Estadística e Información en salud del propio establecimiento.
- ❑ El Departamento de Estadística e Información, mantendrá un archivo con numeración correlativa según orden de llegada de todas las solicitudes recepcionadas.
- ❑ El funcionario responsable de realizar la eliminación del evento o caso erróneo, deberá en primer término verificar el error informado revisando la **Cartola del Paciente en el SIGGES**.
- ❑ Verificado el error, procederá a eliminar el evento o caso GES requerido, dejando consignada en el formulario respectivo, el folio correlativo, la causa o motivo de la eliminación, la fecha de eliminación, el resultado del proceso, y las observaciones que estime pertinentes.
- ❑ En los casos en que el procedimiento sea realizado en el Servicio de Salud, este deberá informar al establecimiento del procedimiento ejecutado, detallando fecha de realización y resultado de la eliminación. Si el procedimiento resulta fallido deberá solicitar información a la mesa de Ayuda del SIGGES. La información al Establecimiento podrá ser enviada vía Fax o e-mail.
- ❑ Finalmente dejará archivada y bajo resguardo la solicitud procesada.
- ❑ Los establecimientos por su parte, deberán mantener archivados los formularios de eliminación de casos, los que podrán ser solicitados para revisiones en cualquier momento, para efectos de auditoría y otros. La responsabilidad de su resguardo es del **Monitor de Registro** del establecimiento, el archivo debe permanecer bajo resguardo según la normativa vigente por un período de 5 años.

El formulario debe contener al menos los siguientes campos:

- ☐ Servicio de Salud: indicar el Servicio de Salud al cual pertenece el establecimiento que solicita la eliminación.
- ☐ Establecimiento: corresponde al establecimiento que está solicitando la eliminación.
- ☐ Código Establecimiento: Registrar código de Establecimiento que solicita la Eliminación
- ☐ Fecha de Solicitud: corresponde a la fecha en que se solicita la eliminación
- ☐ RUN: corresponde al número de RUN del paciente.
- ☐ Si es Recién Nacido sin RUN, indicar el RUN de la madre o padre beneficiario con que haya sido ingresado al SIGGES
- ☐ Nombre del paciente: él o los nombres y apellidos del paciente con eventos o casos a eliminar
- ☐ Problema de Salud y sub problema: indicar a cuál de los problemas de salud en régimen, (si corresponde) se refiere la solicitud de eliminación anexo 1.
- ☐ Documento: Marcar el tipo de documento a eliminar:
- ☐ Indicar la fecha y el número de folio del documento a eliminar
- ☐ Marcar con una X la causa de la eliminación. En caso de marcar Otros especificar la causa.
- ☐ Fecha de eliminación: Registrar la fecha en que el funcionario del Departamento de Estadística eliminó el evento en SIGGES.
- ☐ Eliminación Exitosa: Marcar con una X si la eliminación fue exitosa
- ☐ Eliminación Fallida: Marcar con una X si la eliminación fue fallida
- ☐ Nombre y Firma del funcionario que ejecuta la eliminación: Auto explicativo.
- ☐ Fecha del informe al establecimiento: Registrar la fecha en que se le comunicó al Establecimiento la eliminación del evento solicitado.
- ☐ Observaciones: Indicar cualquier situación que estime conveniente indicar.

Excepción de prestaciones y garantías

Hay situaciones en las cuales una prestación **AUGE** garantizada no puede ser realizada. En el marco de la ley 19.966, decreto supremo N° 44, artículo 11 que señala: *"No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, casos fortuitos o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la Isapre"*.

Para tales efectos, se han definido como causales imputables al beneficiario:

- a) inasistencia
- b) la expresión de la voluntad del paciente o su representante de rechazar el prestador o el tratamiento.
- c) otra causa²²

22 En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando "fuerza mayor"

Para fines de funcionamiento del sistema público se entenderá que no se configura incumplimiento de garantía de oportunidad, cuando por algunas de las causales anteriormente señaladas como imputables al beneficiario, se justifique (documentadamente) la no realización o postergación de una prestación garantizada.

En esos casos el profesional tratante deberá consignar en la Historia Clínica las razones médicas que respaldan la decisión de no realizar una prestación garantizada.
Además deberá informar al **SOME**, para que éste pueda ingresar la información en el **SIGGES**. Para ello puede utilizarse el Formulario de Excepción de Garantía del anexo.)

La justificación deberá constar en documento específico para ello denominado "*Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación*" o Formulario de Excepción de Garantía (ver propuesta en anexo), y obligatoriamente deberá contener la firma del paciente o su representante. Dicho formulario tiene su correlato en el Sistema SIGGES.

Se define como inasistencia, la ausencia o no presentación del paciente o beneficiario a una citación formal y conocida por él para una prestación, asociada a un problema de salud GES.

No se entenderá incumplimiento de garantía de oportunidad GES, cuando el prestador documente la inasistencia del beneficiario, a través del citado formulario, a 2 citaciones en los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad mayores a 15 días (15 o más), y a 1 citación para los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad con plazos inferiores a 15 días (14 o menos).

CAPITULO III

Procedimientos Nivel de Especialidad

- *Trámite Administrativo Habitual.*
 - *Atención del Paciente Derivado.*
 - *Atenciones de Salud.*
 - *Solicitud de Interconsulta o Derivación.*
 - *Orden de Atención.*
 - *Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento.*
 - *Ingreso de los Datos al SIGGES*

Trámite Administrativo Habitual

Todo establecimiento de atención secundaria o terciaria deberá contar con una **Agenda Profesional** y una **Agenda de las Unidades de Apoyo Diagnóstico o Terapéutico**, ambas ubicadas en el **SOME**, donde estén registrados los horarios, cupos y citaciones otorgadas del establecimiento. Si no existen Agendas computacionales, deberán establecerse transitoriamente los registros manuales que cumplan con estos fines, hasta que se disponga de la solución computacional respectiva.

I. Atención del Paciente Derivado

A. Presentación del paciente derivado

- El paciente que ha sido referido por un Consultorio u otro establecimiento, ya sea para consulta de un especialista, o para una prestación de apoyo diagnóstico o terapéutico, deberá acudir el día de la citación, en primer lugar a la Oficina de Admisión del **SOME** (Sección de Orientación Médica y Estadística ²³), donde presentará la citación que le fue entregada.

23 En algunos establecimientos pueden existir varias oficinas que cumplan el rol de Admisión en diferentes unidades. Funcionalmente deben responder a las indicaciones y normas emanadas desde el SOME.

Los pacientes que llegan al SOME de atención secundaria o terciaria pueden provenir de un Consultorio o de un Servicio de Urgencia de Atención Primaria o secundario²⁴, que solicita una interconsulta, o bien exámenes o procedimientos. Por otra parte, también pueden provenir de una especialidad del mismo o de otro establecimiento. Otra opción es que el paciente acuda con una Orden de Atención de Hospitalización.

- Si el paciente es antiguo, el **SOME** previamente habrá solicitado su Historia Clínica, a partir de la agenda.
- Si el paciente es nuevo, el **SOME** le abrirá Historia Clínica, con su correspondiente Tarjeta Índice y Carné del Paciente²⁵.

□ El **SOME** registrará su asistencia:

En el caso de una Interconsulta:

- En la Agenda profesional de la especialidad respectiva.
- En el Informe Diario de Actividades del Profesional que lo atenderá.

En el caso de un examen o procedimiento:

- En la Agenda de la Unidad de Apoyo o Especialidad correspondiente, si está habilitado para ello.
- En el informe diario de Actividades de la Unidad de Apoyo correspondiente.

En el caso de una hospitalización:

- Registrará su ingreso a atención cerrada
- En el Informe Estadístico de Egreso de Hospitalización en su primera parte, dejando una copia en la oficina de Admisión de Atención Cerrada y archivando el original en la historia clínica del paciente.
- En el sistema computacional de atención cerrada o los registros manuales que existan para estos efectos.

□ En el caso de que un paciente no se presentara a la citación, el SOME o el profesional tratante deberá registrar la inasistencia en el Informe Diario de Actividades, o en el sistema que el establecimiento haya establecido para este fin

□ El funcionario de Admisión, remitirá a los pacientes que se atenderán según las siguientes opciones:

- A la Especialidad, en el caso de una Interconsulta, enviando la Solicitud correspondiente, Historia Clínica cuando corresponda e Informe Diario de Actividades del profesional.
- A la Unidad de Apoyo o Especialidad respectiva, cuando se trate de un examen o procedimiento.
- Al Servicio Clínico correspondiente, en el caso de una hospitalización.

²⁴ Si está determinado que ese flujo es posible en la respectiva red.

²⁵ Ver procedimiento en Capítulo de APS

B. Citación o Dación de Hora en Especialidad

1. Dación y registro de hora en el SOME de especialidad

- 1.- Después de la primera atención en un establecimiento de atención secundaria o terciaria, el paciente deberá concurrir al **SOME** con:
 - ☐ Las **Órdenes de Atención** que le haya extendido el especialista, indicando prestaciones de apoyo diagnóstico o tratamiento.
 - ☐ La indicación para que se le cite a control en la misma especialidad.
 - ☐ También puede darse el caso de que dicho profesional extienda una nueva Solicitud de Interconsulta o Derivación.
- 2.- Si el funcionario del **SOME** está habilitado para otorgar las citaciones respectivas, revisará en la **Agenda Profesional** los cupos de la misma jornada o de los días siguientes y conforme con la disponibilidad otorgará una citación, la que deberá ser registrada en el sistema computacional o manual que esté en uso, y en el formulario y/o carné que se entregue al paciente.
- 3.- Si el funcionario del **SOME** no está habilitado para otorgar las citaciones indicadas por el especialista, se comunicará por la vía más expedita con la especialidad o establecimiento que otorgue la atención, solicitando la hora.
- 4.- Si los horarios disponibles en los periodos consultados no permiten asignar una hora para la atención, la solicitud de hora será registrada en la Agenda computacional o manual, para que quede **en espera de citación**.

En todo caso, la citación deberá otorgarse en la primera oportunidad en que se disponga de los horarios correspondientes, y será comunicada a la brevedad al paciente, según el medio más expedito disponible.

2. Notificación

- ☐ El **SOME** informará personalmente al paciente la fecha, lugar, hora, y nombre del profesional que lo atenderá, verbalmente y por escrito, en un documento donde registrará la citación. En ausencia del paciente se le notificará vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc.

C. Paso por Recaudación (sistema actual)

- ☐ Después que el paciente obtiene la indicación del lugar donde se va a atender, ya sea para la consulta de un profesional o un Examen o Procedimiento, o para Hospitalización, debe presentar los formularios respectivos a la Oficina de Recaudación del **SOME**.

- ❑ Este paso es previo a su atención; en la ventanilla correspondiente el paciente debe presentar su identificación, para que sea verificada su calidad de beneficiario y se timbren los formularios correspondientes. En algunos establecimientos se ha establecido que no deben pasar por Recaudación los pacientes que presentan su credencial de beneficiarios, pero esta práctica no está generalizada.

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Los repetidos pasos por Recaudación significan un aumento en la demora de la atención, una molestia para los pacientes y un gasto innecesario de horas-funcionario. Es preciso mejorar el proceso, mediante una identificación adecuada del paciente una sola vez, que quede registrada y, adicionalmente, podría extenderse al paciente un documento probatorio, o bien un timbre autorizado en su carné, que baste para justificar su calidad de beneficiario.

Atenciones de Salud

I. Unidades de atención de salud

El paciente puede ser atendido o recibir una prestación en un establecimiento de atención secundaria o terciaria en los siguientes lugares:

- ❑ Un box de profesional para una consulta o control de salud
- ❑ Un box para tratamiento de profesional médico o paramédico
- ❑ Una Unidad de Apoyo Diagnóstico, donde se le efectúen exámenes de diversa índole
- ❑ Unidad de procedimiento terapéutico
- ❑ Un pabellón, donde se le practique una intervención quirúrgica
- ❑ La Farmacia, donde se le entreguen medicamentos o suplementos alimenticios.
- ❑ Un Servicio Clínico, en el caso de una hospitalización.

II. Atención de pacientes por la especialidad

El especialista recibe a un paciente con una Solicitud de Interconsulta o Derivación del nivel primario, pero también puede recibir una Solicitud enviada por otra especialidad del mismo o de otro establecimiento. Todas las atenciones deberán estar registradas en la respectiva Agenda que maneje el SOME del establecimiento.

A. Paciente acude a la especialidad para Interconsulta

- ❑ El Auxiliar Clínico de la Especialidad recibirá las Solicitudes de Interconsulta del SOME, junto con el Informe Diario de Actividades del Especialista, y las Historias Clínicas, cuando proceda.

- ❑ Hará pasar al paciente al box profesional, junto con la documentación.

B. Primera Atención del especialista por determinado problema de salud

El especialista que otorga la Interconsulta:

- ❑ Examinará los antecedentes registrados en la Solicitud de Interconsulta o Derivación por el profesional que la envió.
- ❑ Efectuará el examen clínico correspondiente.
- ❑ Formulará una Hipótesis Diagnóstica
- ❑ Decidirá camino a seguir.
- ❑ Responderá la Solicitud de Interconsulta o Derivación con el formulario de respuesta a interconsulta que se haya definido²⁶, en los siguientes casos:
 - El paciente no continuará tratamiento en la especialidad, porque se ha resuelto el problema.
 - El paciente deberá continuar su tratamiento en el establecimiento de origen.
 - En ese documento el especialista registrará Diagnóstico, fundamentos de éste, e indicaciones de tratamiento que deba continuarse en el nivel primario, o en la especialidad desde la cual se produjo la derivación.
 - Extenderá las Órdenes de Atención que sean necesarias, para solicitar los exámenes, procedimientos y otros tratamientos que deban efectuarse al paciente, ya sea en el mismo establecimiento o en otro establecimiento. Asimismo deberá extender una Orden de Atención en el caso que se indique una hospitalización. Estas órdenes se anotarán en los formularios que para estos efectos haya establecido el establecimiento.
 - Evaluará la necesidad del concurso de otro especialista, cuando el caso no pueda resolverse en ese nivel. En ese caso emitirá una nueva Solicitud de Interconsulta o Derivación.
 - Registrará la atención en el Informe Diario de Atenciones.

Importante

Si se trata de un caso de sospecha AUGÉ de resolución del nivel secundario, se deberá informar al usuario entregándole copia del *Formulario de Constancia* correspondiente, previamente firmada por él. La copia correspondiente al establecimiento deber ser archivada en la ficha o en el registro establecido en el establecimiento para este propósito. Si se tratara de un paciente ISAPRE se le deberá indicar que debe acudir a su seguro correspondiente para que se hagan efectivas las garantías a las cuales tiene derecho.

En caso de pacientes beneficiarios de FONASA (incluye a PRAIS) se anotará el problema de salud de que se trata en el *Informe Diario de Atenciones* y, en el caso en que se derive a otro establecimiento o especialidad, el lugar y la especialidad de destino.

26 Se puede considerar el uso del IPD como herramienta para la contrarreferencia de los casos. En otros casos puede realizarse una nueva solicitud de Interconsulta o derivación desde el especialista al origen del paciente

C. Resultados de los exámenes de apoyo diagnóstico

- ☐ El servicio clínico o de apoyo diagnóstico que realizó los exámenes solicitados por el especialista emitirá un informe de resultado de cada uno de ellos, remitiéndolo al SOME del establecimiento de especialidad.
- ☐ El SOME incorporará los resultados a la Historia Clínica del paciente.
- ☐ Una vez completos los resultados, el SOME otorgará hora de atención de especialista al paciente, comunicándosela personalmente o por otra vía.

III. Consultas siguientes por el mismo problema de salud

El profesional, en las siguientes consultas:

- ☐ Examinará los resultados de los exámenes solicitados y del tratamiento indicado.
- ☐ Una vez que dicho especialista cuente con los elementos de juicio necesarios, formulará un Diagnóstico.
- ☐ Decidirá si el paciente continúa tratándose en la Especialidad o vuelve al establecimiento de origen.

En el caso en que el paciente vuelva al establecimiento de origen, registrará en el formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación y en la historia clínica del paciente, si éste cuenta con dicha historia en el establecimiento: el Diagnóstico, sus fundamentos y las indicaciones impartidas para su tratamiento.

Si el paciente debe continuar su tratamiento en la Especialidad, el profesional:

- ☐ Dará indicaciones del tratamiento que deba realizarse, mediante las respectivas **Órdenes de Atención**.
- ☐ Solicitará los exámenes que sean necesarios para analizar su evolución, mediante Órdenes de Atención.
- ☐ Si es preciso la concurrencia de un profesional de otra especialidad, emitirá la **Solicitud de Interconsulta o Derivación** correspondiente.
- ☐ Si el paciente debe ser hospitalizado, el profesional extenderá la **Orden de Atención** que se use en el establecimiento para estos efectos.

Los datos mínimos que debe contener la Orden de Atención si esta debe ser ingresada al **SIGGES** son los siguientes:

Datos de Origen

- Fecha y hora de emisión de la Orden
- Servicio de salud y Establecimiento de origen de la orden
- Especialidad de Origen de la orden

Datos del Paciente

- RUN
- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
- N° de Ficha Clínica

Datos Clínicos

- Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGÉ
- Diagnóstico (s) en texto libre
- Establecimiento destino (incluye establecimientos privados)
- Especialidad Destino
- Prestaciones solicitadas
- Otra Indicación: en caso de no indicar una prestación, o de indicar que es necesario que el paciente pase a la etapa de seguimiento, para los casos AUGÉ.
- Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación (se requiere en algunos problemas de salud)

Datos Profesional Solicitante

- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno Profesional Solicitante
- RUN Profesional Solicitante.

IV. Atención de los Pacientes AUGÉ

69

Una vez incorporado un paciente por sospecha de problema de salud AUGÉ, en todos los establecimientos se le dará atención cuidando de que se cumplan a cabalidad las garantías establecidas por la legislación respectiva.

El especialista donde fue referido, tendrá las siguientes obligaciones:

- ☐ Informar el usuario entregándole copia del **Formulario de Constancia** correspondiente, previamente firmada por él²⁷. La copia correspondiente al establecimiento debe ser archivada en la ficha o en el registro establecido en el establecimiento para este propósito.
- ☐ Si se tratara de un paciente **ISAPRE** se le deberá indicar que debe acudir a su seguro correspondiente para que se hagan efectivas las garantías a las cuales tiene derecho.
- ☐ En caso de pacientes beneficiarios de **FONASA** (incluye a **PRAIS**) deberá extender el **Formulario de Informe Proceso Diagnóstico**, en el plazo que establece la ley, después de obtener los resultados de los exámenes necesarios de modo de contar con los elementos de juicio necesarios.

27 La superintendencia estableció que esta notificación debe ser realizada por el prestador al momento de la confirmación. De este modo el establecimiento (que corresponde al prestador) es el responsable de la información al paciente la que puede ser realizada íntegramente por el profesional médico o odontólogo, o bien una vez establecido el diagnóstico la información de derechos y deberes puede ser realizado por otro funcionario del establecimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos a nivel local

El especialista deberá registrar en dicho formulario, los siguientes datos:

- Identificación del paciente
- Datos clínicos, en particular si confirma o descarta que se trata del problema **AUGE** anotado en la **Solicitud de Interconsulta o Derivación**.
- Identificación del profesional
- El especialista deberá registrar, además de problema de salud AUGÉ, los subproblemas en los siguientes casos (Ver Anexo):
 - Cáncer cérvicouterino
 - Cardiopatía congénita
 - Infarto Agudo del Miocardio
 - Diabetes Mellitus 1
 - Cáncer de mama
 - Disrafia espinal
 - Tratamiento quirúrgico de las cataratas
 - Artrosis de cadera
 - Fisura labiopalatina
 - Cáncer en menores de 15 años
 - Cáncer de testículo en personas de 15 años o más
 - Prematurez
 - Leucemia del adulto
 - Tratamiento medico de Artrosis de Rodilla y/o Cadera
 - Politraumatizado grave (con o sin lesión medular)
- La copia de dicho formulario será remitido, junto con el paciente, al SOME, para su registro y trámites correspondientes. En el caso que el paciente deba volver a su establecimiento de origen ya sea por descarte del problema o para realizar su plan de tratamiento, este formulario será remitido al establecimiento correspondiente. El original se archivará en la Historia Clínica del paciente.
- En el caso de que el paciente no pueda recibir o deba posponer la realización de una prestación definida en el Protocolo o Guía Clínica y Garantizada en el AUGÉ debido a causales médicas, el profesional deberá registrar esta situación en la Ficha Clínica y /o en un Formulario establecido para esto. Esto deberá ser ingresado como causal de excepción de Garantía en el sistema.
- Extender el **Formulario de Cierre de Caso**, cuando se produzcan los eventos que así lo requieran. Como se ha indicado en la Primera Parte del Manual, el caso deja de estar activo por determinadas causas. Algunas de ellas deberán ser definidas por el especialista que esté tratando el caso, en tanto que otras, de carácter administrativo, deberán ser identificadas por el **SOME**.

El especialista deberá extender el Formulario de Cierre del Caso, en las siguientes circunstancias:

- Término de tratamiento
- Criterios de exclusión (por protocolo)
- Causas atribuibles al paciente:
 - Por rechazo del tratamiento
 - Otra causa expresada por el paciente

En cambio, las siguientes causas de cierre podrán ser establecidas por el SOME:

- Fallecimiento
- Término de tratamiento garantizado
- Cambio de previsión
- Causas atribuibles al paciente
- Por rechazo al prestador
- Otra causa expresada por el paciente
- Inasistencia

No se llenará el Formulario de Cierre de Caso, sino que el Informe Proceso Diagnóstico cuando se trate de Descarte.

Cuando la derivación no haya sido pertinente por parte del establecimiento de origen se debe llenar un formulario de cierre de caso con la causal, no cumple *criterios de inclusión*, de modo de diferenciar aquellas derivaciones pertinentes en que el caso se descarta de aquellas no pertinentes.

V. Seguimiento

- ❑ Una vez terminada la etapa de tratamiento, en algunos casos el paciente debe mantenerse en observación por un período determinado, según lo establezca el protocolo clínico.
- ❑ En esta etapa el paciente recibe prestaciones de diferente índole, especialmente controles, inclusive exámenes.

En este momento el caso pasa del estado de Tratamiento al estado de Seguimiento.

Para pasar un Caso a Seguimiento el profesional:

- ❑ Deberá emitir una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, con la indicación **A SEGUIMIENTO**, cuando éste deba hacerse en otro establecimiento.
- ❑ Si el seguimiento deberá efectuarse en el mismo establecimiento, deberá emitir una **Orden de Atención Especial** (que no implica prestaciones asociadas), que establezca explícitamente el cambio **A SEGUIMIENTO**.

CASO ESPECIAL:

En el caso de la esquizofrenia, puesto que no se considera que exista un término de tratamiento, los casos no pasan a seguimiento. Lo que puede ocurrir es que la persona continúe tratamiento en otro establecimiento, pero esto no afecta la condición del caso en el SIGGES, es decir, sigue siendo Caso en Tratamiento.

VI. Reingresos

El sistema SIGGES no considera reingresos. Los casos cerrados por cualquier causa, si vuelven a ser atendidos en un establecimiento del SNSS u otro, por ese mismo problema de salud, son considerados por el sistema como casos nuevos, debiéndose reiniciar el proceso.

VII. Solicitud de Interconsulta o Derivación

A. Emisión del formulario

- Si se requiere que el paciente sea evaluado por otro especialista, el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, que remitirá al **SOME**, junto con el paciente, para que se solicite la hora respectiva.

Si el especialista detectara por primera vez un caso AUGE (sospecha del problema de salud AUGE), que corresponde que sea derivado a otra especialidad, debe consignar en la SIC la sospecha, el problema y subproblema de salud AUGE.

Si el especialista detecta en una consulta de un paciente un problema de salud AUGE que no ha sido sospechado previamente y que corresponda seguir en la etapa de proceso de Diagnóstico en la misma especialidad, debe informar al SOME para que en el SIGGES se digite una Solicitud de Interconsulta que cree el caso respectivo. Si el establecimiento no tuviera un procedimiento establecido para que esta información llegue al SOME, el especialista deberá completar un formulario de Solicitud de Interconsulta para que se proceda a lo descrito anteriormente. Esta SIC se entenderá solo como un formulario de notificación de una sospecha de un caso AUGE por lo que no deberá generar el procedimiento de solicitud de hora ni citación correspondientes, y deberá ser registrada en el SIGGES para la creación del Caso respectivo.

- Este formulario cuenta con tres partes: Datos del paciente, Datos clínicos y Datos del Profesional.

En ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

B. Solicitud de hora de Interconsulta

Después que el especialista haya emitido un formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación, el paciente deberá dirigirse al SOME, para que se solicite la hora respectiva.

C. Ingreso de los Datos de la Solicitud de Interconsulta o Derivación.

El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, deberá:

- ❑ Revisar el formulario y completar los datos de tipo administrativo que falten.

En ningún caso deberá llenar o modificar los datos clínicos; si estos faltaran, se preocupará de devolver el formulario al profesional respectivo, para que los complete.

- ❑ Revisar que el establecimiento y la especialidad de destino corresponde a la definición de la red del establecimiento.
- ❑ Ingresar al sistema computacional, SIGGES, donde deberá digitar el RUN del paciente. El sistema recuperará los datos de identificación y los desplegará en pantalla.
 - Si la persona no figura en el SIGGES, el funcionario del SOME deberá ingresar sus datos en forma provisional.
 - Si el paciente no cuenta con RUN, se ingresarán los datos en forma provisional, para que sean actualizados cuando se disponga de dicho dato. Esto se realiza en la opción de ingreso de paciente sin RUN en el sistema.
 - En el caso de un recién nacido sin RUN, se deberá ingresar el RUN de la madre o padre beneficiarios, de preferencia el de la madre.
 - En el caso de las pacientes embarazadas que son derivadas por sospecha de cardiopatía o Disrafia en el no-nato, el caso debe creársele al niño no nacido y no a la madre.
 - Para ello deberá crearse un paciente No-nato, al cual se le asignará el RUN y Apellidos de la madre y en el nombre se consignará NN. Se deberá incluir entre los datos la Fecha de Última Regla de la Madre (FUR)
- ❑ El funcionario del SOME completará los datos locales del paciente. Los datos de la Base de Beneficiarios no pueden ser modificados.
- ❑ A continuación el funcionario del SOME ingresará los demás datos del Formulario Solicitud de Interconsulta o Derivación:
 - Datos clínicos
 - Datos del profesional

Con este registro se puede producir un cambio de estado, de Inicio al estado de Sospecha.

D. Obtención de Citación

- ❑ La Interconsulta puede solicitarse a otro establecimiento o a una especialidad del mismo establecimiento.
- ❑ El funcionario de Admisión del SOME, si está habilitado para ello, deberá consultar computacionalmente la Agenda Profesional de la especialidad respectiva del establecimiento de destino.
- ❑ Si no existe una Agenda Profesional computarizada en red, solicitará por el medio más efectivo, la citación al establecimiento de destino.

E. Registro de hora para Interconsulta

- ❑ Si la citación se obtiene de inmediato, el funcionario del **SOME** registrará la fecha y hora correspondientes, en:
 - La Agenda del establecimiento y/o especialidad de destino, según los medios de que se disponga.
 - El **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario.
- ❑ Si la citación es informada posteriormente por el establecimiento o especialidad de destino, será responsabilidad del SOME del establecimiento de origen efectuar los registros.
- ❑ Si el SOME de origen no se encuentra habilitado, deberá solicitar en el mismo establecimiento o en otro, vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.
- ❑ En este caso, el ingreso de la citación al SIGGES será obligación del establecimiento que administra los cupos de la especialidad respectiva.

F. Notificación al paciente de hora para Interconsulta

- ❑ La citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:
 - Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario ad hoc
 - Telefónicamente
 - Por fax
 - Por aviso al domicilio.

G. Envío de Formulario Solicitud de Interconsulta o Derivación

- ❑ Si la Interconsulta se ha solicitado a otro establecimiento, el **SOME** enviará el **Formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación** al establecimiento que recibe la Referencia por estafeta.
- ❑ La copia del Formulario debe ser archivada en la Historia Clínica del Paciente, o en los archivos que el establecimiento haya establecido para estos fines.
- ❑ Para efectos de derivación interregional o intercomunal, el formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación se envía por fax y el original por correo.

El paciente no debe transitar con el formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación. La gestión es responsabilidad del SOME

VIII. Orden de Atención

A. Emisión del formulario

- ❑ En los casos en que el especialista considere necesario que se practique algún examen de apoyo al diagnóstico o algún procedimiento o tratamiento al paciente, deberá emitir una **Orden de Atención**, donde registrará las prestaciones respectivas.
- ❑ Los datos mínimos que debe contener esta **Orden de Atención** si esta debe ser ingresada al SIGGES son los siguientes:
 - ❑ **Datos de Origen**
 - Fecha y hora de emisión de la Orden
 - Servicio de salud y Establecimiento de origen de la orden
 - Especialidad de Origen de la orden
 - ❑ **Datos del Paciente**
 - RUN
 - Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
 - N° de Ficha Clínica
 - ❑ **Datos Clínicos**
 - Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGÉ
 - Diagnóstico (s) en texto libre
 - Establecimiento destino (incluye establecimientos privados)
 - Especialidad Destino
 - Prestaciones solicitadas
 - Otra Indicación: en caso de no indicar una prestación, o de indicar que es necesario que el paciente pase a la etapa de seguimiento, para los casos AUGÉ.
 - Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación (se requiere en algunos problemas de salud)
 - ❑ **Datos Profesional Solicitante**
 - Nombres; Apellido Paterno; Apellido Materno; Profesional Solicitante
 - RUN Profesional Solicitante

B. Solicitud de hora para exámenes o procedimientos

- ❑ El paciente deberá concurrir al SOME con la Orden de Atención, con el objeto de que se le indique el lugar, fecha y hora en que se le efectuarán las prestaciones.
- ❑ La prestación puede otorgarse en la misma jornada o, al igual que con la consulta profesional, se le puede dar una citación.

C. Ingreso de los Datos

- ❑ El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Orden de Atención** que contenga prestaciones trazadoras, deberá ingresar los datos de dichas prestaciones al sistema computacional, SIGGES, de acuerdo con el Manual del Usuario del **SIGGES**, consignando la fecha y hora de la orden.

D. Obtención de Citación

- ❑ El SOME verifica si está habilitado para otorgar hora en la Unidad de Apoyo o Especialidad donde debe efectuarse cada una de las prestaciones que figuran en la orden de atención.
- ❑ Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al SIGGES.
- ❑ Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar en el mismo establecimiento o en otro, vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.
- ❑ La citación será ingresada al SIGGES por el SOME del establecimiento que administra los cupos.

E. Registro de hora para examen o procedimiento

- ❑ La hora correspondiente deberá ser registrada, por el funcionario del SOME del establecimiento que administra los cupos, en:
 - La Agenda de la Unidad de Apoyo y establecimiento de destino, según los medios de que se disponga.
 - El SIGGES, de acuerdo con el Manual del Usuario.

F. Información al paciente de hora para examen o procedimiento

- ❑ La hora de citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:
 - Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario *ad hoc*
 - Telefónicamente
 - Por fax
 - Por aviso al domicilio.

IX. Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento

El paciente recibirá, durante su proceso de atención, en el establecimiento de origen o en otro donde haya sido referido, distintas prestaciones, que podrán consistir en exámenes, tratamiento, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.

- ❑ El servicio clínico o de apoyo diagnóstico del mismo u otro establecimiento otorgará las prestaciones prescritas, registrándolas en el establecimiento que otorgó la prestación.
- ❑ En aquellos casos en que el establecimiento compre servicios en establecimientos del Extrasistema, le corresponderá registrar estas prestaciones al establecimiento que las solicitó, consignando que es una “compra de servicios” y el establecimiento del extrasistema que la realizó.

Prestaciones a Pacientes AUGE

- ❑ La Unidad de Apoyo o Clínica que otorgue prestaciones de apoyo diagnóstico o tratamiento, informará diariamente al SOME las prestaciones que se les haya realizado a pacientes AUGE, en especial las trazadoras AUGE que se hayan otorgado.
- ❑ El SOME de cada establecimiento tendrá la tarea de registrar en el SIGGES todas las prestaciones trazadoras que se hayan otorgado a pacientes AUGE, conforme a la Lista de Prestaciones Trazadoras.
- ❑ Si se ha establecido un procedimiento de traspaso de datos por interfaz, será obligación del SOME preocuparse por que este traspaso se efectúe en forma diaria y chequear la calidad de los datos resultantes.
- ❑ Las Unidades de Apoyo o Clínica que disponga de equipamiento, conectividad y capacidad de recurso humano de registro podrán ingresar los datos directamente al SIGGES, pero deberán someterse a las normas y procedimientos establecidos por el SOME, quién será responsable de la supervisión y fiscalización de estos procesos.

Excepción de prestaciones y garantías

Hay situaciones en las cuales una prestación **AUGE** garantizada no puede ser realizada. En el marco de la ley 19.966, decreto supremo N° 44, artículo 11 que señala: “No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, casos fortuitos o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la Isapre”.

Para tales efectos, se han definido como causales imputables al beneficiario:

- d) inasistencia
- e) la expresión de la voluntad del paciente o su representante de rechazar el prestador o el tratamiento.
- f) otra causa²⁸

28 En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando “fuerza mayor”

Para fines de funcionamiento del sistema público se entenderá que no se configura incumplimiento de garantía de oportunidad, cuando por algunas de las causales anteriormente señaladas como imputables al beneficiario, se justifique (documentadamente) la no realización o postergación de una prestación garantizada.

En esos casos el profesional tratante deberá consignar en la Historia Clínica las razones médicas que respaldan la decisión de no realizar una prestación garantizada.

Además deberá informar al **SOME**, para que éste pueda ingresar la información en el **SIGGES**. Para ello puede utilizarse el **Formulario de Excepción de Garantía** del anexo.)

La justificación deberá constar en documento específico para ello denominado “*Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación*”, y obligatoriamente deberá contener la firma del paciente o su representante. Dicho formulario tiene su correlato en el Sistema SIGGES.

Se define como inasistencia, la ausencia o no presentación del paciente o beneficiario a una citación formal y conocida por él para una prestación, asociada a un problema de salud GES.

No se entenderá incumplimiento de garantía de oportunidad GES, cuando el prestador documente la inasistencia del beneficiario, a través del citado formulario, a 2 citaciones en los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad mayores a 15 días (15 o más), y a 1 citación para los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad con plazos inferiores a 15 días (14 o menos).

Ingreso de los datos al SIGGES

I. Será obligación del SOME de especialidad:

Ingresar al SIGGES:

- ☐ Los datos de la Citación a Especialidad, en el caso excepcional en que no hubiera sido ingresada por el establecimiento de origen.
- ☐ Los datos de las **Solicitudes de Interconsulta** que hayan emitido los especialistas.
- ☐ Los datos de las Citaciones a Interconsulta solicitadas por profesionales del mismo establecimiento.
- ☐ Los datos de las **Órdenes de Atención de Prestaciones Trazadoras**.
- ☐ Las citaciones para Prestaciones Trazadoras.

En el caso de pacientes AUGÉ:

- ☐ Obtener la información necesaria y llenar el **Formulario de Cierre de Caso**, cuando dicha información no hubiera estado disponible para el profesional tratante.
- ☐ Ingresar al **SIGGES**:
 - Los datos del Formulario Informe Proceso Diagnóstico.

- Los datos del Formulario de Cierre de Caso.
- Los datos del Formulario de Creación de Caso.
- Los datos de las Excepciones de las Garantías.

II. Será obligación del SOME del establecimiento que efectuó las prestaciones:

Ingresar al SIGGES:

- ☐ Los datos de las Prestaciones Trazadoras.

En aquellos casos en que la prestación sea realizada por un establecimiento del extrasistema, las prestaciones deberán ser registradas por el establecimiento que solicitó las prestaciones. Para ello se deberá establecer un procedimiento a través del cual el establecimiento del extrasistema informe de las prestaciones realizadas con el detalle y frecuencia que el establecimiento requiera.

Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el SIGGES

- ☐ El Encargado de **SOME** – Estadística deberá revisar diariamente una muestra de las nóminas de cotejo de modo de ir verificando la calidad y oportunidad del registro.
- ☐ La eliminación de registros erróneos deberá ser realizada por el encargado del establecimiento a quién se haya delegado esta tarea o deberá ser solicitada al Monitor de Registro del Servicio de Salud Respectivo.
- ☐ Cada solicitud de eliminación de registros en el sistema deberán ser realizadas en el formulario correspondiente.

Para ello deben considerarse los siguientes pasos:

1. El formulario deberá ser confeccionado por el establecimiento que ingresó el documento al sistema y que solicita la eliminación del evento o caso GES, completando todos los datos que le son requeridos.
2. El formulario deberá identificar el nombre y apellido del Monitor de registro del establecimiento que solicita la eliminación, Este puede ser respaldado por el Sub Director Médico del Hospital o Director de Consultorio APS, según corresponda, quien deberá refrendarlo con su nombre y firma.
3. El formulario llevará un folio correlativo anual. Formato: 0000/2005; 0000/2006
4. La eliminación se solicitará en forma inmediata a la detección del error.
5. El formulario será remitido al Monitor de registro vía e-mail o FAX al Departamento de Estadística e Información en Salud de la Dirección de Servicio de Salud. Además se oficiará la solicitud respectiva.
6. Los establecimientos en los cuales se haya delegado la función de Eliminación desde el Servicio de Salud hacia el Monitor de registro local deberán mantener los formularios respectivos en el Departamento de Estadística e Información en salud del propio establecimiento.

7. El Departamento de Estadística e Información, mantendrá un archivo con numeración correlativa según orden de llegada de todas las solicitudes recepcionadas.
8. El funcionario responsable de realizar la eliminación del evento o caso erróneo, deberá en primer término verificar el error informado revisando la Cartola del Paciente en el SIGGES.
9. Verificado el error, procederá a eliminar el evento o caso GES requerido, dejando consignada en el formulario respectivo, el folio correlativo, la causa o motivo de la eliminación, la fecha de eliminación, el resultado del proceso, y las observaciones que estime pertinentes.
10. En los casos en que el procedimiento sea realizado en el Servicio de Salud, este deberá informar al establecimiento del procedimiento ejecutado, detallando fecha de realización y resultado de la eliminación. Si el procedimiento resulta fallido deberá a la Mesa de Ayuda del SIGGES. La información al Establecimiento podrá ser enviada vía Fax o e-mail.
11. Finalmente dejará archivada y bajo resguardo la solicitud procesada.
12. Los establecimientos por su parte, deberán mantener archivados los formularios de eliminación de casos, los que podrán ser solicitados para revisiones en cualquier momento, para efectos de auditoría y otros. La responsabilidad de su resguardo es del Monitor de registro del establecimiento, el archivo debe permanecer bajo resguardo según la normativa vigente por un período de 5 años.

El formulario debe contener al menos los siguientes campos:

1. Servicio de Salud: indicar el Servicio de Salud al cual pertenece el establecimiento que solicita la eliminación.
2. Establecimiento: corresponde al establecimiento que está solicitando la eliminación.
3. Código Establecimiento: Registrar código de Establecimiento que solicita la Eliminación
4. Fecha de Solicitud: corresponde a la fecha en que se solicita la eliminación
5. RUN: corresponde al número de RUN del paciente.
6. Si es Recién Nacido sin RUN, indicar el RUN de la madre o padre beneficiario con que haya sido ingresado al SIGGES
7. Nombre del paciente: él o los nombres y apellidos del paciente con eventos o casos a eliminar
8. Problema de Salud y subproblema: indicar a cuál de los problemas de salud en régimen, (si corresponde) se refiere la solicitud de eliminación anexo 1.
9. Documento: Marcar el tipo de documento a eliminar:
10. Indicar la fecha y el número de folio del documento a eliminar
11. Marcar con una X la causa de la eliminación. En caso de marcar Otros especificar la causa.
12. Fecha de eliminación: Registrar la fecha en que el funcionario del Departamento de Estadística eliminó el evento en SIGGES.
13. Eliminación Exitosa: Marcar con una X si la eliminación fue exitosa
14. Eliminación Fallida: Marcar con una X si la eliminación fue fallida
15. Nombre y Firma del funcionario que ejecuta la eliminación: Auto explicativo.
16. Fecha del informe al establecimiento: Registrar la fecha en que se le comunicó al Establecimiento la eliminación del evento solicitado.
17. Observaciones: Indicar cualquier situación que estime conveniente señalar.

CAPITULO IV

Procedimientos Atención Cerrada

- *Unidades de Atención de Salud.*
- *Atención Profesional de Pacientes Hospitalizados.*
- *Registros SIGGES de Pacientes Hospitalizados*
- *Ingreso de los Datos de Pacientes hospitalizados.*

Unidades de atención de salud

El paciente puede ser atendido o recibir una prestación en un establecimiento de atención cerrada en los siguientes lugares:

- ☐ Una Unidad de Apoyo Diagnóstico, donde se le efectúen exámenes de diversa índole.
- ☐ Unidad de procedimiento terapéutico.
- ☐ Un pabellón, donde se le practique una intervención quirúrgica.
- ☐ La Farmacia, donde se le entreguen medicamentos o suplementos alimenticios.
- ☐ Un Servicio Clínico.

Atención Profesional de Pacientes Hospitalizados

- ☐ El profesional de un Servicio Clínico, cuando efectúa las visitas o tratamientos de los pacientes hospitalizados, deberá proceder en la siguiente forma, respecto de los casos **AUGE**:

I. Detección de Caso nuevo AUGÉ

- ☐ Si se trata de una primera sospecha de caso AUGÉ, emitirá una Solicitud de Interconsulta, de modo de detectar esta sospecha de un problema de salud que se presenta mayoritariamente en un establecimiento Cerrado. Por ejemplo en los casos de Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido
- ☐ Si se trata de un diagnóstico que ya esté confirmado, emitirá un Informe Proceso Diagnóstico.

II. Paciente con un problema de salud AUGE que es hospitalizado:

El profesional tratante del Servicio Clínico respectivo deberá llenar, en los casos en que proceda, los siguientes formularios de:

- ❑ **Informe Proceso Diagnóstico**, para registrar la confirmación o descarte del problema de salud AUGE.
- ❑ **Cierre del Caso**, en la eventualidad de que se presente alguna de las causales señaladas para que se produzca este evento.
- ❑ **Órdenes de atención** que sean necesarias, para solicitar los exámenes, procedimientos y otros tratamientos que deban efectuarse al paciente, ya sea en el mismo o en otro establecimiento.
- ❑ **Excepciones de garantías**²⁹: la no realización de una determinada atención puede ser justificada en un formulario específico o en una forma definida en el procedimiento local. Siempre debe existir información en la ficha clínica que permita justificar la decisión tomada por el profesional

Estas órdenes se anotarán en los formularios que para estos efectos haya establecido el establecimiento.

Todos los originales de estos Formularios deberán ser archivados en la Historia Clínica del paciente, o en los archivos que el establecimiento haya destinado con este fin.

Para ello, el profesional especialista tratante, tendrá las siguientes obligaciones:

- ❑ informar el usuario entregándole copia del Formulario de Constancia correspondiente³⁰, previamente firmada por él. La copia correspondiente al establecimiento deber ser archivada en la ficha o en el registro establecido en el establecimiento para este propósito.
- ❑ Si se tratara de un pacientes **ISAPRE** se le deberá indicar que debe acudir a su seguro correspondiente para que se hagan efectivas las garantías a las cuales tiene derecho
- ❑ En caso de pacientes beneficiarios de FONASA (incluye a PRAIS) Extender el Formulario de Informe Proceso Diagnóstico en el plazo que establece la ley, después de obtener los resultados de los exámenes necesarios de modo de contar con los elementos de juicio necesarios. Para ello el especialista deberá registrar en dicho formulario, los siguientes datos:

29 En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando "fuerza mayor"

30 La superintendencia estableció que al momento de confirmar se debe notificar al paciente en un formulario de Constancia GES. Esta notificación debe ser realizada por el prestador al momento de la confirmación. De este modo el establecimiento (que corresponde al prestador) es el responsable de la información al paciente la que puede ser realizada íntegramente por el profesional médico o odontólogo, o bien una vez establecido el diagnóstico la información de derechos y deberes puede ser realizado por otro funcionario del establecimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos a nivel local. Ordinario MINSAL C26 N° 1980 del 12 de Junio del 2008, y ordinario C26 N° 394, del 01 de febrero del 2008

- Identificación del paciente
 - Datos clínicos, en particular si confirma o descarta que se trata del problema **AUGE** anotado en la **Solicitud de Interconsulta o Derivación**.
 - Identificación del profesional
- ❑ El especialista deberá registrar, además de problema de salud AUGÉ, los subproblemas en los siguientes casos:
- Cáncer cérvicouterino
 - Cardiopatía congénita
 - Infarto Agudo del Miocardio
 - Diabetes Mellitus 1
 - Cáncer de mama
 - Disrafia espinal
 - Tratamiento quirúrgico de las cataratas
 - Artrosis de cadera
 - Fisura labiopalatina
 - Cáncer en menores de 15 años
 - Cáncer de testículo en personas de 15 años o más
 - Prematurez
 - Leucemia
 - Politraumatismo
 - Artrosis de cadera o rodilla leve o moderada.
 - Politraumatizado Grave
 - Leucemia en personas mayores de 15 años
- ❑ La copia de dicho formulario será remitido, al **SOME**, para su registro correspondientes. En el caso que el paciente una vez producido el egreso, deba volver a su establecimiento de origen ya sea por descarte del problema o para realizar su plan de tratamiento, este formulario será remitido al establecimiento correspondiente. El original se archivará en la Historia Clínica del paciente
- ❑ EN el caso de que el paciente no pueda recibir o deba posponer la realización de una prestación definida en el Protocolo o Guía Clínica y Garantizada en el AUGÉ debido a causales médicas, el profesional deberá registrar esta situación en la Ficha Clínica y /o en un Formulario establecido para esto. Esto deberá ser ingresado como causal de Excepción de Garantía en el sistema
- ❑ Cuando se autorice el egreso del paciente, el profesional deberá emitir una **Orden de Atención para el seguimiento** (control ambulatorio post alta), si el control ambulatorio se realizará en el mismo establecimiento, o bien **una Solicitud de Interconsulta o Derivación de seguimiento**, si este control se realizará en otro establecimiento de salud.
- ❑ Extender el **Formulario de Cierre de Caso**, cuando se produzcan los eventos que así lo requieran.

Como se ha indicado en la Primera Parte del Manual, el caso deja de estar activo por determinadas causas. Algunas de ellas deberán ser definidas por el especialista que esté tratando el caso, en tanto que otras, de carácter administrativo, deberán ser identificadas por el SOME.

- ❑ El especialista deberá extender el **Formulario de Cierre del Caso**, en las siguientes circunstancias:
 - a) Término de tratamiento
 - b) Criterios de exclusión (por protocolo)
 - c) Causas atribuibles al paciente
 - Por rechazo del tratamiento
 - Otra causa expresada por el paciente

En cambio, las siguientes causas de cierre podrán ser establecidas por el SOME:

- Fallecimiento
- Término de tratamiento garantizado
- Cambio de previsión
- Causas atribuibles al paciente
 - Por rechazo al prestador
 - Otra causa expresada por el paciente
 - Inasistencia

IMPORTANTE

No se llenará el Formulario de Cierre de Caso, sino que el Informe Proceso Diagnóstico cuando se trate de Descarte del problema de salud.

Cuando la derivación no haya sido pertinente por parte del establecimiento de origen se debe llenar un formulario de cierre de caso con la causal, no cumple criterios de inclusión, de modo de diferenciar aquellas derivaciones pertinentes en que el caso se descarta de aquellas no pertinentes..

Caso de Recién Nacido

- ❑ El profesional del Servicio de Obstetricia deberá informar sobre los pacientes recién nacidos que presenten los siguientes problemas:
 - Prematurez
 - Disrafia abierta
- ❑ Según el problema de salud deberá completar los formularios de Solicitudes de Interconsultas o Derivación que permitirán, al ser registrados en el SIGGES la creación de los casos respectivos. (Retinopatía del prematuro, Hipoacusia del prematuro; Disrafia Abierta)
- ❑ El profesional además de los datos del formulario deberá consignará los siguientes datos:
 - Edad gestacional al nacer
 - Peso y talla al nacer
- ❑ El profesional del Servicio Clínico hará entrega de los formularios que haya emitido sobre casos AUGÉ al profesional o auxiliar clínico que se haya designado para su tramitación.

Todos los hospitales deberán establecer, en cada Servicio Clínico, el procedimiento de recolección de los formularios necesarios para el SIGGES:
Solicitud de Interconsulta o Derivación, Informe Proceso Diagnóstico, Cierre de Caso, Orden de Atención, Excepción de Garantías y Creación de Caso.

Además, deberá existir un sistema especial de registro de las prestaciones trazadoras

- ❑ Deberá asignarse la responsabilidad de llevar los registros de prestaciones trazadoras y los formularios, así como su entrega diaria al **SOME**, para el ingreso al **SIGGES**, ya sea a la secretaria del Servicio Clínico, o bien a un auxiliar clínico o profesional, según sean las características del establecimiento.
- ❑ El funcionario encargado de los registros AUGES en la Unidad Clínica:
 - a) recopilará diariamente los formularios del SIGGES que hayan llenado los distintos profesionales.
 - b) Registrará las prestaciones trazadoras que se hayan otorgado en el Servicio Clínico.
 - c) Entregará diariamente los formularios y registros al SOME, para su ingreso al SIGGES.

III. Solicitud de Interconsulta o Derivación

A. Emisión del formulario

- ❑ Si se requiere que el paciente sea evaluado por otro especialista, el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, que remitirá al **SOME**, para que se solicite la concurrencia del profesional solicitado y se registre esta solicitud en el SIGGES.
- ❑ Este formulario cuenta con tres partes: Datos del paciente, Datos clínicos y Datos del Profesional.

En ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados o modificados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

- ❑ Se llenará una Solicitud de Interconsulta o Derivación con indicación de "A seguimiento" cuando se autorice el egreso del paciente y el control ambulatorio deba realizarse en otro establecimiento.

B. Ingreso de los Datos

- ❑ El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Solicitud de Interconsulta** deberá ingresar los datos al sistema computacional, **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario del **SIGGES**, consignando la fecha y hora de la solicitud.

C. Obtención de Citación

- ☐ En el caso de un Solicitud de Interconsulta para un paciente Hospitalizado, el SOME deberá verificar si está habilitado para otorgar hora para un profesional de la Unidad de Apoyo o Especialidad.
- ☐ Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al SIGGES.
- ☐ Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.
- ☐ En el caso de un Solicitud de Interconsulta "a seguimiento" para un paciente a quién se le autorizado el egreso Hospitalizado, el SOME deberá verificar si está habilitado para otorgar hora para un profesional de la Unidad de Apoyo o Especialidad del establecimiento correspondiente.
- ☐ Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al SIGGES.
- ☐ Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.

D. Registro de hora para Consulta

La hora correspondiente deberá ser registrada, por el funcionario del **SOME** del establecimiento que administra los cupos, en:

- ☐ La Agenda de la Unidad de Apoyo y establecimiento de destino, según los medios de que se disponga.
- ☐ El **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario.

E. Información al paciente de hora para Consulta

La hora de citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:

- ☐ Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario *ad hoc*
- ☐ Telefónicamente
- ☐ Por fax
- ☐ Por aviso al domicilio.

IV. Orden de Atención

A. Emisión del formulario

- ☐ En los casos en que el especialista considere necesario que se practique algún examen de apoyo al diagnóstico o algún procedimiento o tratamiento al paciente, hospitalizado deberá emitir una Orden de Atención, donde registrará las prestaciones respectivas.
- ☐ Los datos mínimos que debe contener esta Orden de Atención si esta debe ser ingresada al SIGGES son los siguientes:

❑ **Datos de Origen**

- Fecha y hora de emisión de la Orden
- Servicio de salud y Establecimiento de origen de la orden
- Especialidad de Origen de la orden

❑ **Datos del Paciente**

- RUN
- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
- N° de Ficha Clínica

❑ **Datos Clínicos**

- Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGE
- Diagnóstico (s) en texto libre
- Establecimiento destino (incluye establecimientos privados)
- Especialidad Destino
- Prestaciones solicitadas
- Otra Indicación: en caso de no indicar una prestación. o de indicar que es necesario que el paciente pase a la etapa de seguimiento, para los casos AUGE.
- Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación (se requiere en algunos problemas de salud)

❑ **Datos Profesional Solicitante**

- Nombres; Apellido Paterno; Apellido Materno; Profesional Solicitante
- RUN Profesional Solicitante

B. Ingreso de los Datos

El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Orden de Atención** que contenga prestaciones trazadoras, deberá ingresar los datos de dichas prestaciones al sistema computacional, **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario del **SIGGES**, consignando la fecha y hora de la orden.

C. Obtención de Citación

- ❑ El SOME verifica si está habilitado para otorgar hora en la Unidad de Apoyo o Especialidad donde debe efectuarse cada una de las prestaciones que figuran en la orden de atención.
- ❑ Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al SIGGES.
- ❑ Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.
- ❑ La citación será ingresada al **SIGGES** por el **SOME** del establecimiento que administra los cupos.

D. Registro de hora para examen o procedimiento

La hora correspondiente deberá ser registrada, por el funcionario del **SOME** del establecimiento que administra los cupos, en:

- ☐ La Agenda de la Unidad de Apoyo y establecimiento de destino, según los medios de que se disponga.
- ☐ El **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario.

E. Información al paciente de hora para examen o procedimiento

- ☐ Se deberá informar al paciente al momento del egreso las citaciones ya sea estas en el mismo establecimiento o en el establecimiento al que sea remitido. Estas deberán incluirse en el carné de Alta del paciente.

V. Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento

El paciente recibirá, durante su proceso de atención en el establecimiento distintas prestaciones, que podrán consistir en exámenes, tratamiento, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.

- ☐ El servicio clínico o de apoyo diagnóstico otorgará las prestaciones prescritas, y las registrará en el sistema correspondiente.
- ☐ En el caso de las consultas de especialistas realizadas a pacientes hospitalizados, estas deberán ser registradas en el Informe Diario de Atenciones del Servicio Clínico correspondiente, y remitidas diariamente al **SOME** para ser digitadas en el SIGGES.
- ☐ En aquellos casos en que el establecimiento compre servicios en establecimientos del Extrasistema, le corresponderá registrar estas prestaciones al establecimiento que las solicitó, consignando que es una “compra de servicios” y el establecimiento del extrasistema que la realizó.

Excepción de prestaciones y garantías

Hay situaciones en las cuales una prestación **AUGE** garantizada no puede ser realizada. En el marco de la ley 19.966, decreto supremo N° 44, artículo 11 que señala: “No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, casos fortuitos o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la Isapre”.

Para tales efectos, se han definido como causales imputables al beneficiario:

- g) inasistencia
- h) la expresión de la voluntad del paciente o sus representantes de rechazar el prestador o el tratamiento.
- i) otra causa³¹

31 En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando “fuerza mayor”

Para fines de funcionamiento del sistema público se entenderá que no se configura incumplimiento de garantía de oportunidad, cuando por algunas de las causales anteriormente señaladas como imputables al beneficiario, se justifique (documentadamente) la no realización o postergación de una prestación garantizada.

En esos casos el profesional tratante deberá consignar en la Historia Clínica las razones médicas que respaldan la decisión de no realizar una prestación garantizada.

Además deberá informar al **SOME**, para que éste pueda ingresar la información en el **SIGGES**. Para ello puede utilizarse el **Formulario de Excepción de Garantía** del anexo.)

La justificación deberá constar en documento específico para ello denominado "*Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación*", y obligatoriamente deberá contener la firma del paciente o su representante. Dicho formulario tiene su correlato en el Sistema SIGGES.

Se define como inasistencia, la ausencia o no presentación del paciente o beneficiario a una citación formal y conocida por él para una prestación, asociada a un problema de salud GES.

No se entenderá incumplimiento de garantía de oportunidad GES, cuando el prestador documente la inasistencia del beneficiario, a través del citado formulario, a 2 citaciones en los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad mayores a 15 días (15 o más), y a 1 citación para los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad con plazos inferiores a 15 días (14 o menos).

Ingreso de los datos de Pacientes Hospitalizados

El SOME de cada hospital deberá encargarse de:

- ☐ Recopilar diariamente los formularios para su ingreso al SIGGES.
- ☐ Obtener la información de las prestaciones trazadoras otorgadas por los Servicios Clínicos.
- ☐ Obtener de las Maternidades los casos AUGÉ de recién nacidos.
- ☐ Ingresar al SIGGES:
 - Los datos de los distintos formularios del sistema.
 - Los datos de las prestaciones trazadoras otorgadas en los Servicios Clínicos, incluidas las intervenciones quirúrgicas.
- ☐ Registrar Los días de estada de los pacientes AUGÉ en los casos en que las prestaciones trazadoras sean días camas.

Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el SIGGES

El Encargado de **SOME** – Estadística deberá revisar diariamente una muestra de las nóminas de cotejo de modo de ir verificando la calidad y oportunidad del registro.

- La eliminación de registros erróneos deberá ser realizada por el encargado del establecimiento a quién se haya delegado esta tarea o deberá ser solicitada al Monitor SIGGES del Servicio de Salud Respectivo. Cada solicitud de eliminación de registros en el sistema deberán ser realizadas en un formulario correspondiente.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. El formulario deberá ser confeccionado por el establecimiento que ingresó el documento al sistema y que solicita la eliminación del evento o caso GES, completando todos los datos que le son requeridos.
2. El formulario deberá identificar el nombre y apellido del Monitor de Registro del establecimiento que solicita la eliminación, Este puede ser respaldado por el SDM del Hospital o Director de Consultorio APS, según corresponda, quien deberá refrendarlo con su nombre y firma.
3. El formulario llevará un folio correlativo anual. Formato: 0000/2005; 0000/2006.
4. La eliminación se solicitará en forma inmediata a la detección del error.
5. El formulario será remitido al Monitor de registro vía e-mail o FAX al Departamento de Estadística e Información en Salud de la Dirección de Servicio de Salud. Además se oficiará la solicitud respectiva.
6. Los establecimientos en los cuales se haya delegado la función de Eliminación desde el Servicio de Salud hacia el Monitor de registro local deberán mantener los formularios respectivos en el Departamento de Estadística e Información en salud del propio establecimiento.
7. El Departamento de Estadística e Información, mantendrá un archivo con numeración correlativa según orden de llegada de todas las solicitudes recepcionadas.
8. El funcionario responsable de realizar la eliminación del evento o caso erróneo, deberá en primer término verificar el error informado revisando la Cartola del Paciente en el SIGGES.
9. Verificado el error, procederá a eliminar el evento o caso GES requerido, dejando consignada en el formulario respectivo, el folio correlativo, la causa o motivo de la eliminación, la fecha de eliminación, el resultado del proceso, y las observaciones que estime pertinentes.
10. En los casos en que el procedimiento sea realizado en el Servicio de Salud, este deberá informar al establecimiento del procedimiento ejecutado, detallando fecha de realización y resultado de la eliminación. Si el procedimiento resulta fallido deberá a la Mesa de Ayuda del SIGGES. La información al Establecimiento podrá ser enviada vía Fax o e-mail.
11. Finalmente dejará archivada y bajo resguardo la solicitud procesada.
12. Los establecimientos por su parte, deberán mantener archivados los formularios de eliminación de casos, los que podrán ser solicitados para revisiones en cualquier momento, para efectos de auditoría y otros. La responsabilidad de su resguardo es del Monitor SIGGES del establecimiento, el archivo debe permanecer bajo resguardo según la normativa vigente por un período de 5 años.

13. El formulario debe contener al menos los siguientes campos:
14. Servicio de Salud: indicar el Servicio de Salud al cual pertenece el establecimiento que solicita la eliminación.
15. Establecimiento: corresponde al establecimiento que está solicitando la eliminación.
16. Código Establecimiento: Registrar código de Establecimiento que solicita la Eliminación
17. Fecha de Solicitud: corresponde a la fecha en que se solicita la eliminación
18. RUN: corresponde al número de RUN del paciente.
19. Si es Recién Nacido sin RUN, indicar el RUN de la madre o padre beneficiario con que haya sido ingresado al SIGGES
20. Nombre del paciente: él o los nombres y apellidos del paciente con eventos o casos a eliminar
21. Problema de Salud y subproblema: indicar a cuál de los problemas de salud en régimen, (si corresponde) se refiere la solicitud de eliminación
22. Documento: Marcar el tipo de documento a eliminar:
23. Indicar la fecha y el número de folio del documento a eliminar
24. Marcar con una X la causa de la eliminación. En caso de marcar Otros especificar la causa.
25. Fecha de eliminación: Registrar la fecha en que el funcionario del Departamento de Estadística eliminó el evento en SIGGES.
26. Eliminación Exitosa: Marcar con una X si la eliminación fue exitosa
27. Eliminación Fallida: Marcar con una X si la eliminación fue fallida
28. Nombre y Firma del funcionario que ejecuta la eliminación: Autoexplicativo.
29. Fecha del informe al establecimiento: Registrar la fecha en que se le comunicó al Establecimiento la eliminación del evento solicitado.
30. Observaciones: Indicar cualquier situación que estime conveniente señalar.

CAPITULO V

Procedimientos Servicios de Urgencia

- *Los Servicios de Urgencia.*
- *Ingreso de Pacientes a Servicios de Urgencia.*
- *Paso Por Recaudación.*
- *Atención por Auxiliar Clínico.*
- *Atención Profesional Servicio de Urgencia.*
- *Archivo e Ingreso de Datos.*
- *Formulario DAU Formulario de Registro de la atención de Urgencia*
- *Ingreso de datos al SIGGES*

Los Servicios de Urgencia

- ❑ Los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y los Servicios de Urgencia de los hospitales, tienen como finalidad resolver los casos en que la naturaleza del problema de salud no le permite esperar para ser atendida en un Consultorio.
- ❑ En ellos se brindará una primera atención para resolver el problema inmediato, con los profesionales y equipos que amerite el caso, según las disponibilidades del establecimiento.

I. Ingreso de Pacientes a Servicios de Urgencia

En estos servicios existe una ventanilla de Admisión del SOME para el ingreso de pacientes, el cual se debe hacer con la mayor agilidad:

- 1) El funcionario de admisión recibe al paciente y registra los datos del paciente de este en un **formulario de Atención de Urgencia (DAU)**.³² Este formulario tiene un número de identificación único y es llenado a lo largo de todo el proceso de atención en la Unidad de Urgencia por los diferentes funcionarios y profesionales a cargo del proceso.
- 2) El funcionario de admisión completa los datos de identificación del paciente y el motivo de consulta además de consignar la fecha y hora de atención
- 3) El formulario pasa al Auxiliar Clínico del box o Sala de Atención.

32 Ordinario C26 N° 1980, del Misal, del 12 de junio del 2008, y ordinario C26 N° 394, dal 01 de febrero del 2008

- 4) En algunos casos de mayor gravedad o emergencia, no se pueden tomar los datos del paciente antes de proporcionarle la atención, sino que se pasa directamente al box o Sala de Atención.
- 5) El formulario de Atención de Urgencia debe contener los **datos de identificación del usuario**. Para poder informar los problemas de salud GES y registrar estos en el SIGGES, el formulario debe contener al menos la siguiente información:
 - a. RUN³³
 - b. Nombres y Apellidos
 - c. Fecha de nacimiento edad
 - d. Previsión
 - e. Consultorio de origen: esta información es relevante para que en caso de ser referido a su centro de APS se pueda registrar un solicitud de Interconsulta y derivación a partir de los datos existentes en el formulario DAU, evitando elaborar el documento en papel

Además de los datos de identificación del usuario, en la ventanilla de admisión debe consignarse la fecha y hora de la atención del paciente.

En la mayoría de los establecimientos es en Admisión donde se consigna el motivo de consulta del paciente, que en el caso del problema de salud IAM permite detectar la sospecha cuando se consigna dolor torácico, o un término similar.

Cabe mencionar en particular entre ellos el dolor torácico, en cuyo caso se debe confirmar o descartar con mayor prontitud el Infarto Agudo al Miocardio.

Problema de salud Analgesia del Parto

A pesar de que la atención de los partos no se realiza en los servicios de Urgencia, sino que en recintos especiales para este fin, se puede decir que debido a que las acciones ocurren en un periodo de tiempo acotado y en un lugar físico definido, que las decisiones de sospecha, confirmación, indicación de analgesia y aplicación de estas pueden ser recogidas en una ficha similar al DAU o en los documentos que los establecimientos hayan establecido, no siendo necesario el llenado físico de Solicitudes de Interconsultas; Informes de Proceso Diagnostico, y Cierre de Caso. El digitador del SIGGES podrá transcribir estas decisiones desde los documentos que el establecimiento haya establecido para ello.

³³ En el caso de los Recién Nacidos sin RUN se consigna el RUN de la madre o el padre, y se identifica que se trata de un recién nacido sin RUN.

II. Paso por Recaudación

- ☐ Por lo general los pacientes o sus acompañantes deben documentar los datos en la ventanilla de Recaudación donde, según la previsión, se cursan los cobros correspondientes.

III. Atención por Auxiliar Clínico

El Auxiliar Clínico tendrá las siguientes funciones:

- ☐ Llamar o hacer pasar a los pacientes, en el orden de llegada.
- ☐ Calificar los casos que deban pasar de inmediato. En los lugares en que exista la función de demanda asignada, corresponderá a esta persona efectuar esta tarea. Puede ser que en esos establecimientos se determine que es en ese punto en el que se detecta la sospecha de los problemas de salud GES, tal como el caso de IAM
- ☐ Instalar a los pacientes en los boxes o Salas de Atención, para que sean examinados.
- ☐ Realizar curaciones o procedimientos básicos que indique el profesional, después que examine al paciente.
- ☐ Entregar al SOME los Formularios de Atención de los pacientes atendidos y las Solicitudes de Interconsulta.
- ☐ Entregar a los pacientes los respectivos Formularios de Atención de Urgencia y, cuando corresponda, las Órdenes de Atención y recetas que hayan sido emitidas.

IV. Atención Profesional Servicio de Urgencia

El profesional de turno en el Servicio de Urgencia deberá:

- ☐ Examinar al paciente
- ☐ Formular una hipótesis diagnóstica
- ☐ Identificar un problema de salud AUGE en los casos que corresponda
- ☐ Informar al paciente cuando se trata de un problema de salud AUGE. En este caso se considera suficiente con informar al paciente y hacerle firmar la Ficha de Atención de Urgencia (DAU), dado que esta última se confecciona en dos copias una de las cuales queda en manos del establecimiento y la otra es entregada al paciente.
- ☐ Indicar el tratamiento de urgencia, consistente en:
 - Procedimientos, mediante la anotación en la **Ficha de Atención (DAU, Datos de Atención de Urgencia)**.
 - Exámenes, mediante la indicación en una **Orden de Atención**. En los casos en que se realiza de inmediato el examen en el mismo servicio de urgencia, la indicación se anota en la Ficha de Atención consignando la fecha y hora y el tipo de atención requerida.
 - Medicamentos, mediante una prescripción. Los medicamentos que se proporcionan en el acto se registran en la Ficha de Atención.
 - Hospitalización en Urgencia, mediante una **Orden de Atención**.

- ❑ Llenar un Comprobante o **Formulario de Atención de Urgencia**, en el cual se indica el motivo de consulta, hipótesis diagnóstica, problema de salud AUGÉ, prestaciones realizadas (incluyendo la hora de realización de estas) e indicaciones; cuando se considere necesario se indicará el control en un Consultorio.

En ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados o modificados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

Los SAPUs siguen el mismo procedimiento de los establecimientos APS

- ❑ Extender una **Solicitud de Interconsulta o Derivación** a otro establecimiento o especialidad, en los siguientes casos:
 - a. Cuando se encuentre un problema de salud AUGÉ que no haya sido ingresado por otro establecimiento.
 - b. Cuando se considere que el paciente debe ser examinado por un especialista.

- En los casos de **IRA de niños menores de 5 años y Neumonías** comunitarias que consulten en los servicios de Urgencia de Hospitales y se manejen en forma ambulatoria, el registro de esta atención se realizará en los establecimientos de APS, cuando el paciente se presente a continuar su tratamiento.
- Para ello los servicios de Urgencia deberán entregar al paciente un informe que indique además de los datos de identificación del paciente (en especial el RUN) la fecha y hora de atención, el problema de salud y el diagnóstico específico, el tratamiento realizado en el establecimiento y la indicación de derivación.
- Ese documento deberá ser entregado en el SOME del establecimiento APS al solicitar la atención, para que se ingresen los datos en el **SIGGES** utilizando la planilla definida para este fin, y devuelto posteriormente al paciente y asignándole esta atención al establecimiento de urgencia correspondiente, en el encabezado de la hoja APS en el **SIGGES**.
- La atención o tratamiento recibidos en la APS se entenderán como la continuación de la etapa anterior debiendo registrar en el SIGGES las prestaciones de Tratamiento y/o Kinesioterapia cuando corresponda.
- Igualmente si el paciente no ha acudido al establecimiento APS en el tiempo indicado (definido por la garantía y el tratamiento entregado) se podrá ingresar los datos para la excepción de la garantía por causal atribuible al paciente (inasistencia) lo que deberá ser respaldado en la ficha.
- Los SAPUs siguen el mismo procedimiento de los establecimientos APS.

V. Archivo e Ingreso de Datos

El **SOME** del Servicio de Urgencia tendrá las siguientes obligaciones, después de la atención:

- ☐ Recibir y archivar todas las Fichas de Atención y los diferentes formularios relacionados con el SIGGES.
- ☐ Ingresar al SIGGES:
 - Los datos de las Fichas de Atención de los problemas GES identificados.
 - Los formularios de Solicitud de Interconsulta o Derivación
- ☐ Despachar las Solicitudes de Interconsulta a los establecimientos o especialidades indicados en ellas.

VI. Formulario de Registro de la atención de Urgencia (DAU)

A. Emisión y llenado del formulario

El formulario será emitido por el funcionario de admisión de la Unidad de emergencia. Los formularios tendrán la identificación del servicio de salud, establecimiento, y de la unidad correspondiente, y tendrán un número de identificación único que permita su archivo y posterior ubicación en el archivo si es necesario.

El formulario consta de cuatro partes: datos del establecimiento; datos del paciente; datos de la atención; datos del o de los profesionales tratantes.

En ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados o modificados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

1. Proceso de admisión del paciente

- ☐ El funcionario de Admisión deberá completar los datos de identificación del paciente:
 - RUN
 - Nombre y Apellidos
 - Edad o fecha de nacimiento
 - Sexo
 - Domicilio
 - **Consultorio de Origen o establecimiento donde está inscrito el paciente.** Esto facilitará la derivación del paciente.
- ☐ Deberá consignar también datos relacionados a la consulta actual:
 - Fecha y Hora de la atención
 - Motivo de consulta
 - Lugar y causa de accidente en caso de tratarse de un accidente
 - Medio de acceso al establecimiento (ambulancia, Otro vehículo ...)

- ❑ En el documento se deberá identificar el funcionario que realizó la admisión con el nombre y RUT de este además de su firma.

2. Proceso de atención del paciente

El profesional a cargo de la atención del paciente deberá consignar en el Formulario de Atención de Urgencia:

- ❑ **Hipótesis diagnóstica Inicial:** en el caso de los problemas de salud GES, este momento corresponde a la sospecha del problema. Se debe consignar la fecha y hora en la cual el profesional emite la primera sospecha.
- ❑ **Problema de salud GES:** se debe consignar cuando el problema de salud que se esté tratando sea un problema de salud GES. Se debe especificar el problema de salud GES que se sospecha, según el listado del anexo. Si el formulario de Atención de Urgencia no permite consignar La hipótesis diagnóstica inicial y la condición GES del problema de salud, el profesional deberá emitir una Solicitud de Interconsulta y/o Derivación en el momento en que sospeche un problema de salud GES. Este formulario permitirá realizar el registro de la sospecha del problema de salud en el SIGGES.
- ❑ **Indicación de exámenes y procedimientos diagnósticos:** Las indicaciones para la realización de exámenes y procedimientos diagnósticos pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia. En ese caso se debe especificar la Fecha y Hora además del tipo de examen o procedimiento solicitado. Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar la Indicación de Exámenes se deberá emitir una Orden de Atención y seguir el procedimiento indicado (ver registro de Ordenes de Atención)
- ❑ **Realización de exámenes y procedimientos diagnósticos:** La realización de exámenes y/o procedimientos diagnósticos pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia. En ese caso se debe especificar la fecha y hora de realización, además de la unidad que realizó el examen. Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar la realización de exámenes y/o procedimientos diagnósticos estos deberán ser registrados en las Hojas de registro de Atenciones correspondientes, en las cuales se deberá especificar la identificación del paciente, el número del formulario de atención de urgencia del paciente, fecha y hora de la realización del procedimiento. Si se trata de un problema de salud GES se debe además especificar el Problema de salud correspondiente.
- ❑ **Confirmación Diagnóstica:** en el momento que el profesional determina que se produjo la confirmación diagnóstica o el descarte de la sospecha inicial, este se debe consignar el Formulario de Atención de Urgencia. Este Formulario debe permitir especificar el diagnóstico en texto libre, el problema GES, y si se produjo la confirmación o el descarte de este problema. Además se debe especificar la fecha y hora en que esto ocurre. Si el formulario de Atención de Urgencia no permite consignar la confirmación o el descarte del problema de salud GES se deberá emitir un formulario de Informe de Proceso Diagnóstico y seguir el procedimiento indicado para el llenado de este formulario.
- ❑ **Indicación de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos:** Las indicaciones para la realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos pueden estar consignadas en el

Formulario de Atención de Urgencia, si estos se realizan en el mismo recinto. En ese caso se debe especificar la Fecha y Hora además del tipo de Tratamiento y/o procedimiento Terapéutico. Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar la Indicación de Tratamiento se deberá emitir las Ordenes de Atención correspondientes y seguir el procedimiento indicado (ver registro de Ordenes de Atención)

- ❑ **Realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos:** La realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos en la Unidad de Emergencia pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia. En ese caso se debe especificar la fecha y hora de realización. Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar la realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos estos deberán ser registrados en las Hojas de registro de Atenciones correspondientes, en las cuales se deberá especificar la identificación del paciente, el número del formulario de atención de urgencia del paciente, fecha y hora de la realización del procedimiento. Si se trata de un problema de salud GES se debe además consignar el Problema de salud correspondiente
- ❑ **Indicación del destino del paciente:** Una vez que se termina la etapa de atención del paciente en la Unidad de Emergencia, se debe consignar el destino del paciente en el Formulario de Atención de Urgencia. Se debe permitir consignar la Fecha y Hora de la indicación.
 - Si se indica la Hospitalización del paciente en el mismo establecimiento se debe especificar la unidad de destino del paciente.
 - Si se indica el traslado para la Hospitalización en otro establecimiento se debe especificar el nombre y servicio de salud de destino. Se deberá elaborar además un **Formulario de Solicitud de Interconsulta y/o Derivación**, y seguir el procedimiento especificado.
 - Si se requiere que el paciente sea evaluado por otro especialista en la consulta ambulatoria del mismo establecimiento, el profesional deberá especificar en el Formulario de Atención de Urgencia la especialidad en la cual debe ser evaluado el paciente. Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar esta información el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación** y se seguirá el procedimiento indicado para este formulario.
 - Si el paciente es remitido a su consultorio el profesional deberá especificar en el Formulario de Atención de Urgencia esta indicación. A partir de los datos del Formulario, el SOME deberá registrar una Solicitud de Interconsulta y derivación dirigida al establecimiento de origen consignado en dicho formulario especificando los diagnósticos y prestaciones realizadas durante la atención de urgencia.
- ❑ **Identificación del o de los profesionales tratantes:** El formulario deberá contener la información suficiente para individualizar al o los profesionales que registraron información en el Formulario de Atención de Urgencia. Al menos se debe considerar Nombres y Apellidos y RUN.

En ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados o modificados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

- Notificación del paciente GES: Aquellos pacientes que tengan un problema de salud GES deben ser notificados por escrito por el prestador en un formulario que es firmado por el paciente, quién se queda con una de las copias. En el caso de las atenciones de urgencia se determinó que esta notificación puede ser realizada con el mismo **formulario de Atención (DAU)** utilizado en el proceso de atención de urgencia, el cual debe ser firmado por el paciente reconociendo haber tomado conocimiento de sus derechos y deberes.

B. Ingreso de los Datos al SIGGES

El funcionario de Admisión del SOME recibirá las copias de todos los Formularios de Atención de Urgencia, Órdenes de Atención y Solicitudes de Interconsultas o Derivación emitidos por las unidades de emergencia.

1. Formularios de Atención de Urgencia DAU de pacientes GES

En el caso de los Formularios de Atención de Urgencia de pacientes GES emitidos en las unidades de Emergencia estos deben ser registrados por Admisión del SOME en el SIGGES. Debido a que en el SIGGES no hay una pantalla para registrar los formularios DAU, las diferentes decisiones registradas en el DAU deben registrarse en diferentes formularios en el SIGGES.

Las sospechas de problemas de salud deben reflejarse en un ingreso de Solicitud de Interconsulta; las confirmaciones o descarte en un Ingreso de Informe de Proceso Diagnóstico; las indicaciones de exámenes o procedimientos en un ingreso de Orden de Atención; las atenciones realizadas en un Ingreso de Prestaciones Otorgadas.

El detalle de cómo se deben registrar en el SIGGES las diferentes decisiones y acciones registradas en el Formulario de Atención de Urgencia DAU se detallan en los párrafos siguientes:

a. Si se Sospecha de un problema de salud GES

- Si el **Formulario de Atención de Urgencia** consigna la **sospecha de un problema de salud GES** identificando el problema de salud según el listado del anexo y especificando la fecha y hora de la sospecha, esto deberá registrarse en el SIGGES en la pantalla de registro de las Solicitudes de Interconsultas, según las siguientes especificaciones:

Pantalla de registro de Solicitudes de Interconsulta

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Folio N°:	Será dado automáticamente por el Sistema una vez que sea registrado el documento y deberá ser escrito en el formulario de Atención de Urgencia al lado del registro de la sospecha GES una vez que se digite la información al SIGGES						
Fecha solicitud:	Debe registrarse el día, mes y año en que se está extendiendo el formulario (dd/mm/aaaa). Esta información corresponde a la Fecha de atención en que ocurre la sospecha registrada en el Formulario de atención de urgencia						
Hora:	Debe registrarse con 2 dígitos la Hora y los minutos en que se está llenando el formulario Ej.: Dos y cuarto de la tarde: 14:15 Esta información corresponde a la hora de atención en que ocurre la sospecha registrada en el Formulario de atención de urgencia						
Servicio de Salud:	Debe registrarse el nombre del Servicio de Salud al que pertenece el establecimiento que hace la atención de urgencia.						
Establecimiento:	Debe registrarse el nombre del establecimiento de Salud que está realizando la Atención de Urgencia.						
Especialidad:	Deberá consignarse aquí el Servicio o Especialidad al cual pertenece el profesional que está realizando la atención de Urgencia. Las especialidades corresponden a las siguientes:						
	<table border="1"> <tr> <td>10-200-0</td><td>Unidad Emergencia (Indiferenciado)</td></tr> <tr> <td>10-200-1</td><td>Unidad Emergencia Adultos</td></tr> <tr> <td>10-200-2</td><td>Unidad Emergencia Niños</td></tr> </table>	10-200-0	Unidad Emergencia (Indiferenciado)	10-200-1	Unidad Emergencia Adultos	10-200-2	Unidad Emergencia Niños
10-200-0	Unidad Emergencia (Indiferenciado)						
10-200-1	Unidad Emergencia Adultos						
10-200-2	Unidad Emergencia Niños						
Unidad:	Debe registrar como Unidad de Atención Ambulatoria						

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:

Nombre:	Deberá registrarse el apellido paterno, luego el materno y finalmente los nombres del paciente registrados en el Formulario de Atención de urgencia.
Historia Clínica:	Deberá consignarse el número asignado al Formulario de Atención de Urgencia , lo que facilitará el recuperar la información desde el Archivo de los Formularios de Atención de urgencia cuando sea necesario.
RUN:	Deberá registrarse los números correspondientes al Rol Único Nacional del paciente registrado en el Formulario de Atención de Urgencia
Si es Recién Nacido: (R.N), RUN de padre o madre beneficiario	Si el causante de la atención es un Recién Nacido, deberá consignarse el RUN de uno de sus padres (mamá o papá). Al igual que los N° anteriores, tal como se registró en el Formulario de Atención de urgencia.
Sexo:	Registrar con una X en el casillero correspondiente a masculino si el paciente es un hombre; o en el de femenino si se trata de una mujer. En el SIGGES el dato se llena directamente desde la base de datos de beneficiario
Fecha de nacimiento:	Deberá registrarse la fecha de nacimiento, en los casilleros correspondientes a día – mes y año. La hora de nacimiento es sólo requerida en el caso que se trate de un Recién Nacido. En el SIGGES el dato se llena directamente desde la base de datos de beneficiario
Edad:	Registrar <u>en casilleros horizontales el número</u> que corresponda y <u>en los casilleros verticales marcar con una "X"</u> si dichos números indican años, meses, días u horas. En el SIGGES el dato se llena directamente desde la base de datos de beneficiario
Domicilio:	Deberá consignar el nombre de la calle, avenida o pasaje, número de la casa o departamento, número o letra del Block, nombre la población o Villa y nombre de la ciudad donde reside el paciente.

Comuna de residencia:	Deberá indicarse el nombre de la Comuna de residencia del paciente.
Teléfono 1:	Debe registrarse uno a uno y en cada casillero el número de teléfono, ya sea de red fija o celular, del paciente y/o familiar, a objeto de una rápida ubicación, si fuere necesario.
Teléfono 2:	Debe registrarse uno a uno y en cada casillero el número de teléfono, alternativo ya sea de red fija o celular, del paciente y/o familiar, a objeto de una rápida ubicación, si fuere necesario.
Correo electrónico:	Si el paciente lo tuviere, deberá registrarse en forma clara el nombre de su e-mail.

DATOS CLINICOS DEL PACIENTE

Se deriva para atención en <u>Establecimiento</u> :	Debe registrar claramente el nombre completo del Establecimiento que realiza la atención. Es el mismo que aparece en el encabezado del Formulario de Atención de urgencia.
Especialidad:	Debe Repetirse lo registrado en el establecimiento de origen
Se envía a consulta para:	Aquí se debe dejar consignado con una X que se trata de realizar una Confirmación diagnóstica
Hipótesis Diagnóstica:	Deberá registrarse el texto libre especificado por el profesional en el momento de la sospecha en el Formulario de Atención de Urgencia, sin utilizar siglas.
¿Sospecha problema de Salud AUGE?:	Se debe registrar con una "X" frente al casillero que corresponda, si se ha marcado en el Formulario de Atención de Urgencia que el paciente presenta una patología AUGE.

DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre:	Deberá registrarse el apellido paterno, luego el materno y los nombres del profesional que está atendiendo al paciente.
RUN:	Deberá consignar uno en uno los números del Rol Único del profesional.

b. Si se indican Exámenes y/o procedimientos Diagnósticos en un Problema GES

- ☐ Si el **Formulario de Atención de Urgencia** consigna la **Indicación de exámenes y procedimientos diagnósticos** en una persona con un problema de salud GES, esta indicación deberá registrarse en el SIGGES en la pantalla de ingreso de **Ordenes de atención**
- ☐ Los datos que se requieren registrar son los **siguientes**:

Pantalla de registro de Ordenes de Atención

- ☐ Datos de Origen
 - Fecha y hora de emisión de la Orden: corresponde a la fecha y hora de la realización de la indicación de exámenes y/o procedimientos diagnósticos consignada el Formulario de Atención de Urgencia
 - Servicio de salud y Establecimiento de origen del formulario de Atención de Urgencia.
 - Especialidad de Origen de la orden Corresponden a las siguientes según el tipo de unidad de emergencia

10-200-0	Unidad Emergencia (Indiferenciado)
10-200-1	Unidad Emergencia Adultos
10-200-2	Unidad Emergencia Niños

❑ Datos del Paciente

- RUN: consignados en la Ficha de Atención de Urgencia
- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
- N° de Ficha Clínica: Deberá consignarse el número asignado al **Formulario de Atención de Urgencia**, lo que facilitará el recuperar la información desde el Archivo de los Formularios de Atención de urgencia cuando sea necesario.

❑ Datos Clínicos

- Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGÉ, tal como se especifica en el Formulario de Atención de Urgencia
- Diagnóstico (s) en texto libre: corresponde a la Hipótesis Diagnóstica Inicial
- Establecimiento destino (incluye establecimientos privados): corresponde al establecimiento de Origen del Formulario de Atención de Urgencia
- Especialidad Destino: Corresponde a la especialidad en que se realiza el examen o la Unidad de emergencia cuando este se realiza en la misma unidad
- Prestaciones solicitadas: Según los códigos del FONASA
- Otra Indicación: no corresponde
- Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación (se requiere en algunos problemas de salud) No corresponde

❑ Datos Profesional Solicitante

- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno Profesional Solicitante
- RUN Profesional Solicitante

c. Si se confirma o descarta un problema de salud GES

- ❑ Si el **Formulario de Atención de Urgencia** consigna la **Confirmación o Descarte** en una persona con un problema de salud **GES**, esta indicación deberá registrarse en el SIGGES en la pantalla de ingreso del **Informe de Proceso Diagnóstico** según las siguientes especificaciones:

Pantalla de registro de Informe de Proceso Diagnóstico

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Folio N°	Será dado automáticamente por el sistema una vez que sea registrado el documento y deberá ser escrito en el formulario de atención de Urgencia al lado de la confirmación o el descarte una vez que se digite en el SIGGES.
Fecha y hora del Informe	Debe registrarse con 2 dígitos el día, mes y el año en que se produjo la confirmación o el descarte tal como se especifica en el Formulario de Atención de Urgencia
Servicio de Salud	Debe indicarse el nombre del Servicio de Salud a que pertenece el establecimiento que realiza la confirmación o descarte del problema de salud.
Establecimiento	Registrar nombre (sin utilizar siglas) del establecimiento que atiende al paciente.

Especialidad	Deberá consignarse aquí el Servicio o Especialidad al cual pertenece el profesional que está realizando la atención de Urgencia. Las especialidades corresponden a las siguientes:						
	<table> <tr> <td>10-200-0</td><td>Unidad Emergencia (Indiferenciado)</td></tr> <tr> <td>10-200-1</td><td>Unidad Emergencia Adultos</td></tr> <tr> <td>10-200-2</td><td>Unidad Emergencia Niños</td></tr> </table>	10-200-0	Unidad Emergencia (Indiferenciado)	10-200-1	Unidad Emergencia Adultos	10-200-2	Unidad Emergencia Niños
10-200-0	Unidad Emergencia (Indiferenciado)						
10-200-1	Unidad Emergencia Adultos						
10-200-2	Unidad Emergencia Niños						
Unidad	Debe registrar como Unidad de Atención Ambulatoria						

DATOS DEL (DE LA) PACIENTE

Nombre	Autoexplicativo
Historia Clínica	Deberán registrarse los números que conforman el N° del Formulario de Atención de Urgencia lo que facilitará el acceso a la Información que exista en los archivos.
RUN	Debe registrarse claramente, el número del Rol Único del paciente registrado en el Formulario de Atención de Urgencia
Si es Recién Nacido (R.N), RUN de padre o madre beneficiario	Si se trata de un Recién Nacido, deberá consignarse el RUN de uno de sus padres (mamá o papá).
Sexo	Registrar con una X en el casillero correspondiente a masculino si el paciente es un hombre; o en el de femenino si se trata de una mujer. El SIGGES extrae estos datos desde la base de datos de Beneficiarios
Fecha de nacimiento	Deberá registrarse la fecha de nacimiento, en los casilleros correspondientes a día – mes y año). La hora de nacimiento es sólo requerida en el caso que se trate de un Recién Nacido. El SIGGES extrae estos datos desde la base de datos de Beneficiarios
Edad	Registrar <u>en casilleros horizontales el número</u> que corresponda y en <u>los casilleros verticales marcar con una "X"</u> , si dichos números indican años, meses, días u horas. El SIGGES extrae estos datos desde la base de datos de Beneficiarios

DATOS CLINICOS

Problema de Salud Auge	Se debe registrar el nombre del problema de salud Auge (sin emplear siglas), especificado en el Formulario de Atención.
¿Confirma que el diagnóstico pertenece al sistema AUGE?	Colocar X frente a Sí, si es afirmativo y frente a No, si no lo confirma
Subgrupo o subproblema de salud AUGE	Dependiendo del protocolo ciertos problemas de salud están subdivididos en subcategorías, por ejemplo: Disrafia abierta y cerrada.
Diagnóstico	Se deberá registrar con letra legible el o los diagnósticos concluyentes después de la atención médica, especificados en el Diagnóstico Final, del Formulario de Atención de Urgencia.
Fundamentos del Diagnóstico	Aquí se consignará los fundamentos clínicos que tuvo el Profesional para confirmar el problema de salud, si se encuentran especificados en el Formulario de Atención de urgencia
Tratamiento e Indicaciones	Se podrán registrar los tratamientos e indicaciones si se encuentran especificados en el Formulario de Atención de urgencia.
El tratamiento deberá iniciarse a más tardar el...	No corresponde.

DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre	Deberá registrarse el apellido paterno, luego el materno y los nombres del profesional que está atendiendo al paciente.
RUN	Deberá consignar uno en uno los números del Rol Único del profesional.

d. Si se indican Tratamientos o procedimientos a un paciente con un problema de salud AUGE

- ☐ Si el **Formulario de Atención de Urgencia** contiene las **Indicaciones de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos** en una persona con un problema de salud GES, esta indicación deberá registrarse en el SIGGES en la pantalla de ingreso de **Ordenes de atención**
 - Los datos que se requieren en la pantalla de ingreso de Ordenes de Atención del SIGGES tal como fue descrito anteriormente.

e. Si se le han realizado prestaciones a una persona con un problema de salud AUGE

- ☐ Si la **Realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos** están consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia. Estas podrán ser registradas en el SIGGES como **Prestaciones Otorgadas, prestaciones AUGE, valoradas o Otras prestaciones** según sea el caso.

Registro en Pantalla de Prestaciones Otorgadas:

- RUN: consignados en la Ficha de Atención de Urgencia
- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
- N° de Ficha Clínica: Deberá consignarse el número asignado al **Formulario de Atención de Urgencia**, lo que facilitará el recuperar la información desde el Archivo de los Formularios de Atención de urgencia cuando sea necesario.
- Caso Auge del Paciente: según lo consignado en el Problema de salud GES. Si la prestación se realiza previo a la hora de confirmación o descarte se debe registrar el problema de salud referido en la SOSPECHA. Si la Prestación se realiza con posterioridad a la Confirmación o Descarte se debe registrar el problema de salud referido en la CONFIRMACIÓN.
- Formulario de Origen: se debe consignar la orden de atención que generó la indicación, anotando el folio registrado al lado de este y entregado por el SIGGES al momento de digitar la orden de atención.
- Prestación: prestación realizada según el código de FONASA correspondiente.
- Compra de servicio: no corresponde ya que la prestación se habría realizado en el establecimiento de origen
- Servicio de salud que otorga: corresponde al servicio de salud del establecimiento de origen
- Establecimiento: corresponde al establecimiento del encabezado del Formulario de Atención de Urgencia
- Fecha de inicio: corresponde a la fecha de realización de la prestación
- Hora: corresponde a la hora de realización de la prestación.

f. Si se indica la Hospitalización de un apaciente con un problema de salud AUGÉ

- ❑ Si en el **Formulario de Atención de Urgencia** se indica la Hospitalización del paciente en el mismo establecimiento. Esta información debe registrarse como una **Solicitud de Interconsulta o derivación** hacia la especialidad de destino especificada en el Formulario de Atención del Paciente, Unidad de Atención Cerrada, del mismo establecimiento. La Fecha y hora del registro en el SIGGES corresponde a la fecha y hora de indicación del destino del paciente,
- ❑ Si en el **Formulario de Atención de Urgencia** se indica el traslado para la Hospitalización en otro establecimiento. Se debe especificar el nombre y servicio de salud de destino. A partir de los datos del formulario se registrará en el SIGGES como una **Solicitud de Interconsulta y Derivación** al servicio de salud del establecimiento especificado. Este deberá ser tramitado según los protocolos establecidos entre ambos establecimientos para estos casos.

Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar esta información el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación** y se seguirá el procedimiento indicado para este formulario

- ❑ Si en el **Formulario de Atención de Urgencia** se indica que el paciente requiere que el paciente sea evaluado por otro especialista en la consulta ambulatoria del mismo establecimiento, se deberá registrar en el SIGGES como una **Solicitud de Interconsulta y Derivación** al mismo establecimiento a la unidad de Atención Ambulatoria, a la especialidad consignada en el Formulario de Atención de Urgencia la especialidad en la cual debe ser evaluado el paciente.

Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar esta información el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación** y se seguirá el procedimiento indicado para este formulario.

Una vez generada la Solicitud de Interconsulta y Derivación, el establecimiento deberá gestionar la citación del paciente e informarlo ya sea directamente o a través de su consultorio de la Fecha y Hora en que debe ser atendido por el especialista. Este procedimiento se detalla más adelante.

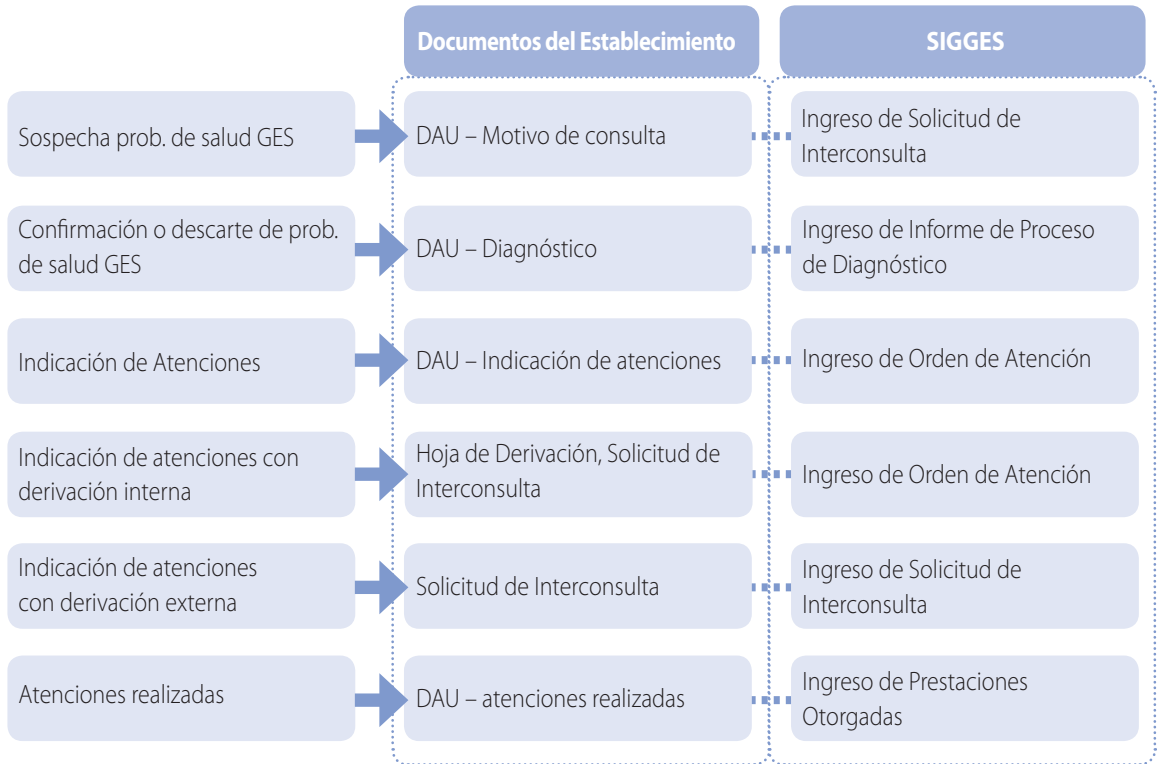
- ❑ Si en el **Formulario de Atención de Urgencia** el paciente es remitido a su consultorio esta información se registra en el SIGGES como una **Solicitud de Interconsulta y/o derivación**. La fecha y hora de la derivación corresponde a la fecha y hora de indicación del destino del paciente. El establecimiento de destino deberá estar consignado en el Formulario de Atención de Urgencia en los datos del Paciente como consultorio de origen o consultorio donde está inscrito el paciente. Si se trata de un problema de salud GES deberá ser marcado como tal especificando el problema de salud tal como aparece en el Formulario de Atención de Urgencia. En aquellos casos en que se haya sospechado y /o confirmado un problema de salud GES en la unidad de emergencia, este deberá ser enviado ya sea para confirmación diagnóstica en la primera situación, o para tratamiento en la

segunda situación. Si no se trata de un problema de salud GES, se deberá marcar como NO en la casilla sospecha un problema GES.

Si el Formulario de Atención de Urgencia no permite consignar esta información el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación** y se seguirá el procedimiento indicado para este formulario.

Una vez generada la Solicitud de Interconsulta y Derivación, el establecimiento deberá gestionar la citación del paciente e informarlo ya sea directamente o a través de su consultorio de la Fecha y Hora en que debe ser atendido por el especialista. Este procedimiento se detalla más adelante.

En suma, desde el formulario de atención DAU se generan en el SIGGES diferentes documentos según las decisiones que se hayan producido



VII. Formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación

A. Emisión del formulario

- ☐ Si el Formulario de Atención de urgencia no permite registrar la sospecha de un problema de salud GES en la unidad de Emergencia, el profesional deberá llenar una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, que remitirá al SOME para que se registre en el SIGGES creando el caso correspondiente.
- ☐ Si se requiere que el paciente sea evaluado por otro especialista, y el formulario de Atención de Urgencia no permite registrar esta indicación el profesional llenará una **Solicitud de Interconsulta o Derivación**, que remitirá al **SOME**, para que se solicite la concurrencia del profesional solicitado y se registre esta solicitud en el SIGGES.
- ☐ Este formulario cuenta con tres partes: Datos del paciente, Datos clínicos y Datos del Profesional.

En ningún caso los Datos Clínicos podrán ser llenados o modificados por otra persona que no sea el profesional que otorgó la consulta.

B. Ingreso de los Datos

- ☐ El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Solicitud de Interconsulta** desde la Unidad de Emergencia deberá ingresar los datos al sistema computacional, **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario del **SIGGES**, consignando la fecha y hora de la solicitud.

C. Obtención de Citación

- ☐ En el caso de una Solicitud de Interconsulta para un paciente atendido en la Unidad Urgencia, el SOME deberá verificar si está habilitado para otorgar hora para un profesional de la Unidad de Apoyo o Especialidad, o para el consultorio correspondiente al destino.
- ☐ Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al SIGGES.
- ☐ Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.

D. Registro de hora para Consulta

La hora correspondiente deberá ser registrada, por el funcionario del **SOME** del establecimiento que administra los cupos, en:

- ☐ La Agenda de la Unidad de Apoyo y establecimiento de destino, según los medios de que se disponga.
- ☐ El **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario.

E. Información al paciente de hora para Consulta

La hora de citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:

- ☐ Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario ad hoc
- ☐ Telefónicamente
- ☐ Por fax
- ☐ Por aviso al domicilio.

VIII. Orden de Atención

A. Emisión del formulario

- ☐ En los casos en que el especialista considere necesario que se practique algún examen de apoyo al diagnóstico o algún procedimiento o tratamiento al paciente en la unidad de emergencia y esta no pueda ser consignada en el Formulario de Atención de Urgencia, el profesional deberá emitir una **Orden de Atención**, donde registrará las prestaciones respectivas.
- ☐ Los datos mínimos que debe contener esta **Orden de Atención** si esta debe ser ingresada al SIGGES son los siguientes:

☐ Datos de Origen

- Fecha y hora de emisión de la Orden
- Servicio de salud y Establecimiento de origen de la orden
- Especialidad de Origen de la orden Corresponde a las definidas para las unidades de Urgencia

10-200-0	Unidad Emergencia (Indiferenciado)
10-200-1	Unidad Emergencia Adultos
10-200-2	Unidad Emergencia Niños

☐ Datos del Paciente

- RUN
- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
- N° de Ficha Clínica: Corresponde al Número del Formulario de Atención de urgencia

☐ Datos Clínicos

- Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGÉ
- Diagnóstico (s) en texto libre
- Establecimiento destino (incluye establecimientos privados)
- Especialidad Destino
- Prestaciones solicitadas
- Otra Indicación: No corresponde
- Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación No corresponde.

☐ **Datos Profesional Solicitante**

- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno Profesional Solicitante
- RUN Profesional Solicitante

B. Ingreso de los Datos

El funcionario de Admisión del **SOME**, cada vez que reciba una **Orden de Atención emitida** en la Unidad de emergencia que contenga prestaciones trazadoras, deberá ingresar los datos de dichas prestaciones al sistema computacional, **SIGGES**, de acuerdo con el Manual del Usuario del **SIGGES**, consignando la fecha y hora de la orden.

C. Obtención de Citación y registro de horas para examen o procedimiento

En el caso de las atenciones realizadas en las Unidades de Emergencia no se requiere solicitud de hora o citación ya que las atenciones se realizan de inmediato.

Se deberá realizar el

En el caso de órdenes de atención para ser realizadas en otro establecimiento o con posterioridad a la atención de urgencia, el **SOME** deberá verificar si está habilitado para otorgar hora para un profesional de la **Unidad de Apoyo o Especialidad, o para el consultorio correspondiente al destino**.

Si se encuentra habilitado, otorga de inmediato hora de atención de especialidad al paciente, ingresando fecha y hora de citación al **SIGGES**.

Si no se encuentra habilitado, deberá solicitar vía teléfono, fax, e-mail, radio, etc., la hora de atención profesional en la especialidad respectiva.

D. Información al paciente de hora para Consulta

La hora de citación será comunicada al paciente a la brevedad por uno de los siguientes medios:

- ☐ Entregando personalmente los datos de la citación en un formulario ad hoc
- ☐ Telefónicamente
- ☐ Por fax
- ☐ Por aviso al domicilio.

IX. Prestaciones de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento

El paciente recibirá, durante su proceso de atención en la unidad de emergencia distintas prestaciones, que podrán consistir en exámenes, tratamiento, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.

- ❑ Las prestaciones realizadas en la Unidad de Emergencia podrán ser consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia, las que serán registradas desde ese formulario al sistema correspondiente y al SIGGES.
- ❑ Si el formulario de Atención de urgencia no permite el registro de las Prestaciones, estas deberán ser registradas en el sistema que se defina y posteriormente remitidas a Admisión para ser registradas en el SIGGES
- ❑ En el caso de aquellas atenciones realizadas por otros servicios clínicos o de apoyo diagnóstico durante la estadía en la unidad de emergencia estas deberán ser registrar en el sistema correspondiente y luego remitidas a Admisión para su registro en el SIGGES.
- ❑ En el caso de las consultas de especialistas realizadas a pacientes en la unidad de emergencia, estas deberán ser registradas en el Informe Diario de Atenciones del Servicio Clínico correspondiente, y remitidas diariamente al **SOME** para ser digitadas en el SIGGES.

Excepción de prestaciones y garantías

Hay situaciones en las cuales una prestación AUGÉ garantizada no puede ser realizada. En el marco de la ley 19.966, decreto supremo N° 44, artículo 11 que señala: “No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, casos fortuitos o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la Isapre”.

Para tales efectos, se han definido como causales imputables al beneficiario:

- j) inasistencia
- k) la expresión de la voluntad del paciente o sus representantes de rechazar el prestador o el tratamiento.
- l) otra causa³⁴

Para fines de funcionamiento del sistema público se entenderá que no se configura incumplimiento de garantía de oportunidad, cuando por algunas de las causales anteriormente señaladas como imputables al beneficiario, se justifique (documentadamente) la no realización o postergación de una prestación garantizada.

34 En el caso de situaciones de fuerza mayor, las que deben estar oficializadas por la Autoridad Sanitaria correspondiente, es posible exceptuar garantías (desgún la definición explícita que se haya realizado ante la situación), con la causal de Excepción otras, explicitando “fuerza mayor”

En esos casos el profesional tratante deberá consignar en la Historia Clínica las razones médicas que respaldan la decisión de no realizar una prestación garantizada.

Además deberá informar al **SOME**, para que éste pueda ingresar la información en el **SIGGES**. Para ello puede utilizarse el **Formulario de Excepción de Garantía** del anexo.)

La justificación deberá constar en documento específico para ello denominado "*Formulario de Justificación de la no realización o postergación de una prestación*", y obligatoriamente deberá contener la firma del paciente o su representante. Dicho formulario tiene su correlato en el Sistema SIGGES.

Se define como inasistencia, la ausencia o no presentación del paciente o beneficiario a una citación formal y conocida por él para una prestación, asociada a un problema de salud GES.

No se entenderá incumplimiento de garantía de oportunidad GES, cuando el prestador documente la inasistencia del beneficiario, a través del citado formulario, a 2 citaciones en los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad mayores a 15 días (15 o más), y a 1 citación para los problemas de salud que tengan garantías de oportunidad con plazos inferiores a 15 días (14 o menos).

Procedimientos para la eliminación de registros erróneos en el SIGGES

El Encargado de **SOME** – Estadística deberá revisar diariamente una muestra de las nóminas de cotejo de modo de ir verificando la calidad y oportunidad del registro.

- ❑ La eliminación de registros erróneos deberá ser realizada por el encargado del establecimiento a quién se haya delegado esta tarea o deberá ser solicitada al Monitor de Registro del Servicio de Salud Respectivo. Cada solicitud de eliminación de registros en el sistema deberán ser realizadas en un formulario correspondiente.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. El formulario deberá ser confeccionado por el establecimiento que ingresó el documento al sistema y que solicita la eliminación del evento o caso GES, completando todos los datos que le son requeridos.
2. El formulario deberá identificar el nombre y apellido del Monitor de Registro del establecimiento que solicita la eliminación, Este puede ser respaldado por el SDM del Hospital o Director de Consultorio APS, según corresponda, quien deberá refrendarlo con su nombre y firma.
3. El formulario llevará un folio correlativo anual. Formato: 0000/2005; 0000/2006.
4. La eliminación se solicitará en forma inmediata a la detección del error.
5. El formulario será remitido al Monitor de registro vía e-mail o FAX al Departamento de Estadística e Información en Salud de la Dirección de Servicio de Salud. Además se oficiará la solicitud respectiva.

6. Los establecimientos en los cuales se haya delegado la función de Eliminación desde el Servicio de Salud hacia el Monitor de registro local deberán mantener los formularios respectivos en el Departamento de Estadística e Información en salud del propio establecimiento.
7. El Departamento de Estadística e Información, mantendrá un archivo con numeración correlativa según orden de llegada de todas las solicitudes recepcionadas.
8. El funcionario responsable de realizar la eliminación del evento o caso erróneo, deberá en primer término verificar el error informado revisando la Cartola del Paciente en el SIGGES.
9. Verificado el error, procederá a eliminar el evento o caso GES requerido, dejando consignada en el formulario respectivo, el folio correlativo, la causa o motivo de la eliminación, la fecha de eliminación, el resultado del proceso, y las observaciones que estime pertinentes.
10. En los casos en que el procedimiento sea realizado en el Servicio de Salud, este deberá informar al establecimiento del procedimiento ejecutado, detallando fecha de realización y resultado de la eliminación. Si el procedimiento resulta fallido deberá a la Mesa de Ayuda del SIGGES. La información al Establecimiento podrá ser enviada vía Fax o e-mail.
11. Finalmente dejará archivada y bajo resguardo la solicitud procesada.
12. Los establecimientos por su parte, deberán mantener archivados los formularios de eliminación de casos, los que podrán ser solicitados para revisiones en cualquier momento, para efectos de auditoria y otros. La responsabilidad de su resguardo es del Monitor de Registro del establecimiento, el archivo debe permanecer bajo resguardo según la normativa vigente por un período de 5 años.
13. El formulario debe contener al menos los siguientes campos:
 - ☐ Servicio de Salud: indicar el Servicio de Salud al cual pertenece el establecimiento que solicita la eliminación.
 - ☐ Establecimiento: corresponde al establecimiento que está solicitando la eliminación.
 - ☐ Código Establecimiento: Registrar código de Establecimiento que solicita la Eliminación.
 - ☐ Fecha de Solicitud: corresponde a la fecha en que se solicita la eliminación.
 - ☐ RUN: corresponde al número de RUN del paciente.
 - ☐ Si es Recién Nacido sin RUN, indicar el RUN de la madre o padre beneficiario con que haya sido ingresado al SIGGES.
 - ☐ Nombre del paciente: él o los nombres y apellidos del paciente con eventos o casos a eliminar.
 - ☐ Problema de Salud y subproblema: indicar a cuál de los problemas de salud en régimen, (si corresponde) se refiere la solicitud de eliminación anexo 1.
 - ☐ Documento: Marcar el tipo de documento a eliminar:
 - ☐ Indicar la fecha y el número de folio del documento a eliminar.
 - ☐ Marcar con una X la causa de la eliminación. En caso de marcar Otros especificar la causa.
 - ☐ Fecha de eliminación: Registrar la fecha en que el funcionario del Depto de Estadística eliminó el evento en SIGGES.
 - ☐ Eliminación Exitosa: Marcar con una X si la eliminación fue exitosa.
 - ☐ Eliminación Fallida: Marcar con una X si la eliminación fue fallida.
 - ☐ Nombre y Firma del funcionario que ejecuta la eliminación: Auto explicativo.
 - ☐ Fecha del informe al establecimiento: Registrar la fecha en que se le comunicó al Establecimiento la eliminación del evento solicitado.
 - ☐ Observaciones: Indicar cualquier situación que estime conveniente señalar.

CAPITULO VI

Salidas del SIGGES y su Aplicación

- *Salidas del SIGGES relacionadas a la verificación del Registro.*
- *Salidas del SIGGES Para el Monitoreo de Casos y Garantías GES.*

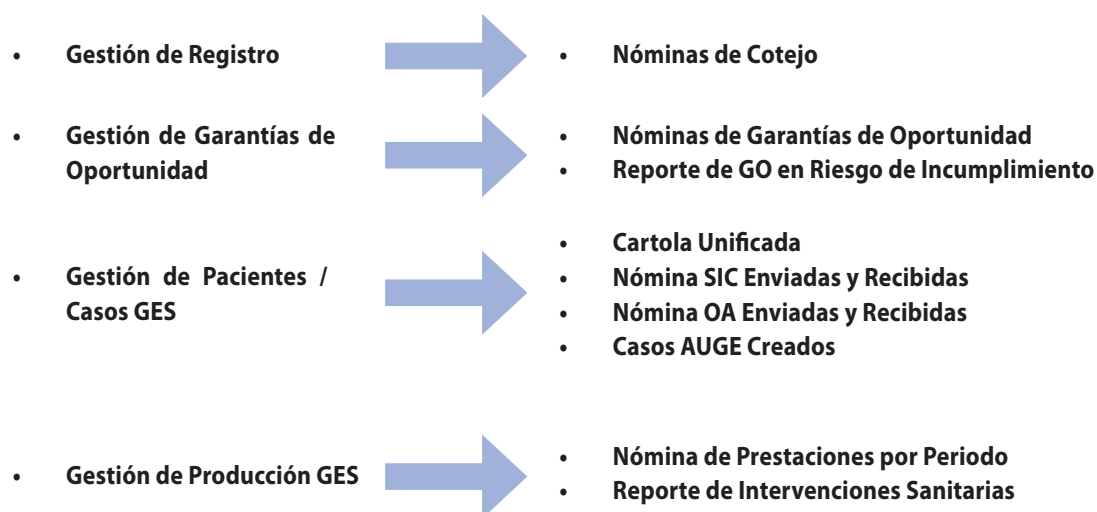
Salidas del SIGGES y su Aplicación

El **SIGGES**, en una primera etapa, privilegia la generación de salidas de uso local. De este modo, los usuarios del **SIGGES** que ingresan información (funcionarios de **SOME** y/o de otras instancias en los establecimientos de salud) podrán cotejar diariamente que el registro de datos sea el correcto

A su vez, los encargados **GES** de los establecimientos y Servicios de Salud podrán monitorear los casos **AUGE** a través de los reportes y alarmas que el **SIGGES** genere, a fin de tomar las medidas de gestión correspondientes y dar solución al cumplimiento de las garantías de oportunidad para el paciente.

La exportación de algunas salidas a planillas Excel permitirá además generar indicadores locales y verificar periódicamente el cumplimiento de garantías y compromisos de gestión relacionados, a partir de una mayor elaboración de esta información en las unidades de Estadísticas e Información de Salud.

Salidas SIGGES



Salidas del SIGGES relacionadas a la verificación del Registro.

Para verificar la calidad de los registros en los establecimientos, los Encargados de las Unidades de Estadísticas cuentan con las Nóminas de Cotejo. En estas nóminas se muestran los principales campos de cada uno de los documentos ingresados según la fecha de ingreso. Permite obtener nóminas de hasta siete días para cada establecimiento

Las nóminas de Cotejo disponibles son:

- ☐ Nomina de Cotejo Solicitud Interconsulta
- ☐ Nómina de Cotejo Informe de Proceso Diagnóstico
- ☐ Nomina de Cotejo Orden de Atención
- ☐ Nómina de Cotejo Citaciones
- ☐ Nómina de Cotejo Prestaciones Otorgadas
- ☐ Nómina de Cotejo Creación Manual de Caso
- ☐ Nómina de Cotejo Planilla de Ingreso IAM
- ☐ Nómina de Cotejo Casos AUGE APS
- ☐ Nómina de Cotejo de Cierre de Casos y Excepción de Garantías de Oportunidad
- ☐ Nómina de Cotejo de Eliminaciones

Cartola Unificada del Paciente

- ☐ **Objetivo:** Informar los datos de un paciente, los casos AUGE creados y sus Garantías, y todos los hitos registrados para ese paciente en el SIGGES sin importar las vías de ingreso.
- ☐ **Perfil Usuario:** Ingreso SIGGES, Supervisor de Servicio de Salud, Monitoreo e Informes
- ☐ **Filtros:** Rut del Paciente

☐ **Frecuencia:** Por Demanda

☐ **Contenido:**

- Datos del Paciente
- **Casos Auge**
- Hitos

Salidas del SIGGES para el Monitoreo de Casos y Garantías GES

- ☐ El SIGGES tiene una serie de salidas que le permiten monitorear los casos AUGE y las garantías por establecimientos, servicios o problemas de salud.
- ☐ Un tipo de salidas son las que constituyen Cuadros resúmenes de las variables seleccionadas.
- ☐ Otro tipo de salidas constituyen listados sobre las variables definidas

Cuadros Resumen:

- ☐ Monitoreo de Garantía de Oportunidad Acumulado según cumplimiento
- ☐ Monitoreo de Garantías de Oportunidad en Riesgo de Incumplimiento por Servicio de Salud / Establecimiento
- ☐ Monitoreo de Garantías de Oportunidad en Riesgo de Incumplimiento por Problema de Salud
- ☐ Casos Auge Creados en Periodo por Servicio de Salud
- ☐ Casos Auge Creados en Periodo por Problema de Salud

Listados o Nóminas

- ☐ Nómina de Pacientes AUGE
- ☐ Nómina de Garantías Vigentes
- ☐ Nómina de Garantías Vencidas
- ☐ Nómina de Garantías Cerradas

Cartola Unificada del Paciente

- ☐ **Objetivo:** Informar los datos de un paciente, los casos AUGE creados y sus Garantías, y todos los hitos registrados para ese paciente en el SIGGES sin importar las vías de ingreso.
- ☐ **Perfil Usuario:** Ingreso SIGGES, Supervisor de Servicio de Salud, Monitoreo e Informes
- ☐ **Filtros:** Rut del Paciente
- ☐ **Frecuencia:** Por Demanda
- ☐ **Contenido:**
 - Datos del Paciente
 - **Casos Auge**
 - Hitos

Salidas relacionadas a Prestaciones y al Proceso de Facturación.

- ❑ Existen diferentes reportes relacionados a las prestaciones realizadas por los establecimientos.
- ❑ La Nómina de Prestaciones por Período y la Nómina de Prestaciones por Paciente muestra las prestaciones registradas por los establecimientos como realizadas a los pacientes.
- ❑ El Reporte de Facturación muestra las prestaciones que han sido “validadas” por el FONASA y que se considerarán para el proceso de Facturación.
- ❑ Finalmente la Nómina de Prestaciones Facturables sin Contexto AUGE muestra una serie de prestaciones que podrían llegar a ser facturables si se demuestra que fueron realizadas a casos AUGE.

CAPITULO VII

Anexos

- *Formularios e Instrucciones.*
- *Hitos o Eventos a Registrar en el SIGGES.*
- *Glosario de Términos*
- *Aranceles prestaciones Trazadoras AUGE y Prestaciones AUGE APS.*

ANEXO 1: Formularios e Instrucciones

SOLICITUD DE INTERCONSULTA O DERIVACIÓN

		Día		Mes		Año		FOLIO N°	
		FECHA SOLICITUD						HORA:	
		Para ser llenado en Admisión							
		1. Servicio de Salud		2. Establecimiento					
		3. Especialidad		4. Unidad					
		5. Nombre		6. Historia Clínica					
		Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres			
		7. RUT		8. Si es recién nacido, RUT de padre o madre beneficiaria					
		9. Sexo		10. Fecha de nacimiento		11. Edad			
		Masc.		Día		Mes		Años	
		Fem.		Mes		Año		Días	
				Hora				Meses	
								Horas	
		12. Domicilio (calle, número interior, bloque (block), villa, localidad)							
		13. Comuna de residencia		14. Teléfono 1		15. Teléfono 2		16. Correo electrónico	
		Para ser llenado por el(la) profesional que solicita la interconsulta o derivación							
		17. Se deriva para atención en:		Establecimiento		18. Especialidad			
		19. Se envía a consulta para:		Confirmación diagnóstica		Seguimiento		Especificar	
				Realizar Tratamiento		Otro			
		20. Hipótesis diagnóstica o diagnóstico: (anote con letra legible y sin siglas)							
		21. ¿Sospecha problema de salud AUGE?		Especificar problema		22. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX			
		NO		SI					
		23. Fundamentos del diagnóstico							
		24. Exámenes realizados							
		Para ser llenado en Admisión, excepto la firma							
		25. Nombre		Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres	
		26. RUT				Firma del Profesional			

Formulario de Solicitud de Interconsulta o Derivación

1. OBJETIVO

Instrumento que utiliza el profesional, para derivar un paciente a la atención de un especialista, con el fin de comprobar una hipótesis diagnóstica.

2. ESTRUCTURA

- Identificación del Establecimiento de Salud de origen
- Datos de identificación del paciente
- Datos Clínicos
- Datos del Profesional que solicita la interconsulta

3. RESPONSABLES

El llenado del formulario es de responsabilidad compartida entre Admisión y el profesional que solicita la interconsulta.

4. INSTRUCTIVO DE LLENADO

Folio N°:	Será dado automáticamente por el Sistema una vez que sea registrado el documento y deberá ser escrito en el formulario en este espacio.
Fecha solicitud:	Debe registrarse el día, mes y año en que se está extendiendo el formulario (dd/mm/aaaa)
Hora:	Debe registrarse con 2 dígitos la Hora y los minutos en que se está llenando el formulario Ej.: Dos y cuarto de la tarde = 14:15
1.-Servicio de Salud:	Debe registrarse el nombre del Servicio de Salud al que pertenece el establecimiento que está solicitando la Interconsulta.
2.-Establecimiento:	Debe registrarse el nombre del establecimiento de Salud que está solicitando la Interconsulta.
3.-Especialidad:	Deberá consignarse aquí el Servicio o Especialidad al cual pertenece el profesional que está solicitando la Interconsulta. (Ej.: Servicio de Urgencia, Policlínico de Obstetricia, Medicina, Medicina Familiar u otro).
4.- Unidad:	Debe registrar si corresponde, la Unidad a la que pertenece el profesional que da origen a la solicitud (Ej. Unidad de Patología Cervical, Unidad de Diálisis u otro)

DATOS DEL PACIENTE:

5.- Nombre:	Deberá registrarse el apellido paterno, luego el materno y finalmente los nombres del paciente, contra Cédula de Identidad a la vista.
6.- Historia Clínica:	Deberá consignarse uno a uno en cada casillero, el número asignado a la Historia Clínica del paciente.
7.-RUT:	Deberá registrarse uno a uno los números correspondientes al Rol Unico Tributario del paciente (mismo número de la Cédula de Identidad que la tendrá a la vista)
8.- Si es Recién Nacido (R.N), RUT de padre o madre beneficiario:	Si el causante de la interconsulta es un Recién Nacido, deberá consignarse el RUT de uno de sus padres (mamá o papá). Al igual que los N° anteriores, contra cédula de identidad a la vista.
9.- Sexo:	Registrar con una X en el casillero correspondiente a masculino si el paciente es un hombre; o en el de femenino si se trata de una mujer.
10.-Fecha de nacimiento:	Deberá registrarse la fecha de nacimiento, en los casilleros correspondientes a día – mes y año). La hora de nacimiento es sólo requerida en el caso que se trate de un Recién Nacido.
11.- Edad:	Registrar <u>en casilleros horizontales el número</u> que corresponda y en <u>los casilleros verticales marcar con una "X"</u> , si dichos números indican años, meses, días u horas.
12.- Domicilio:	Deberá consignar el nombre de la calle, avenida o pasaje, número de la casa o departamento, número o letra del Block, nombre la población o Villa y nombre de la ciudad donde reside el paciente.
13.- Comuna de residencia:	Deberá indicarse el nombre de la Comuna de residencia del paciente.
14.- Teléfono 1:	Debe registrarse uno a uno y en cada casillero el número de teléfono, ya sea de red fija o celular, del paciente y/o familiar, a objeto de una rápida ubicación, si fuere necesario.
15.- Teléfono 2:	Debe registrarse uno a uno y en cada casillero el número de teléfono, alternativo ya sea de red fija o celular, del paciente y/o familiar, a objeto de una rápida ubicación, si fuere necesario.
16.- Correo electrónico:	Si el paciente lo tuviere, deberá registrarse en forma clara el nombre de su e-mail.

DATOS CLINICOS

17.-Se deriva para atención en Establecimiento:	Debe registrar claramente el nombre completo del Establecimiento al que será enviado el paciente con la interconsulta.
18.- Especialidad:	Debe registrar el nombre de la especialidad del profesional al cuál se le está solicitando la Interconsulta. (Ej.: Cardiología, Endocrinología, etc.)
19.- Se envía a consulta para:	Aquí se debe dejar consignado con una X si se trata de realizar una Confirmación diagnóstica o para Realizar Tratamiento o para Seguimiento o si es para Control de la Especialidad o alguna otra razón la cual se deberá especificar.
20.- Hipótesis Diagnóstica:	El profesional deberá consignar claramente cuál es su hipótesis diagnóstica, sin ocupar siglas.
21.- ¿Sospecha problema de Salud AUGE?:	Se debe registrar con una "X" frente al casillero que corresponda, si el profesional considera que el paciente presenta una patología AUGE. Si ha marcado "SI" deberá consignar en letras el problema de salud que presenta el paciente.

INFORME DEL PROCESO DIAGNÓSTICO

Para ser llenado en Admisión		FECHA INFORME		Día	Mes	Año	FOLIO N°	HORA:	
1. Servicio de Salud		2. Establecimiento							
3. Especialidad		4. Unidad							
DATOS DEL(A) PACIENTE	5. Nombre		6. Historia Clínica						
	Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres				
	7. RUT		8. Si es recién nacido, RUT de padre o madre beneficiaria						
	9. Sexo	☐ Masc. ☐ Fem.	10. Fecha de nacimiento	Día	Mes	Año	Hora	11. Edad	☐ Años ☐ Días ☐ Meses ☐ Horas

Para ser llenado por el(la) profesional		13. ¿Confirma que el diagnóstico pertenece al sistema AUGE?	☐ NO ☐ SI
12. Problema de salud AUGE			
14. Subgrupo o subproblema de salud AUGE			
15. Diagnóstico (anote el(los) diagnóstico(s) con letra legible y sin siglas)			
16. Fundamentos del diagnóstico			
17. Tratamiento e indicaciones			
18. El tratamiento deberá iniciarse a más tardar el:		Día	Mes
		Año	

Para ser llenado en Admisión, excepto la firma	
25. Nombre	
Apellido Paterno	Apellido Materno
Nombres	
26. RUT	Firma del Profesional

Original: Establecimiento que realiza la confirmación

Formulario de Informe del Proceso de Diagnostico

1.- DEFINICION

Instrumento que utiliza el profesional de especialidad para confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica de un caso en sospecha AUGÉ, indicando además la fecha en que el paciente deberá dar inicio al tratamiento que se indique.

2.- OBJETIVO

Comunicar formalmente al SOME el diagnóstico del paciente referido, a fin de que se registre en el SIGGES.

3.- ESTRUCTURA

- Identificación del establecimiento que recibe la referencia
- Datos del (de la) paciente
- Datos Clínicos
- Datos del profesional

4.- RESPONSABLE

Debe ser llenado por el profesional responsable de la confirmación o descarte del problema de salud.

5.- INSTRUCTIVO DE LLENADO

Folio N°:	Será dado automáticamente por el sistema una vez que sea registrado el documento y deberá ser escrito en el formulario en este espacio.
Fecha y hora del Informe:	Debe registrarse con 2 dígitos el día, mes y el año en que se está llenando el informe, consignando la hora.
1.- Servicio de Salud:	Debe indicarse el nombre del Servicio de Salud a que pertenece el establecimiento que realiza la confirmación o descarte del problema de salud.
2.- Establecimiento:	Registrar nombre (sin utilizar siglas) del establecimiento que atiende al paciente.
3.- Especialidad:	Nombre de la especialidad a la que pertenece el profesional que está realizando el presente Informe
4.- Unidad:	Debe registrar si corresponde, la Unidad a la que pertenece el profesional que extiende el informe (Ej. Unidad de Patología Cervical, Unidad de Diálisis u otro)

DATOS DEL (DE LA) PACIENTE

5.- Nombre:	Autoexplicativo, teniendo cuidado de seguir el orden indicado (apellido paterno, materno y nombres)
6.- Historia Clínica:	Deberán registrarse uno a uno los números que conforman el N° de Historia Clínica del paciente.
7.- RUT:	Debe registrarse claramente, uno en uno el número del Rol Unico del paciente contra cédula de identidad a la vista.
8.- Si es Recién Nacido (R.N), RUT de padre o madre beneficiario:	Si se trata de un Recién Nacido, deberá consignarse el RUT de uno de sus padres (mamá o papá). Al igual que los N° anteriores, contra cédula de identidad a la vista.

9.- Sexo:	Registrar con una X en el casillero correspondiente a masculino si el paciente es un hombre; o en el de femenino si se trata de una mujer.
10.- Fecha de nacimiento:	Deberá registrarse la fecha de nacimiento, en los casilleros correspondientes a día – mes y año). La hora de nacimiento es sólo requerida en el caso que se trate de un Recién Nacido.
11.- Edad:	Registrar <u>en casilleros horizontales el número</u> que corresponda y en <u>los casilleros verticales marcar con una "X"</u> , si dichos números indican años, meses, días u horas.

DATOS CLINICOS

12.- Problema de Salud Auge:	Se debe registrar el nombre del problema de salud Auge (sin emplear siglas).
13.- ¿ Confirma que el diagnóstico pertenece al sistema AUGE?:	Autoexplicativo, colocar X frente a Sí, si es afirmativo y frente a No, si no lo confirma
14.- Subgrupo o subproblema de salud AUGE:	Dependiendo del protocolo ciertos problemas de salud están subdivididos en subcategorías, por ejemplo: Disrrafia abierta y cerrada.
15.- Diagnóstico:	Se deberá registrar con letra legible el o los diagnósticos concluyentes después de la atención médica.
16.- Fundamentos del Diagnóstico:	Aquí se consignará los fundamentos clínicos que tuvo el Profesional para confirmar el problema de salud
17.- Tratamiento e Indicaciones:	Deberá consignar tratamientos e indicaciones a seguir por el paciente.
18.- El tratamiento deberá iniciarse a más tardar el...	Deberá establecer día, mes y año en que el paciente deberá dar inicio a su tratamiento, con la fórmula dd/mm/aaaa. Esta fecha permite diferir la fecha de inicio de tratamiento en algunos problemas de salud, según Guías Clínicas. Por ejemplo en el caso de una embarazada con cáncer cervicouterino, se difiere el tratamiento hasta después del parto.

DATOS DEL PROFESIONAL

19.- Nombre:	Deberá registrarse el apellido paterno, luego el materno y los nombres del profesional que está atendiendo al paciente.
20.- RUT:	Deberá consignar uno en uno los números del Rol Unico del profesional.
Firma profesional:	Aquí deberá estampar la firma el profesional que está emitiendo el presente Informe.

CIERRE DEL CASO

FOLIO Nº _____	FECHA INFORME	Día [][]	Mes [][]	Año [][][][]	HORA: [][] [][]
1. Servicio de Salud		2. Establecimiento			
3. Especialidad					
DATOS DEL (LA) PACIENTE					
5. Nombre				4. Historia clínica [][][][][][][][][][]	
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres	
6. RUT	[][][][][][][][][][]	7. SEXO (marcar con X)	☐ Masculino ☐ Femenino	8. Teléfono [][][][][][][][][][]	
9. Problema de Salud AUGÉ			10. Diagnóstico (anote el(los) diagnóstico(s) con letra legible y sin siglas)		
Rama: _____					
11. CAUSAL DE CIERRE DEL CASO (marcar causa con X)					
A: Decisión del Profesional Tratante					
☐ Criterios de Exclusión (según protocolos)					
☐ Término de tratamiento					
B. Relacionado con el seguro					
☐ Término de Garantía					
☐ Cambio de Previsión					
C. ☐ Fallecimiento → Fecha Defunción					
Día [][] Mes [][] Año [][][][]					
D. Causas atribuibles al paciente o a sus representantes:					
☐ D1 Por inasistencia (según protocolo)					
☐ D2 Por expresión de la voluntad del paciente o de sus representantes					
☐ Rechazo del Prestador Designado					
☐ Rechazo del Tratamiento					
☐ Otra causa _____					
Acompaña Documento ☐ SI ☐ NO					
D. Otra causa ☐ _____					
12. OBSERVACIONES					
DATOS DEL RESPONSABLE					
13. Nombre					
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres	
14. RUT	[][][][][][][][][][]	Firma del Profesional _____			

Este documento se debe anexas a la historia clínica

Formulario Cierre de Caso Auge

1.- OBJETIVO

Dejar establecido formalmente, el cierre de un caso con su causal, evento que será ingresado en el Sistema de Información.

2.- ESTRUCTURA

- Identificación del establecimiento que está cerrando el caso.
- Datos de identificación del paciente.
- Datos Clínicos
- Datos del responsable del cierre del caso AUGE.

3.- RESPONSABLE

Es responsabilidad compartida entre el SOME y el Profesional responsable de la atención del paciente.

4.- INSTRUCTIVO DE LLENADO

Folio N°:	Número correlativo automático, lo da el Sistema al momento de ingresar los datos el formulario.
Fecha:	Debe registrarse el día(dd), mes(mm) y año(aaaa) en que se está extendiendo el formulario.
1.- Servicio de Salud:	Debe registrarse el nombre del Servicio de Salud al que pertenece el establecimiento que está cerrando el caso.
2.- Establecimiento:	Debe registrarse el nombre del establecimiento de salud que está cerrando el caso.
3.- Especialidad:	Deberá consignarse aquí el Servicio o especialidad al cual pertenece el profesional que está cerrando el caso.
4.- Unidad:	Debe registrar si corresponde, la Unidad a la que pertenece el profesional que extiende el informe (Ej. Unidad de Patología Cervical, Unidad de Diálisis u otro)

DATOS DEL PACIENTE	
5.- Nombre:	Deberá registrarse el apellido paterno, apellido materno y luego los nombres del paciente.
6.- Historia Clínica:	Deberá consignarse uno a uno en cada casillero, el número asignado a la Historia Clínica del Paciente.
7.- RUN:	Deberá registrarse uno a uno los números correspondientes al Rol Unico Tributario del paciente.
8.- Si es Recién Nacido (R.N), RUN de padre o madre beneficiario:	Si se trata de un Recién Nacido, deberá consignarse el RUN de uno de sus padres (mamá o papá).
9.- Sexo:	Marcar con una X en el casillero correspondiente a Masculino si el paciente es un varón, en el casillero correspondiente a Femenino si se trata de una paciente mujer.
10.- Fecha de nacimiento:	Deberá registrarse la fecha de nacimiento, en los casilleros correspondientes a día – mes y año). La hora de nacimiento es sólo requerida en el caso que se trate de un Recién Nacido.
11.- Edad	Registrar <u>en casilleros horizontales el número</u> que corresponda y en <u>los casilleros verticales marcar con una "X"</u> , si dichos números indican años, meses, días u horas.

DATOS CLÍNICOS

12.- Problema de Salud AUGE:	Se debe registrar el Problema de Salud AUGE que se está cerrando.
13.- Subgrupo o subproblema de salud AUGE:	Se debe señalar si corresponde el subproblema AUGE según protocolo (se refiere a un área específica derivada del problema de salud) Ej. Cáncer Cervicouterino "Preinvasor".
14.- Diagnóstico:	Registrar, con letra clara, el diagnóstico del caso que se está cerrando.
15.- Causa de cierre del caso:	Se debe registrar con una X frente a la causal que corresponda
A) Decisión profesional tratante:	
- No cumple criterios de Inclusión.	Se refiere a aquellos casos en que la derivación para el problema de salud marcado no es pertinente. Esto es diferente del descarte del problema en el cual si hubo pertinencia en la derivación
= Criterios de exclusión:	Se refiere al cierre del caso por alguna condición del paciente (de salud u otra) indicada según protocolo.
- Término de tratamiento:	Se cierra por haber terminado el tratamiento indicado por el médico.
B) Relacionado con el Seguro:	
- Término de Garantía.	Se cierra el caso por haber cumplido con el tratamiento que está garantizado según protocolo.
- Cambio de Previsión:	Se debe registrar la X, cuando el paciente ha dejado de ser beneficiario de FONASA
C) Fallecimiento:	
- Fecha de Defunción:	En este caso deberá registrarse la fecha del deceso, en los casilleros que corresponda en la forma dd/mm/aaaa.
D) Causas atribuibles al paciente o sus representantes.	
- Por inasistencia:	Si el paciente deja de concurrir a la atención programada por un período determinado según Guías Clínicas.
- Por expresión de la voluntad del paciente o de sus representantes.	
• Rechazo del prestador designado:	Si el paciente no desea ser atendido por el prestador que se le asignó para el problema de salud que le aqueja.
• Rechazo del tratamiento:	Si el paciente voluntariamente está rechazando el tratamiento dado por el médico tratante para ese caso.
• Por otra causa:	Otra, que no sea de las anteriores descritas, debiendo ser especificada.
- Acompaña documento:	Marque con una X la opción SI o NO. Si el paciente trae algún documento en que manifiesta alguna de las causas anteriormente descritas, éste documento debe quedar como respaldo en la Historia Clínica, debiendo el paciente además firmar su historia clínica.
16. Observaciones:	Espacio para texto libre.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL CIERRE DEL CASO

17.- Nombre:	Deberá registrarse el apellido paterno, luego el materno y los nombres del funcionario que está cerrando el caso.
18.- RUT:	Deberá consignar uno en uno los números del Rol Unico del funcionario responsable del cierre del caso.
Firma profesional:	Aquí deberá estampar la firma el profesional que está emitiendo el presente documento.

CONTENIDOS DE LA HOJA DIARIA NECESARIAS PARA EL REGISTRO DE CASOS AUGE APS (IRA BAJA, NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, DIABETES MELLITUS TIPO 2, HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL, EPILEPSIA NO REFRACTARIA, SALUD ORAL).

Para registrar la información **se puede adecuar los registros locales** para asegurarse de contar con la información necesaria para el seguimiento del AUGE (hoja diaria, farmacia, etc).

1.- OBJETIVO

El establecimiento deberá adaptar y distribuir los formularios entre los diferentes profesionales y personal, junto a un instructivo de registro.

Los registros con la información solicitada deben ser comunicados al SOME diariamente, para ser consolidados o ingresados al Sistema de Información cuando este esté disponible, y poder de este modo monitorear sus garantías.

2.- RESPONSABLES

El profesional que realiza una atención a un paciente con un Problema AUGE, ya sea en la etapa de sospecha, confirmación o tratamiento, es responsable de registrar diariamente este evento, en los instrumentos que disponga el establecimiento.

3.- DATOS BÁSICOS

Los datos siguientes son los mínimos necesarios para la identificación del caso, y el seguimiento de las garantías.

- a. **Servicio de Salud:** Servicio de Salud del que depende el establecimiento.
- b. **Establecimiento:** Centro asistencial de salud donde se realiza la atención.
- c. **Especialidad:** En aquellos casos en que se realicen atenciones de especialista en los establecimientos de la APS, se podrá consignar la especialidad de acuerdo a la tabla de especialidades.

Las atenciones habituales por profesionales de la APS deben consignarse como especialidad **Medicina Familiar** en el SIGGES

- d. **Fecha:** La correspondiente al día en que se realizó la atención, Este debe ser el mismo día de llenado del formulario.
- e. **RUN:** del paciente, autoexplicativo.
- f. **Nombre:** del paciente.
- g. **Problema de Salud:** Escriba uno de los Problemas de Salud AUGE que es posible sospechar y /o Confirmar en la APS, con letra legible y sin siglas.
 - IRA Baja
 - Neumonía Adquirida en la Comunidad
 - Hipertensión Arterial Esencial
 - Epilepsia No refractaria
 - Diabetes Mellitus tipo 2

- Salud Oral.
- Colectomía Preventiva del Cáncer de vesícula
- Vicios de refracción
- Depresión
- Ortesis
- EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
- Asma Moderada y Severa
- Artrosis de cadera y/o rodilla
 - a. Artrosis moderada leve de Cadera
 - b. Artrosis Moderada a leve de Rodilla
- Urgencia Odontológica
- Salud Oral integral 60 años
- Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas

En el caso de la **Retinopatía Diabética**, si en el establecimiento de APS se dispone de oftalmólogo, este podrá registrar esta confirmación en la Hoja Diaria de Atenciones de marcando que se trata de una atención de oftalmólogo. En el SIGGES esta podrá ser registrada en la Hoja APS.

- h. **Decisión:** Se debe marcar en aquella atención en que se produzca la decisión del profesional de sospechar un problema de salud AUGE, o de confirmar o sospechar.
- **Sospecha:** se debe marcar esta celda en aquella primera consulta en que se sospecha de la existencia del problema de salud. Para efectos de monitorear garantías, esta columna sólo aplica para los problemas AUGE que tienen una etapa de sospecha: Hipertensión Arterial Esencial, Diabetes Mellitus Tipo 2, y Neumonía Adquirida en la Comunidad; colectomía, Asma Bronquial, EPOC...
 - **Confirmación Diagnóstica o Descarte:** Consignar en aquella consulta en que el el profesional confirma o descarta el diagnóstico del problema AUGE. En el caso del problema IRA, esto ocurre en la primera consulta; en el Problema de Salud oral del niño de seis años se registra en esta etapa en el momento en que el paciente solicita la atención en el establecimiento (fecha de la solicitud de la atención).
- i. **Nombre y RUN del profesional o técnico que otorga la atención**

Contenidos Mínimos de una Orden de Atención

Los Contenidos Mínimos de una Orden de Atención si esta debe ser ingresada al SIGGES son los siguientes:

❑ **Datos de Origen**

- Fecha y hora de emisión de la Orden
- Servicio de salud y Establecimiento de origen de la orden
- Especialidad de Origen de la orden

❑ **Datos del Paciente**

- RUN
- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno
- N° de Ficha Clínica

❑ **Datos Clínicos**

- Problema y subproblema de Salud cuando se trata de un Problema AUGE
- Diagnóstico (s) en texto libre
- Establecimiento destino (incluye establecimientos privados)
- Especialidad Destino
- Prestaciones solicitadas
- Otra Indicación: en caso de no indicar una prestación. o de indicar que es necesario que el paciente pase a la etapa de seguimiento, para los casos AUGE.
- Fecha propuesta para realización de la indicación o prestación (se requiere en algunos problemas de salud)

❑ **Datos Profesional Solicitante**

- Nombres Apellido Paterno, Apellido Materno Profesional Solicitante
- RUN Profesional Solicitante

Eliminación de Documentos

Contenidos Mínimos de Un formulario de Eliminación de Documentos en el SIGGES

- ☐ Servicio de Salud: indicar el Servicio de Salud al cual pertenece el establecimiento que solicita la eliminación.
- ☐ Establecimiento: corresponde al establecimiento que está solicitando la eliminación.
- ☐ Código Establecimiento: Registrar código de Establecimiento que solicita la Eliminación
- ☐ Fecha de Solicitud: corresponde a la fecha en que se solicita la eliminación
- ☐ RUN: corresponde al número de RUN del paciente.
- ☐ Si es Recién Nacido sin RUN, indicar el RUN de la madre o padre beneficiario con que haya sido ingresado al SIGGES
- ☐ Nombre del paciente: él o los nombres y apellidos del paciente con eventos o casos a eliminar
- ☐ Problema de Salud y subproblema: indicar a cuál de los problemas de salud en régimen, (si corresponde) se refiere la solicitud de eliminación anexo 1.
- ☐ Documento: Marcar el tipo de documento a eliminar:
- ☐ Indicar la fecha y el número de folio del documento a eliminar
- ☐ Marcar con una X la causa de la eliminación. En caso de marcar Otros especificar la causa.
- ☐ Fecha de eliminación: Registrar la fecha en que el funcionario del Depto de Estadística eliminó el evento en SIGGES.
- ☐ Eliminación Exitosa: Marcar con una X si la eliminación fue exitosa
- ☐ Eliminación Fallida: Marcar con una X si la eliminación fue fallida
- ☐ Nombre y Firma del funcionario que ejecuta la eliminación: Autoexplicativo.
- ☐ Fecha del informe al establecimiento: Registrar la fecha en que se le comunicó al Establecimiento la eliminación del evento solicitado.

Observaciones: Indicar cualquier situación que estime conveniente señalar

Excepción de Garantía

Justificación de la no realización o postergación de una prestación (Excepción de Garantía)

FOLIO Nº _____ FECHA INFORME

Día		
Mes		
Año		

 HORA:

1. Servicio de Salud		2. Establecimiento																										
3. Especialidad																												
DATOS DEL (LA) PACIENTE		4. Historia clínica <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										
5. Nombre																												
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres																								
6. RUT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>													7. SEXO (marcar con X) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>Masculino</td></tr><tr><td>Femenino</td></tr></table>		Masculino	Femenino	8. Teléfono <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
Masculino																												
Femenino																												
9. Problema de Salud AUGÉ		10. Diagnóstico (anote el(los) diagnóstico(s) con letra legible y sin siglas)																										
Subproblema																												
11. CAUSAL DE EXCEPCIÓN (marcar causa con X)																												
11.1. Decisión del Profesional Tratante																												
11.1.1. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Criterios de Exclusión (según protocolo)																												
11.1.2. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Indicación Médica																												
11.2. Causas atribuibles al paciente o a sus representantes																												
11.2.1. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Inasistencia																												
Días de Inasistencia <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Fecha Inasistencia <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>Día</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Año</td><td></td><td></td></tr></table>		Día			Mes			Año												
Día																												
Mes																												
Año																												
11.2.2. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Rechazo del Prestador Designado																												
11.2.3. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Rechazo de la atención o procedimiento garantizado																												
Prestación Rechazada:		Código <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																										
Descripción (glosa) _____																												
11.2.4. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Otra Causa definida por el paciente: (explicitar) _____																												
12. OBSERVACIONES (complementar selección anterior) _____																												
DATOS DEL RESPONSABLE: (profesional tratante; paciente o su representante)																												
13. Nombre																												
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombres																								
14. RUT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>													Firma del Profesional _____															

Este documento se debe anexar a la historia clínica

FICHA DE ATENCIÓN DE URGENCIA

Contenidos Mínimos de la Ficha de Atención de Urgencia para ingresar datos al SIGGES

- ❑ Datos de Identificación del establecimiento
 1. Servicio de Salud
 2. Establecimiento
 3. Especialidad
 4. Número de Folio

- ❑ Datos de Identificación del Paciente:
 - a. RUN³⁵
 - b. Nombres y Apellidos
 - c. Fecha de nacimiento edad
 - d. Sexo
 - e. Domicilio
 - f. Previsión
 - g. **Consultorio de Origen o establecimiento donde está inscrito el paciente.** Esto facilitará la derivación del paciente.

- ❑ Deberá consignar también datos relacionados a la consulta actual:
 1. Fecha y Hora de la atención
 2. Motivo de consulta
 3. Lugar y causa de accidente en caso de tratarse de un accidente
 4. Medio de acceso al establecimiento (ambulancia, Otro vehiculo ...)

- ❑ En el documento se deberá identificar el funcionario que realizó la admisión con el nombre y RUN de este además de su firma.

- ❑ **Hipótesis diagnóstica Inicial:** en el caso de los problemas de salud GES, este momento corresponde a la sospecha del problema. Se debe consignar la fecha y hora en la cual el profesional emite la primera sospecha.
 - **Hipótesis diagnóstica Inicial:** en texto libre
 - **Fecha y Hora**

- ❑ **Problema de salud GES:** se debe consignar cuando el problema de salud que se esté tratando sea un problema de salud GES. Se debe especificar el problema de salud GES que se sospecha, según el listado del anexo
 - **AUGE:** si /no
 - **Problema de Salud:** según listado del anexo

35 En el caso de los Recién nacidos sin RUN se consigna el RUN de la madre o el padre, y se identifica que se trata de un recién nacido sin RUN.

- ❑ **Indicación de exámenes y procedimientos diagnósticos:** Las indicaciones para la realización de exámenes y procedimientos diagnósticos pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia.
 - Fecha y Hora además
 - Examen o procedimiento solicitado.
 - Unidad o servicio que debe realizarla: destino

- ❑ **Realización de exámenes y procedimientos diagnósticos:** La realización de exámenes y/o procedimientos diagnósticos pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia.
 - Fecha y hora de realización
 - Unidad que realizó el examen.
 - Examen o procedimiento realizado (listado de prestaciones de FONASA)
 - Si se trata de un problema de salud GES se debe además especificar el Problema de salud correspondiente.

- ❑ **Confirmación Diagnóstica:** en el momento que el profesional determina que se produjo la confirmación diagnóstica, este se debe consignar el Formulario de Atención de Urgencia.
 - Diagnóstico Final: en texto libre
 - Problema GES Subproblema
 - Confirmación o el descarte de este problema.
 - Fecha y hora en que esto ocurre.

- ❑ **Indicación de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos:** Las indicaciones para la realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia
 - Fecha y Hora
 - Tratamiento y/o procedimiento Terapéutico.
 - Unidad que realizó el procedimiento

- ❑ **Realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos:** La realización de Tratamientos y procedimientos Terapéuticos en la Unidad de Emergencia pueden estar consignadas en el Formulario de Atención de Urgencia.
 - Fecha y hora de realización.
 - Tratamiento o Procedimiento
 - Problema de salud GES correspondiente

- ❑ **Indicación del destino del paciente:** Una vez que se termina la etapa de atención del paciente en la Unidad de Emergencia, se debe consignar el destino del paciente en el Formulario de Atención de Urgencia. Se debe permitir consignar la
 - Fecha y Hora de la indicación.
 - Si se indica la Hospitalización del paciente en el mismo establecimiento se debe
 - especificar la unidad de destino del paciente.
 - Si se indica el traslado para la Hospitalización en otro establecimiento se debe especificar el
 - nombre Establecimiento
 - Especialidad
 - Servicio de Salud de destino..
 - Si se requiere que el paciente sea evaluado por otro especialista en la consulta ambulatoria del mismo establecimiento,
 - especialidad.
 - Si el paciente es remitido a su consultorio el profesional deberá especificar en el Formulario de Atención de Urgencia esta indicación. A partir de los datos del Formulario, el SOME deberá registrar una Solicitud de Interconsulta y derivación dirigida al establecimiento de origen consignado en dicho formulario especificando los diagnósticos y prestaciones realizadas durante la atención de urgencia.
- ❑ *Identificación del o de los profesionales tratantes:* El formulario deberá contener la información suficiente para individualizar al o los profesionales que registraron información en el Formulario de Atención de Urgencia. Al menos se debe considerar
 - Nombres y Apellidos
 - RUN.
- ❑ **Notificación y Toma de Conocimiento de caso Ges:** En aquellas atenciones que correspondan a un problema de salud GES, el formulario deberá permitir registrar el nombre y la firma del paciente o de su representante una vez que toma conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
 - Firma o huella digital del paciente
 - Nombre y RUT de la persona notificada en caso de no corresponder al paciente (persona responsable)
 - Fecha y hora e notificación

ANEXO 2

Instructivo de Registro de Atenciones Otorgadas por la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)

El presente instructivo busca aclarar y estandarizar la forma de registro de las prestaciones realizadas en la **UAPO**, de tal manera de asegurar que éste sea homogéneo, y permita evaluar el funcionamiento de estas unidades.

Para ello se han distinguido dos tipos de registro:

1. **Registro REM:** en este contexto se identifican dos tipos de atenciones según el profesional que las otorga: la consulta oftalmológica y la consulta tecnólogo médico. Para la primera, las atenciones realizadas deben ser registrada en REM A07, en la sección A.3, "médicos especialistas contratados por el establecimiento". Para la segunda, las atenciones realizadas deben ser registradas en REM A07, en la sección B, "consultas y controles por otros profesionales en la especialidad". Con esto se diferenciará de la actividad del tecnólogo médico del centro de APS, que deberá ir registrado en el REM A04, sección B, "consultas de profesionales no médicos".
2. **Registro SIGGES:** Actualmente el paciente derivado a la UAPO puede presentar dos condiciones:
 - 2.1 Derivación desde una lista de espera y/o de consulta APS sin sospecha de patología GES
 - 2.2 Derivación desde consulta médica de APS con sospecha de patología GES.

En consideración al punto 2.1 se aclara:

La derivación **sin** sospecha de patología GES, puede generar en la consulta del especialista la confirmación de un problema de salud GES. (Catarata; Retinopatía Diabética, Vicio refracción mayor de 65 años o estrabismo menor de 9 años), esta decisión **deberá** constar además de la ficha clínica en **la emisión de los documentos GES** definidos para tal efecto: IPD (Informe Proceso Diagnóstico) que confirma y la Notificación de paciente GES (que informa al paciente su condición de paciente GES, dejando constancia firmada de su parte de tal notificación).

En este caso no se hace acepción al descarte, porque no existe una sospecha GES de origen. El médico especialista de la UAPO sólo deberá emitir el IPD de confirmación, gatillando el caso desde el tratamiento.

Del registro en SIGGES propiamente tal considérese luego del **IPD que confirma** el problema de salud GES, los siguientes aspectos específicos para cada uno:

1. Cataratas: Luego ingresar una Interconsulta (SIC) para **tratamiento**, derivando el caso al establecimiento de nivel secundario que según la red sea el responsable para ello.
2. Retinopatía diabética: luego ingresar una Orden de Atención para tratamiento, derivando el caso al establecimiento de nivel secundario que según la red sea el responsable para ello.
3. Vicio refracción mayor de 65 años: en el caso de confirmar Otros Vicios refracción (distinto de presbicia Pura) luego ingresar una Orden de Atención para **tratamiento- entrega de lentes**, derivando el caso al establecimiento de nivel secundario que según la red sea el responsable para ello. Si el problema de salud confirmado es presbicia Pura se deberá coordinar con el consultorio la entrega de los lentes.
4. Estrabismo: luego ingresar una Orden de atención para el **tratamiento médico o para el qco.** derivando el caso al establecimiento de nivel secundario que según la red sea el responsable para ello.

Nota: En el caso de una confirmación por Retinopatía Diabética asociada a una clasificación de estadio leve o moderado, sin indicación de tratamiento, se deberá ingresar el IPD que define esta condición confirmando el caso y para luego aplicar un cierre de caso aludiendo a la causal: **“por otra causa”** agregando en la observación que **“no existe indicación de tratamiento”**. Con esto frente a nuevas derivaciones por fondo de ojo alterado que este paciente posea se garantizarán nuevamente la oportunidad de su diagnóstico.

En consideración al punto 2.2 se aclara:

La derivación con sospecha de patología GES hacia la UAPO, debiera constituir una medida de excepción, ya que el responsable de la resolución de este problema de salud desde la confirmación es el establecimiento de nivel secundario, a través del flujo conocido para cada Ges oftalmológica.

Por lo que esta derivación debiera solo ocurrir si el establecimiento responsable del caso determina incapacidad de resolver e informa los pacientes nominados al gestor de red quién en búsqueda de otra opción de atención para estos pacientes, pudiera definir que es el consultorio en conjunto con la UAPO una alternativa factible.

Teniendo ese precedente, esta consulta oftalmológica deberá determinar una confirmación o un descarte del problema de salud GES. (Catarata; Retinopatía Diabética, Vicio refracción mayor de 65 años o estrabismo menor de 9 años), esta decisión deberá constar además de la ficha clínica en la emisión de los documentos GES definidos para tal efecto: IPD (Informe Proceso Diagnóstico) que confirma o descarta, y la Notificación de paciente GES (que informa al paciente su condición de paciente GES, dejando constancia firmada de su parte de tal notificación).

Para ambos tipos de pacientes de los puntos anteriores, el registro en la plataforma SIGGES de los documentos GES deberá ser realizado por el funcionario designado en el establecimiento de atención primaria al cual la UAPO se encuentra adosada. En relación a esto, el establecimiento de origen en SIGGES, es el consultorio que está registrando, y el establecimiento de destino el hospital que asume el tratamiento. No existe código de establecimiento para las UAPO.

Si por otro lado, la UAPO se encuentra adosada a un establecimiento hospitalario, el proceso de registro descrito, será realizado desde este establecimiento, en lo que respecta al IPD, PO de consulta y la OA o SIC para tratamiento. Se entiende que la sospecha o íter consulta de lista de espera fue ingresada por el establecimiento de atención primaria al que pertenece el paciente.

Con respecto al Monitoreo de Garantías activadas para estas GES:

Como es de conocimientos y tal como se señaló anteriormente, las garantías de tto. de cataratas, y estrabismo no se traspasan a los reportes de monitoreo de los establecimiento de destino, aunque se ingrese una OA o una SIC (según se indicó anteriormente) que traslade la responsabilidad al establecimiento de destino.

Para estos casos el Monitor SIGGES del establecimiento deberá resguardar en conjunto con el monitor del establecimiento el proporcionar dicha información mediante reportes periódicos de esos problemas de salud.

Se sugiere implementar un calendario de reportes enviados vía email cada 30 días a lo menos que permitan al establecimiento de destino visualizar y considerar este reporte adjunto al monitoreo de las garantías activadas que el evidencie para la gestión de su propio establecimiento.

En el caso de los Vicio de refracción y del estrabismo menor de 9 años (tto. Medico) el sistema permite trasladar la garantía a través de la OA direccionada al establecimiento responsable de la entrega de dicho tratamiento: lentes para ambos casos o solo parches para el segundo.

ANEXO 3

Lista de Problemas y Subproblemas AUGÉ

Nombre del decreto	Nombre SIGGES	sospecha	Confirmación
1. Insuficiencia Renal Crónica Terminal	Insuficiencia Renal Crónica Terminal	No hay	Insuficiencia Renal
2. Cardiopatías congénitas operables en menores de 15 años	Cardiopatías Congénitas Operables	Cardiopatía congénita Operable	Cardiopatía congénita operable Grave
			Cardiopatía congénita operable no Grave
3. Cáncer Cervicouterino	Cáncer Cervicouterino	Cáncer cervicouterino	cáncer cervicouterino Preinvasor
			cáncer cervicouterino Invasor
4. Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos	Alivio del Dolor	No hay	Alivio del Dolor
5. Infarto Agudo del Miocardio	Infarto Agudo del Miocardio	Infarto Agudo del Miocardio	Infarto agudo del Miocardio
		No hay	Prevención de By-pass coronario
6. Diabetes Mellitus Tipo 1	Diabetes Mellitus Tipo 1	descompensación DM1 (episodio)	descompensación DM1 (episodio)
		Diabetes Mellitus tipo 1	Diabetes Mellitus tipo 2
7. Diabetes Mellitus Tipo 2	Diabetes Mellitus Tipo 2	Diabetes Mellitus tipo 2	Diabetes Mellitus tipo 2
8. Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Cáncer de Mama	Cáncer de Mama derecha	Cáncer de Mama derecha
		cáncer de mama izquierda	cáncer de mama izquierda
9. Disrrafias Espinales	Disrrafias Espinales	Disrrafia espinal Abierta	Disrrafia espinal Abierta
		Disrrafia espinal cerrada	Disrrafia espinal cerrada
10. Tratamiento Quirúrgico de Escoliosis en menores de 25 años	Escoliosis	No hay	Escoliosis
11. Tratamiento Quirúrgico de cataratas	Cataratas	Cataratas	Catarata Izquierda
			Catarata derecha
			Catarata Bilateral

Nombre del decreto	Nombre SIGGES	sospecha	Confirmación
12. Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años o más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Artrosis de Cadera	No hay	Artrosis de cadera derecha Artrosis de cadera izquierda
13. Fisura Labiopalatina	Fisura Labiopalatina	Fisura labio palatina	Fisura Labial Fisura Palatina Fisura Labio palatina
14. Cáncer en menores de 15 años: leucemia, linfoma y tumores sólidos.	Cáncer en Menores de 15 Años	leucemia en menores de 15 años Linfomas y tumores sólidos en menores de 15 años	leucemia en menores de 15 años Linfomas en menores de 15 años Tumores sólidos en menores de 15 años
15. Esquizofrenia .	Esquizofrenia .	Esquizofrenia	equizofrenia
16. Cáncer de Testículo en personas de 15 años y más	Cáncer de Testículo (Adultos)	cáncer de testículo	Cáncer de testículo unilateral izquierdo cáncer de testículo unilateral derecho Cáncer de testículo bilateral
17. Linfomas en personas de 15 años y más	Linfoma en Adultos .	Linfoma en adultos	Linfoma en adultos
18. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida	VIH (Tratamiento triterapia) *	No corresponde	No corresponde
19. IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años	Infección Respiratoria Aguda	Ira Baja	Ira Baja
20. Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más	Neumonía	Neumonía	Neumonía
21. Hipertensión Arterial Esencial en personas de 15 años o más	Hipertensión arterial esencial	Hipertensión arterial	Hipertensión arterial
22. Epilepsia No Refractaria	Epilepsia No Refractaria	Epilepsia no refractaria	epilepsia no refractaria
23. Salud Oral Integral para niños de 6 años	Salud Oral	salud oral menor de 6 años	salud oral menor de 6 años

Nombre del decreto	Nombre SIGGES	sospecha	Confirmación
24. Prematurez	Prematurez	Prevención parto prematuro	Prevención parto prematuro
		Retinopatía del Prematuro	Retinopatía del Prematuro
		No corresponde	Displasia Broncopulmonar del prematuro
		Hipoacusia del prematuro	Hipoacusia del prematuro
25. Trastornos de Generación de Impulso y Conducción en personas de 15 años y más que Requieren Marcapaso	Marcapaso	Trastorno de la conducción - marcapaso	Trastorno de la conducción - marcapaso
26. Colectectomía Preventiva del Cáncer de Vesícula en Personas de 35 a 49 años, sintomáticos.	Colectectomía Preventiva	Colectectomía preventiva	Colectectomía preventiva
27. Cáncer Gástrico.	Cáncer Gástrico	Cáncer gástrico*	Cáncer gástrico
28. Cáncer de Próstata en Personas de 15 años y más.	Cáncer De Próstata	No hay	Cáncer de próstata
29. Vicios de Refracción de Personas de 65 años y más.	Vicios de Refracción	Vicios de refracción	Prebicie pura
			Otros Vicios de refracción
30. Estrabismo en Menores de 9 años.	Estrabismo	Estrabismo	Estrabismo
31. Retinopatía Diabética.	Retinopatía Diabética	Retinopatía Diabética	Retinopatía Diabética
32. Desprendimiento de Retina Regmatógeno no Traumático.	Desprendimiento de Retina	desprendimiento de retina	desprendimiento de retina
33. Hemofilia.	Hemofilia	Hemofilia	Hemofilia
34. Depresión en Personas de 15 Años y más.	Depresión	Depresión	Depresión
35. Tratamiento Quirúrgico de la Hiperplasia Benigna de la Próstata en Personas Sintomáticos.	Hiperplasia de Próstata	No hay	Hiperplasia de Próstata

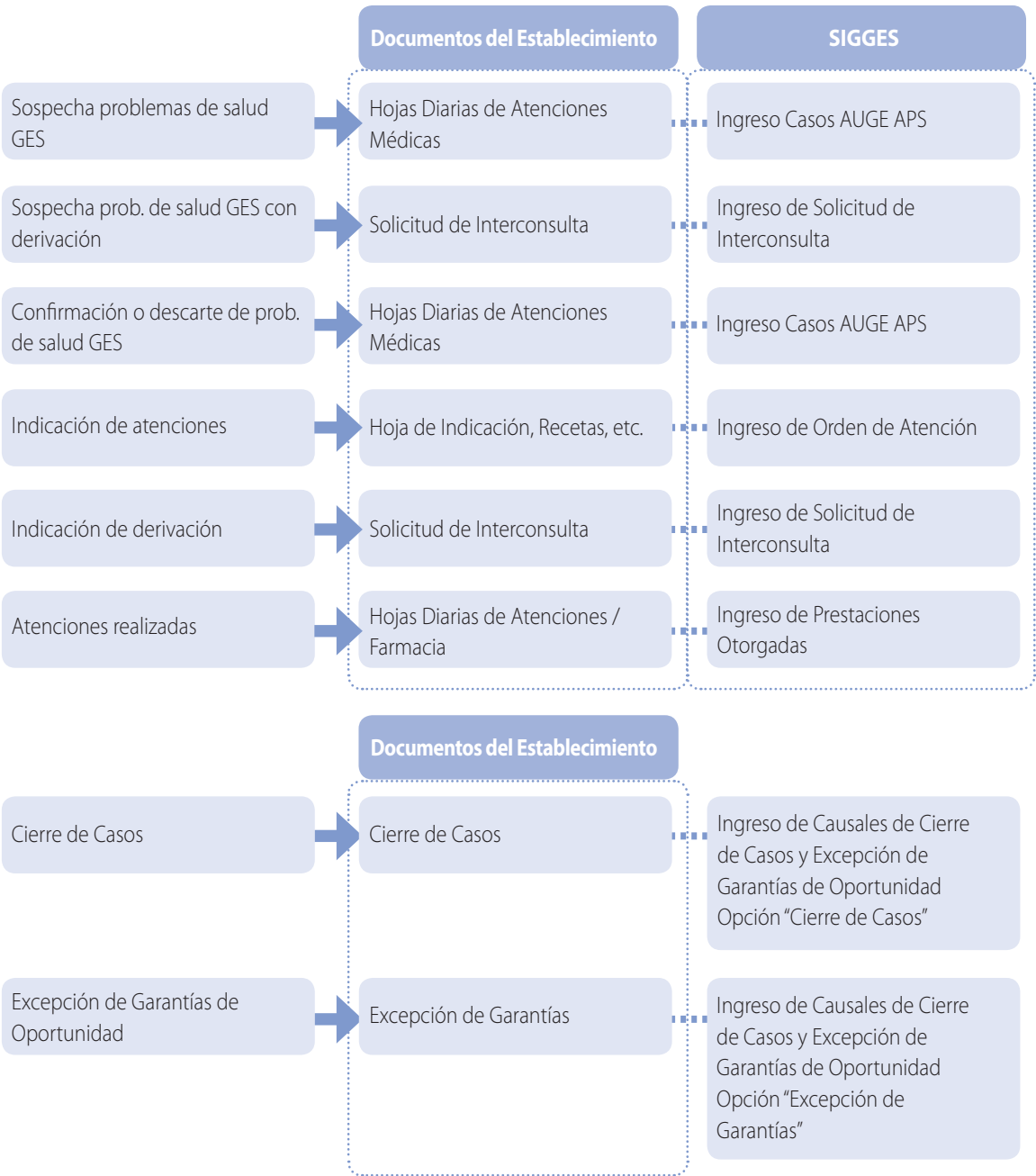
Nombre del decreto	Nombre SIGGES	sospecha	Confirmación
36. Órtesis (o Ayudas Técnicas) para Personas de 65 Años y más.	Órtesis	Ortesis	Ortesis
37. Accidente Cerebrovascular Isquémico en Personas de 15 años y más.	Accidente Cerebrovascular	Accidente Cerebrovascular	Accidente cerebrovascular
38. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de Tratamiento Ambulatorio.	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	EPOC	EPOC
39. Asma Bronquial Moderada y Severa en Menores de 15 años.	Asma Bronquial	Asma Bronquial	Asma Bronquial
40. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido	Síndrome De Dificultad Respiratoria	Síndrome de dificultad respiratoria	Síndrome de dificultad respiratoria
41. Tratamiento Médico en personas de 55 años y más con Artrosis de Cadera y/o rodilla, Leve o Moderada	Tratamiento Médico Artrosis de Cadera Leve o Moderada	Artrosis de cadera o rodilla leve o moderada	Artrosis de cadera leve o moderada
			Artrosis de rodilla leve o moderada
42. Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de Aneurismas Cerebrales	Hemorragia por Aneurismas Cerebrales	Hemorragia subaracnoidea por aneurismas cerebrales rotos	Hemorragia subaracnoidea por aneurismas cerebrales rotos
43. Tratamiento quirúrgico de Tumores Primarios del Sistema Nervioso Central en personas de 15 años o más.	Tumores Primarios SNC	Tumor primario de SNC	Tumor primario de SNC
44. Tratamiento quirúrgico de Hernia Núcleo Pulposos Lumbar	Hernia Núcleo Pulposos Lumbar	No hay	hernia al núcleo pulposos
45. Leucemia en personas de 15 años y más.	Leucemia Adulto	Leucemia Adulto Aguda	Leucemia Adulto Aguda
		Leucemia Adulto Crónica	Leucemia Adulto Crónica
46. Urgencia Odontológica ambulatoria	Urgencias Odontológicas	No corresponde	No corresponde

Nombre del decreto	Nombre SIGGES	sospecha	Confirmación
47. Salud Oral integral del adulto de 60 años	Salud Oral Adulto	Salud oral personas de 60 años	Salud oral personas de 60 años
48. Politraumatizado Grave	Politraumatizado Grave	Politraumatizado Grave	Politraumatizado Grave
49. Atención de urgencia del Traumatismo Craneoencefálico Moderado o Grave	Traumatismo Craneoencefálico Moderado o Grave	Traumatismo Craneoencefálico Moderado o Grave	Traumatismo Craneoencefálico Moderado o Grave
50. Trauma Ocular Grave	Trauma Ocular Grave	Trauma ocular Grave	Trauma ocular Grave
51. Fibrosis Quística	Fibrosis Quística	No Hay	Fibrosis Quística
52. Artritis Reumatoide	Artritis Reumatoide	No hay	Artritis reumatoide
53. Consumo Perjudicial o Dependencia De Riesgo Bajo a Moderado de Alcohol y Drogas en Personas Menores de 20 Años	Dependencia de Alcohol y Drogas	dependencia de alcohol y Drogas	dependencia de alcohol y Drogas
54. Analgesia del Parto	Analgesia del Parto	Analgesia del parto	Analgesia del parto
55. Gran Quemado	Gran Quemado	Gran Quemado	Gran Quemado
56. Hipoacusia Bilateral en personas de 65 años y más que requieren Uso de Audífono	Hipoacusia Bilateral Adulto Uso de Audífono Requerido	No hay	Hipoacusia bilateral

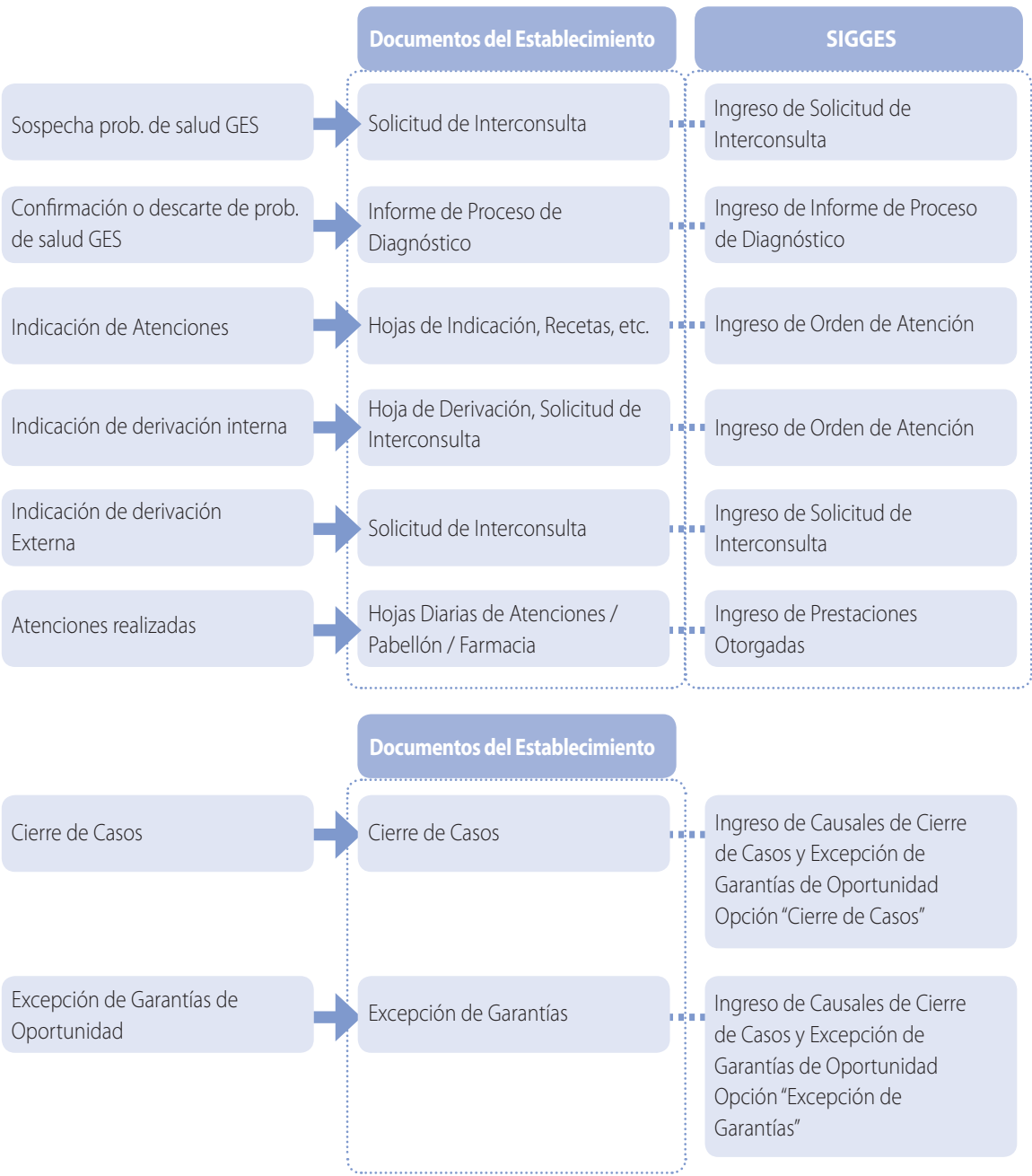
* Solo en mayores de 40 años

ANEXO 4

Hitos o Eventos a Registrar en el SIGGES en APS



En Nivel Secundario y Terciario



En Urgencia



ANEXO 5

Glosario de Términos

- ❑ **Admisión:** Unidad perteneciente al SOME que realiza la inscripción y citación de los pacientes.
- ❑ **Alerta de Ausencia de Citación:** Se aplica a las garantías de oportunidad cuyo evento de término sea una prestación. Para cada garantía de cada problema de salud se definirá el tiempo en que se alertará el hecho que no se ha realizado la citación correspondiente a la prestación otorgada. El tiempo de la Alerta se considera a partir de la ocurrencia del evento de inicio de la garantía de oportunidad. Una vez que se realiza la citación, se cierra esta alarma.
- ❑ **Alerta de Incumplimiento inminente:** Se produce cuando el evento de cierre no ha ocurrido y el tiempo de la garantía de oportunidad está próximo a su vencimiento. Está definido para todas las garantías de cada problema de salud.
- ❑ **Alerta de Citación fuera de plazo:** Alerta que se aplica a las garantías de oportunidad cuyo evento de término sea una prestación. Se activa durante el ingreso de citaciones, en que el SIGGES avisa al usuario que la fecha de citación supera a la fecha de término de garantía (el SIGGES pregunta si se desea grabar de todas formas). Si la grabación de la citación con plazo vencido se realiza de todas maneras, el usuario que monitorea recibe en ese momento un aviso de este hecho y además puede imprimir un reporte donde aparecen estos casos (Reportes de Monitoreo).
- ❑ **Alta:** El SIGGES no considera esta categoría, pero incluye concepto habitual de alta, en su acepción de "Mejorado", en la categoría "Término de tratamiento", como causa de cierre de caso.
- ❑ **Archivo de Historias Clínicas:** Unidad perteneciente al SOME, encargada de custodiar y proporcionar las historias clínicas de los pacientes a las distintas unidades de un establecimiento.
- ❑ **Atención Primaria:** Nivel de atención constituido por Consultorios y Postas Rurales, que prestan atención ambulatoria de salud.
- ❑ **AUGE:** Plan que establece Garantías Explícitas de Salud.
- ❑ **Cambio de Previsión:** Término de la calidad de beneficiario (FONASA o ISAPRE) por incorporación a un seguro privado o a CAPREDENA o DIPRECA (mientras no sea promulgada la ley y no abarque a los beneficiarios de esos sistemas de seguro de enfermedad y maternidad).
- ❑ **Causas de Cierre:** Corresponden a las causas por las cuales se puede cerrar un caso GES. Estas pueden ser por decisión del profesional tratante (Criterios de exclusión; Término del tratamiento) Relacionadas con el seguro (Termino de la garantía; Cambio de previsión, Fallecimiento del paciente), Causas atribuibles a los pacientes (Inasistencia, Rechazo al prestador de la red por parte del paciente, Rechazo al tratamiento, Otros atribuibles al paciente) y por Descarte del problema de salud.

- ❑ **Cierre de caso por Causa Atribuible al paciente:** ya sea que expresamente y por escrito declara que no desea continuar su tratamiento atenderse en la red de prestadores definida o por otra causa declarada; o por inasistencia.
- ❑ **Cierre de Caso:** Evento que tiene como consecuencia que el paciente no continuará atendiéndose por un caso determinado en el sector salud. El caso pasa al estado de “caso cerrado” por algún problema de salud. El egreso no necesariamente cierra el registro de datos sobre este paciente. Los registros más habituales para cerrar el caso son el IPD en el caso del descarte, y el Formulario de Cierre para las otras causales.*
- ❑ **Cobertura Financiera Adicional (CFA):** El financiamiento del 100% de los copagos originados sólo por enfermedades o condiciones de salud contenidas en las GES, que superen un deducible.
- ❑ **Contrarreferencia:** Es el informe que emite el especialista, dirigido al profesional del establecimiento o Servicio Clínico de origen, en el que da respuesta a la interconsulta, excepto cuando el establecimiento o servicio de origen sea un servicio de urgencia. Este informe se llena en el Formulario de Informe del Proceso de Diagnóstico o bien en el formulario Respuesta a Interconsulta.
- ❑ **Crónico:** Es una condición de salud determinada clínicamente, que se instala en la vida del paciente en alguna etapa de su ciclo de vida, generalmente asociada a la idea de que se trata de una patología no completamente recuperable. Es el diagnóstico del paciente el que determina esta condición y no es necesario especificar en cada caso que se trata de una enfermedad crónica.
- ❑ **Deducible:** Suma de los copagos realizados³⁶, que habrán de ser acumulados por cada evento para tener derecho a la CFA, en un período máximo de doce meses desde el primer copago:
 - Afiliados a Isapres y Grupo D Fonasa: 29 cotizaciones mensuales, legales o pactadas, por cada evento asociado a las GES, el que no excederá de UF 122. En caso de existir más de un evento en 12 meses, 43 cotizaciones mensuales, legales o pactadas, no pudiendo exceder de UF 181.
 - Grupo C Fonasa: 21 cotizaciones mensuales por evento; más de un evento: 31 cotizaciones.
 - Trabajadores independientes Fonasa grupo D: 2 veces el promedio de sus ingresos mensuales; más de un evento: 3.
 - Trabajadores independientes Fonasa grupo C: 1,47; más de un evento: 2,16.
- ❑ **DEIS:** Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud.

* Ver definiciones de estados del paciente. Los casos no podrán ser cerrados definitivamente excepto cuando se trate de fallecidos. Además, el cierre debe ser considerado según el protocolo, ya que pueden existir acciones de salud que se continúen, aun habiendo fallecido el paciente. Por ejemplo la terapia psicológica a la familia en el caso de los Cuidados Paliativos. Adicionalmente, el SIGGES debe permitir ingresar después del fallecimiento todas aquellas prestaciones realizadas al paciente en vida, que no alcanzaron a ser registradas antes de su muerte, para lo cual se establecerá un plazo de cierre de los registros de la cuenta de prestaciones del caso (quince días).

36 No se contabilizan los copagos que tengan origen en prestaciones no cubiertas por las GES o que hayan sido otorgadas fuera de la red de prestadores, salvo tratándose de una condición garantizada que implique urgencia vital o secuela funcional grave, y que requiera hospitalización inmediata, en cuyo caso los copagos efectuados fuera de la red se contabilizan hasta el momento en que el paciente se encuentra en condiciones de ser trasladado.

- ❑ **Descarte:** evento que consiste en rechazar la hipótesis diagnóstica acerca de la enfermedad que desencadenó el ciclo de atenciones. Implica la emisión del “Informe del Proceso de Diagnóstico”.
- ❑ **Encargado GES:** Funcionario designado oficialmente para monitorear el funcionamiento del sistema GES en un establecimiento o servicio de salud.
- ❑ **Especialidad:** Unidad clínica que proporciona consulta profesional en hospitales y establecimientos de nivel secundario o terciario.
- ❑ **Estadística:** Unidad perteneciente al SOME, encargada de la recolección, procesamiento y distribución de la información estadística del establecimiento.
- ❑ **Estados:** Diferentes fases por las que pasa un caso AUGÉ, que van sucediéndose a medida que se producen distintos eventos en la historia del paciente. Los cambios de estado los gatilla el SIGGES internamente, sin necesidad de ser digitados. Ver Primera Parte, Generalidades.
- ❑ **Eventos:** Hitos (atenciones, actos administrativos, ocurrencias en el ciclo de una enfermedad, etc.) que van sucediéndole al paciente en el tiempo.
- ❑ **Examen de medicina preventiva:** Plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la morbimortalidad o sufrimiento, debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias. Solo deberán ser consideradas aquellas enfermedades o condiciones para las cuales existe evidencia del beneficio de la detección temprana en un individuo asintomático. El Ministerio de Salud definirá, entre otros, los procedimientos, contenidos, plazo y frecuencia del examen, fijando condiciones equivalentes para los sectores público y privado. Los resultados deben ser manejados como datos sensibles y las personas examinadas no podrán ser objeto de discriminación a consecuencia de ellos.
- ❑ **Formulario de Cierre de Caso:** formulario que debe llenar el especialista cuando proceda el cierre de un caso AUGÉ. (ver Anexo)
- ❑ **Formulario de Creación de Caso:** formulario que debe llenar la matrona o médico obstetra para registrar el ingreso de un prematuro recién nacido como caso AUGÉ. (ver Anexo)
- ❑ **Formulario de Informe Proceso Diagnóstico:** formulario que debe llenar el especialista para confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica registrada en la Solicitud de Interconsulta. (ver Anexo)
- ❑ **Formulario de Solicitud de Interconsulta:** formulario que extiende un profesional a un paciente, para que sea referido a un especialista. (ver anexo)
- ❑ **Garantía activa o vigente:** Corresponde a la garantía en que ha ocurrido sólo el evento de inicio para el cumplimiento de la garantía.
- ❑ **Garantía Cerrada:** Corresponde a la garantía en que han ocurrido ambos eventos, el de inicio y el de término.
- ❑ **Garantías de Oportunidad Retrasadas:** ³⁷ Garantía respecto a la cual se ha sobrepasado el tiempo definido para la ocurrencia de los eventos o el tiempo definido por la garantía ya ocurrió

sin la presencia del segundo evento. Corresponde a aquellas que en el sistema SIGGES no presenta hito de cierre. En el SIGGES aparecen como Incumplidas sin hito. La medición del retraso se realiza utilizando el indicador “Porcentaje de retrasos de cumplimiento de garantías SIGGES” que corresponde al número de garantías retrasadas en el período de análisis sobre el total de garantías registradas en el período de estudio.

- ❑ **Garantías de oportunidad Cumplidas:** Garantía respecto a la cual se ha satisfecho el tiempo definido para la ocurrencia de los eventos. Se miden en el sistema SIGGES como la sumatoria de las *garantías cumplidas* (garantías cuyas prestaciones trazadoras fueron realizadas en los períodos máximos señalados en el decreto), *garantías incumplidas con hito* (garantías cuyas prestaciones trazadoras fueron realizadas en un plazo superior al señalado para el primer prestador en el decreto), *Garantías Vigentes* (garantías que están abiertas o vigentes, cuyo plazo aún no ha vencido), *garantías exceptuadas* (garantías que de acuerdo a los criterios de excepción (ordinario 1417 del 30 de Junio del 2006), han debido ser postergadas o contraindicadas por condiciones propias del paciente), y las *garantías cerradas* (corresponde a aquellas que de acuerdo a los criterios señalados en el ordinario 1913 del 09 de Julio del 2007, han sido cerradas a la fecha de corte).
- ❑ **Garantía Explícita de Protección Financiera:** Contribución que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones, la que deberá ser de un 20% del valor determinado en un arancel de referencia del **Régimen**³⁸. El arancel deberá aprobarse en el decreto supremo que establece las GES y sujetarse a los procedimientos de elaboración de éstas que contempla la ley.
- ❑ **Garantía Explícita de Acceso:** Obligación del Fondo Nacional de Salud y de las Instituciones de Salud Previsional de asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas a sus beneficiarios, en la forma y condiciones que determine el Decreto Supremo correspondiente.
- ❑ **Garantía Explícita de Calidad:** Otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley N° 19.937, en la forma y condiciones que determine el Decreto Supremo correspondiente.
- ❑ **Garantía Explícita de Oportunidad:** Plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el Decreto Supremo correspondiente. Dicho plazo considerará, a lo menos, el tiempo en que la prestación deberá ser otorgada por el prestador de salud de la red definida que corresponda en primer lugar; el tiempo para ser atendido por un prestador distinto, designado por el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, cuando no hubiere sido atendido por el primero; y, en defecto de los anteriores, el tiempo en que el prestador definido por la Superintendencia de Salud deba otorgar la prestación con cargo a las instituciones antes señaladas. No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario.

38 No obstante lo señalado, el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir el valor total de las prestaciones, respecto de los grupos A y B a que se refiere el artículo 29 de la ley N° 18.469, y podrá ofrecer una cobertura financiera mayor a la dispuesta en la Garantía Explícita de Protección Financiera a las personas pertenecientes a los grupos C y D señalados en el mismo artículo, de acuerdo con las normas establecidas en el Título IV de la ley N° 18.469.

- ❑ **Garantía explícita de Oportunidad retrasadas SIGGES fiscalizadas:** Fonasa de acuerdo a su obligación y atribuciones, en forma sistemática realiza procesos de fiscalización de las garantías en los establecimientos asistenciales, orientado a Puntos críticos, áreas en falencia y casos que ameritan anticipación al incumplimiento legal. En el caso de fiscalizaciones con foco dirigido a las garantías de oportunidad retrasadas en el SIGGES, en que se confirme efectivamente el retraso, se considerarán estas como retrasadas confirmadas por fiscalización.
- ❑ **Garantía excedida:** Corresponde a aquella garantía que se ha cerrado. Esta garantía que sólo tiene el evento de inicio; el segundo no ocurrirá debido a que existe una excepción como el cierre de caso; o bien que, ocurriendo ambos eventos fuera del plazo esperado, se ha ingresado una excepción que explica este hecho. Las excepciones pueden ser por decisión del profesional tratante (Criterios de exclusión; Indicación Médica), Causas atribuibles a los pacientes (Inasistencia, Rechazo al prestador de la red por parte del paciente, Rechazo al tratamiento, Otros atribuibles al paciente. Para el registro de esto se utiliza el Formulario de Excepción (ver anexo).
- ❑ **Garantías Explícitas en Salud (GES):** Condiciones relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud que se establezcan por Decreto Supremo. El Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional deberán asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios.
- ❑ **Garantías, Cálculo de tiempo de las:** Todas las garantías que vencen un día no hábil se postergan para el día hábil siguiente, para lo cual el sistema deberá manejar el calendario anual con días hábiles y no hábiles. Esto con excepción de aquellas consideradas de urgencia.
- ❑ **Garantías, Iteración de:** Se dice que una Garantía de Oportunidad es cíclica o iterativa cuando el evento de término de la garantía es a la vez el evento de inicio de una nueva garantía que tiene el mismo tiempo límite que la anterior, o sea que expresa continuidad. Esta garantía se aplica a los problemas de salud crónicos donde la entrega de medicamentos o el tratamiento es permanente.
- ❑ **Inasistencia:** Causa de egreso del SIGGES atribuible al paciente, se debe calificar de acuerdo a los Guías Clínicas clínicos de cada problema de salud.
- ❑ **Orden de atención:** Documento mediante el cual un profesional solicita que se efectúe una o más prestaciones a un paciente, tales como exámenes, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, etc. La prestación se ingresa en el establecimiento que la realiza, excepto cuando la otorga un establecimiento ajeno al SNSS. En este último caso lo ingresa el SOME del establecimiento donde se solicitó la prestación, basándose en una "orden de compra".
- ❑ **Prestación:** toda atención que proporciona un establecimiento a sus pacientes en: las unidades clínicas de consulta profesional, las unidades de apoyo diagnóstico o terapéutico, las unidades de hospitalización, los pabellones quirúrgicos y la farmacia.
- ❑ **Prima Universal:** Valor determinado por el Ministerio de Hacienda, expresado en unidades de fomento, al que deberán ajustarse las **GES**³⁹. Los cambios en el valor no podrán ser

39 Las GES no pueden generar un costo esperado individual promedio pertinente, del conjunto de los beneficiarios del Fonasa e Isapres, estimado para un período de doce meses, significativamente diferente de la Prima Universal que se haya establecido. Dicho costo deberá estimarse sobre la base de los Guías Clínicas referenciales que haya definido el Ministerio de Salud y de las demás normas que establezca un reglamento Minsal-Hacienda

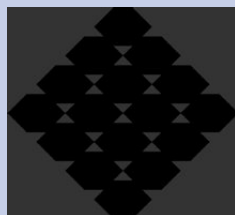
superiores a la variación experimentada por el Índice General Real de Remuneraciones por Hora, calculado por el INE.

- ❑ **Problema de Salud:** es una condición de salud, reconocida y tipificada. Para el SIGGES, un problema de salud es una instancia en la Lista de Problemas de Salud (LPS) determinadas por los respectivos Decretos.
- ❑ **Red Asistencial de cada Servicio de Salud:** Conjunto de establecimientos asistenciales públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos municipales de atención primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados que suscriban convenio con dicho Servicio
- ❑ **Referencia:** En el SIGGES se refiere al envío de la Solicitud de Interconsulta a un especialista, desde cualquiera de sus posibles orígenes (APS; Servicio de Urgencia, incluyendo SAPU; otro servicio clínico o especialidad del mismo o de otro establecimiento). Cuando el paciente se envía a hacerse un examen o tratamiento a otro establecimiento debe hacerse mediante una **"orden de atención"**, lo que no corresponde a una referencia.
- ❑ **Régimen General de Garantías en Salud:** Instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 18.469, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Establece las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud deberá cubrir a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la ley Nº 18.469.
- ❑ **Reingreso:** en esta etapa de desarrollo del sistema no es posible el reingreso. Un paciente que presenta nuevamente sospecha de un problema de salud previamente cerrado se crea como caso nuevo, si las definiciones de ingreso lo permiten.
- ❑ **Seguimiento:** Estado posterior a la etapa de tratamiento, en que el paciente recibe prestaciones de diferente índole, especialmente controles, inclusive exámenes de laboratorio o gabinete. Requiere que el paciente sea ingresado con una Solicitud de Interconsulta o una Orden de Atención que especifique el cambio de estado **"A seguimiento"**.
- ❑ **Servicio Clínico:** Unidad clínica de atención cerrada, donde se proporcionan servicios de hospitalización.
- ❑ **SIGGES, Sistema de Información para la Gestión de Garantías Explícitas en Salud:** Sistema de Información para la Gestión de Garantías en Salud. Sistema informático, diseñado para detectar puntos críticos, áreas en falencia y anticipación al incumplimiento legal en el sector público, apoya la gestión de las garantías constitutivas de derecho para los beneficiarios cuyo cumplimiento puede ser exigido por éstos ante su seguro respectivo y demás instancias que correspondan
- ❑ **Sistema de acreditación prestadores institucionales:** Proceso periódico de evaluación de los prestadores institucionales autorizados sanitariamente, respecto del cumplimiento de estándares mínimos de calidad requerida para la seguridad de los usuarios, fijados por el Ministerio de Salud
- ❑ **Sistema de registro de prestadores individuales de salud:** Inscripción en un listado de la Superintendencia de Salud, de prestadores individuales de salud, en el que constan sus especialidades y subespecialidades si las tuvieran.

- ❑ **SOME:** Sección de Orientación Médica y Estadística, existente en cada establecimiento de los servicios de salud.
- ❑ **Término de tratamiento:** causa de egreso del SIGGES, en que el profesional tratante especifica por escrito que el paciente no requiere continuar su tratamiento por determinado problema de salud. El paciente puede estar mejorado o no.
- ❑ **Traslado:** Evento mediante el cual el paciente es enviado para que continúe su tratamiento en otro establecimiento de salud, dejando de atenderse en el establecimiento donde estaba tratándose. Esto excluye a los casos en que parte del tratamiento es realizada en otro establecimiento en razón de la disponibilidad de recursos especializados, por ejemplo, radioterapia, diálisis, etc.
- ❑ **Unidad de Apoyo Diagnóstico:** Unidad clínica donde se realizan los exámenes de laboratorio, radiodiagnóstico, medicina nuclear o cualquier otro tipo de examen que proporcione elementos de juicio para formular el diagnóstico.
- ❑ **Unidad de Apoyo Terapéutico:** Unidad clínica donde se realizan los procedimientos y tratamientos indicados por los facultativos.

Bibliografía

1. Ministerio de Salud (1988). Manual de Procedimientos de la Sección de Orientación Médica y Estadística (SOME)
2. Ministerio de Salud Departamento de Gestión de Procesos (2007). Guías Rápidas de los 56 problemas de salud (56 guías)
3. Decreto Supremo N° 170 del 28/01/2005.
4. Decreto Supremo n° 228 publicado el 30 de Enero del 2006 entró en vigencia el 1° de Julio del 2006
5. Decreto Supremo n° 44, publicado el 09 de Enero del 2007 y que entró en vigencia el 1 de Julio del 2007
6. Decreto Supremo n° 69, publicado 28 de Febrero del 2007,
7. Ministerio de salud, Ordinario 1417 del 30 de Junio 2006
8. Ley N° 18.469
9. Ley n° 19.966
10. Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud
11. Ordinario 1417 del MINSAL del 30 de Junio del 2006
12. Ordinario C26 N° 394 del MINSAL del 01 de Febrero del 2008
13. Ordinario C26 N° 1980 del 12 de Junio del 2008



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Redes Asistenciales
División de Integración de Redes Asistenciales